รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

(Self – Assessment report: SAR)

ประจำปีการศึกษา 2568

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2568 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามองค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ซึ่งพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 4.0 ระดับหลักสูตร

เนื้อหาของรายงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง

และส่วนที่ 4 ภาคผนวก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับนี้ จะเป็นเอกสารสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการเรียนการสอน และส่งเสริมความมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา

(นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล)
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
10 สิงหาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา	2
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)	5
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	6
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO)	7
โครงสร้างหลักสูตร	10
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ CUPT QA ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร	11
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน	12
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร	19
AUN. 1 Expected Learning Outcomes	19
AUN. 2 Programmer Structure and Content	61
AUN. 3 Teaching and Learning Approach	79
AUN. 4 Student Assessment	102
AUN. 5 Academic Staff	113
AUN. 6 Student Support Services	133
AUN. 7 Facilities and Infrastructure	150
AUN. 8 Output and Outcomes	169
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง	192
ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA	193
รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา	198
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	213
รายการหลักฐาน (QR CODE เอกสารหลักฐาน 1-8)	214

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิตเท่ากับ 109 คน อาจารย์ประจำ 42 คน คณาจารย์มีตำแหน่ง ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจำนวน 36 คน

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2553 มีการเรียนการสอนทั้งหมด 17 คณะ 2 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต โดยมีวิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน (University to Create Wisdom for Sustainable Community Development with Innovations of International Standards)

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และชุมชน
3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ปรัชญา

ปญฺญาชีวี เสฏฺฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม) "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"

(A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All)

ปณิธาน

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “(Wisdom of Community Empowerment)”

ปรัชญาการจัดการศึกษา

ประสบการณ์สร้างปัญญา

(True Wisdom Springs From Lived Experiences)

คณะแพทยศาสตร์ มีการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกฉินการแพทย์ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้ได้จำนวนที่เพียงพอและมีคุณภาพ
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับนักศึกษา และจัดการเรียนการสอนนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่ตรงกับความต้องการของประเทศไทย
3. เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้สามารถทำงานร่วมกับชุมชนเป็นที่พึ่งพาของชุมชนในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
5. เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากล และให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน
6. เพื่อพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม และนำไปพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพด้านการแพทย์ ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาระบบสุขภาพของประชาชนกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ที่จะต้องดำเนินการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปรัชญา

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุข แก่มวลมนุษยชาติ

(true success is application of learning to the benefit of mankind)

ปณิธาน

ปัญญาและการอุทิศตนเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน

(Wisdom and dedication for community well being)

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแพทย์ชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิตและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม

พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ที่มีภูมิปัญญา ความเป็นมืออาชีพและมีภาวะผู้นำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2. การสร้างวิจัยและนวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและภายนอกระดับชาติและนานาชาติ
3. ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมโรคซับซ้อนด้วยมาตรฐานสากลและหัวใจความเป็นมนุษย์
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณี
5. บริหารด้านหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม

1. Moral and Integrity (Ethics and transparency)
2. Education and Organization Learning (Visionary Leadership)
3. Data Driven (Management by Fact to success and innovation)
4. Unity (Valuing People)
5. Professionalism (Delivering Value and Results)

วัฒนธรรมองค์กร

สามัคคี มีคุณธรรมนำพา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน	เป็นไปตามเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร	
AUN. 1 Expected Learning Outcomes	ระดับ .....4.....
AUN. 2 Programme Structure and Content	ระดับ .....3.....
AUN. 3 Teaching and Learning Approach	ระดับ .....4.....
AUN. 4 Student Assessment	ระดับ .....4.....
AUN. 5 Academic Staff	ระดับ .....3....
AUN. 6 Student Support Services	ระดับ .....4.....
AUN. 7 Facilities and Infrastructure	ระดับ .....4.....
AUN. 8 Output and Outcomes	ระดับ .....3.....

จุดเด่นของหลักสูตร

1. **บริหารหลักสูตรตามแนวคิด Outcome-Based Education อย่างเป็นระบบ**
   หลักสูตรมีการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) กิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผล รวมทั้งประเมินการบรรลุ PLOs ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนใช้ Comprehensive Examination การประเมินภาคปฏิบัติ และผลจากการฝึกงานประกอบการพิจารณาความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา
2. **จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์จริงและการเรียนรู้เชิงรุก**
   หลักสูตรใช้ Simulation-Based Learning, PBL, CBL, TBL, การสะท้อนผลการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมากกว่า 2,010 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2568 นิสิตผ่านรายวิชาฝึกภาคสนามทั้ง 4 รายวิชา ร้อยละ 100 และผลประเมินรายวิชาอยู่ระหว่าง 4.22–4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00
3. **มีระบบติดตามผลลัพธ์และนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง**
   หลักสูตรติดตามอัตราการสำเร็จการศึกษา การออกกลางคัน ระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ผลสอบใบประกอบวิชาชีพ ภาวะการมีงานทำ การบรรลุ PLOs และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมนำผลเข้าสู่วงจร PDCA และ CQI อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้อัตราการออกกลางคันลดลงจากร้อยละ 33.00 ในปีการศึกษา 2565 เหลือร้อยละ 3.57 ในปีการศึกษา 2568
4. **ผลลัพธ์ของผู้เรียนและบัณฑิตมีแนวโน้มดีขึ้น**
   อัตราการสำเร็จการศึกษาอยู่ระหว่างร้อยละ 96.43–100.00 และใช้เวลาสำเร็จการศึกษาเฉลี่ย 4 ปี ขณะที่อัตราสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเพิ่มจากร้อยละ 23.10 ในปีการศึกษา 2566 เป็นร้อยละ 61.80 ในปีการศึกษา 2568 สะท้อนประสิทธิผลของมาตรการเตรียมความพร้อมและระบบติดตามผู้เรียน
5. **บัณฑิตสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและทำงานตรงสาขา**
   ผลสำรวจบัณฑิตปีการศึกษา 2567 พบว่ามีงานทำภายใน 1 ปีร้อยละ 87.88 และในกลุ่มผู้มีงานทำร้อยละ 96.55 ปฏิบัติงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่สำเร็จการศึกษา แสดงถึงความสอดคล้องของสมรรถนะบัณฑิตกับความต้องการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

6. **มีวัฒนธรรมการวิจัยและใช้การเทียบเคียงเพื่อพัฒนาคุณภาพ**
   หลักสูตรส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์และนิสิต โดยปีการศึกษา 2568 นิสิตจัดทำโครงงานวิจัย 12 เรื่อง และมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนา

1. **ยกระดับผลสอบใบประกอบวิชาชีพให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง**
   แม้อัตราสอบผ่านเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 61.80 แต่ยังมีผู้สอบไม่ผ่านประมาณร้อยละ 38.20 หลักสูตรควรวิเคราะห์ผลสอบจำแนกตามหมวดสมรรถนะ กำหนดเป้าหมายรายปี และจัดระบบเสริมความรู้หรือ Remediation เฉพาะกลุ่ม
2. **พัฒนาระบบติดตามบัณฑิตในระยะยาว**
   ควรติดตามการได้รับใบประกอบวิชาชีพ ตำแหน่งงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การศึกษาต่อ การเปลี่ยนสายงาน และการประกอบอาชีพอิสระอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ผลลัพธ์ระยะยาวประกอบการทบทวนหลักสูตร
3. **บริหารอัตรากำลังและภาระงานอาจารย์ให้สมดุล**
   ข้อมูลในเล่มแสดงว่าภาระงานสอนและบริการวิชาการมีสัดส่วนร้อยละ 71.73 ขณะที่ภาระงานวิจัยมีเพียงร้อยละ 5.36 จึงควรทบทวนการกระจายภาระงาน จัดสรรเวลาสำหรับการวิจัยและพัฒนาอาจารย์ รวมทั้งวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับจำนวนนิสิตและภารกิจของหลักสูตร

ส่วนที่ 1
โครงร่างหลักสูตร
(Program Profile)

ส่วนที่ 1
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบุคลากรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ มีความเป็นผู้นำ ในการบริบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยพร้อมซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.2 ความสำคัญ

ข้อมูลสถิติสาธารณสุข พบว่า สาเหตุการตาย 5 อันดับแรกที่สำคัญตามลำดับ ได้แก่ มะเร็งทุกชนิด โรคหลอดเลือดในสมอง ปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งทางบก เป็นอัตรา 120.3, 47.1, 45.2, 39.4, และ 25.2 ต่อแสนประชากร (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561)

นอกจากนี้จำนวนโรคติดต่อที่เป็นโรคติดเชื้อสูงขึ้น และการบาดเจ็บที่ยังคงมีต่อเนื่อง แต่ไม่สมดุลกับจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ โดยเฉพาะทางด้านฉุกเฉิน ดังรายงานการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ในระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2558 ผู้ใช้บริการ 2,094.55 รายต่อประชากรแสนคน และปี 2560 ผู้ใช้บริการ 2,406.19 รายต่อประชากรแสนคน โดยแนวโน้มสัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต่อ ประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจาก 230.2 ในปี 2558 เป็น 358.4 ในปี 2560 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2562)

พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มีการก่อตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน เป็นแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยม่มาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นและผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการอย่างม่คุณภาพทั่วถึง และเท่าเท่ยม โดยเป็นสังคมแห่งการรอบรู้ และเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การปลูกฝัง และสร้างค่านิยมแก่ภาคประชาสังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแพทย์ฉุกเฉินตามบริบทของประเทศไทยอย่างเหมาะสม 2) การส่งเสริมสนับสนุพัฒนาและจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับบริการทั่วทั้งประเทศให้มีมาตรฐานคุณภาพ และพัฒนาสู่ระดับสากล 3) การพัฒนาและขับเคลื่อนการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

จากข้อมูลแผนพัฒนากำลังคนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี พ.ศ. 2557 พบว่าความต้องการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในระบบจำนวน 5,000 คน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตถึง 20 ปี แต่จากข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2561) พบว่า มีบุคลากรซึ่งเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจำนวน 163 คน เท่านั้น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation) ขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้น

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ที่ดำเนินการ หลักสูตรปริญญา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.3.1 แสดงออกซึ่งจิตอาสาและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

1.3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.3 สามารถปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.3.4 แสดงภาวะผู้นำในการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานบริการ

1.3.5 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

1.3.6 สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Programme Learning Outcomes: PLOs) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยยึดกรอบจากมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่กำหนดมาตรฐานไว้ 6 ด้านและเพิ่มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยาอีกจำนวน 2 ด้านรวมเป็น 8 ด้านได้แก่

PLO.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
(1) แสดงออกซึ่งจิตสำนึกและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(2) แสดงออกซึ่งจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
(3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดำรงตนและการปฏิบัติงานได้
(4) เคารพกฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

PLO.2 ด้านความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1) อธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (2) อธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านฉุกเฉินการแพทย์ สามารถบูรณาการ และประยุกต์กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ (3) อธิบายความรู้ความเข้าใจในคำสั่ง กฎ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ (4) ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความรู้งานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นคว้า กับศาสตร์ด้านฉุกเฉินการแพทย์

PLO.3 ด้านทักษะทางปัญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
(1) แสดงความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ รวมทั้งประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้ (2) แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติการด้านฉุกเฉินการแพทย์ (3) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในการวิเคราะห์และหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย

PLO4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
(1) แสดงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม (2) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน วางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (3) แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) แสดงความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

PLO5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
(1) ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน (2) ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3) แสดงทักษะการเลือกใช้ภาษาและรูปแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

PLO6. ด้านสุนทรียศิลป์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
(1) ประยุกต์ความรู้และคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม กับศาสตร์ที่ศึกษาได้

PLO7. ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
(1) ประยุกต์ความรู้และสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม (2) แสดงบุคลิกภาพตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

PLO8. ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
(1) แสดงทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์ (2) เลือกใช้มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินได้ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน (3) ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4) บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ (5) เลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ)

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 1202

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Emergency Medical Operation)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา	เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.	หลักสูตรตามเกณฑ์ อศป.	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	**ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต**	**30**	**30**
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ			30
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก			-
2. หมวดวิชาเฉพาะ	**ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต**	**104**	**104**
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ		40	40
1.2 กลุ่มวิชาเอก		64	64
3. หมวดวิชาเลือกเสรี	**ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต**	**6**	**6**
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)		-	-
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า	**120 หน่วยกิต**	**140**	**140**

ส่วนที่ 2
ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
สถานที่จัดการเรียนการสอน .....
เกณฑ์การประเมิน ☑ **เกณฑ์ปี 2548** ☑ **เกณฑ์ปี 2558**
ประเภทหลักสูตร (สำหรับเกณฑ์ปี 2558)
☐ **วิชาการ** ☑ **ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ**
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อ	**เกณฑ์การประเมิน**	**ผลการดำเนินงาน หลักสูตร 2559 และ2564**
1	จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เป็นไปตามเกณฑ์
2	คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เป็นไปตามเกณฑ์
3	คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	เป็นไปตามเกณฑ์
4	คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน	เป็นไปตามเกณฑ์
5	คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)	เป็นไปตามเกณฑ์
6	คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	
7	คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)	
8	อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์	
9	คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์	
10	การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา	
11	ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา	
12	การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี	เป็นไปตามเกณฑ์

หมายเหตุ สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12

สรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12

☑ เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์ข้อ 1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

☑ เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการดำเนินการกำกับมาตรฐาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีจำนวน 5 คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา ดังนี้

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร	ตำแหน่งทางวิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	ประเภท <<อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร>>	ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564					
1.นายวงศ์วัฒน์ เตมียบุตร	อ.	ว.ว.	โสต ศอ นาสิกวิทยา	ผู้รับผิดชอบ	√
2.นายวัชเรสร พันธ์พัฒนกุล	อ.	ว.ว.	ประสาทวิทยา	ผู้รับผิดชอบ	√
3.นางสาวอชิรญา ชนะพาล	อ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	√
4.นางสาวทัศนีย์ ศรีโพธิ์	อ.	วท.ม.	กายวิภาคศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	√
5.นายเกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม	อ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบ	√

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร	ตำแหน่งทางวิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	ประเภท <<อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร>>	ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564					
1.นายวงศ์วัฒน์ เตมียบุตร	อ.	ว.ว.	โสต ศอ นาสิกวิทยา	ผู้รับผิดชอบ	√
2.นายวัชเรสร พันธ์พัฒนกุล	อ.	ว.ว.	ประสาทวิทยา	ผู้รับผิดชอบ	√
3.นางสาวอชิรญา ชนะพาล	อ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	√
4.นางสาวทัศนีย์ ศรีโพธิ์	อ.	วท.ม.	กายวิภาคศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	√
5.นายเกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม	อ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบ	√
6.นายสรวิศ บุญญฐี	ผศ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ครอบครัว	อาจารย์ประจำ	√
7.นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์	อาจารย์ประจำ	√
8.นางอรทัย เกตุขาว	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์	อาจารย์ประจำ	√
9.นาสุนันทา วงศ์รัตนกมล	อ.	ปริญญาเอก	พยาบาลศาสตร์	อาจารย์ประจำ	√

ชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร	ตำแหน่งทางวิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	ประเภท <<อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร>>	ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
10.นางสุรางคนา ไชยรินคำ	อ.	ปริญญาเอก	พยาบาลศาสตร์	อาจารย์ประจำ	√

อาจารย์ประจำหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน
(รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ช่วยสอน ล่าสุด ปีการศึกษา 2568)

ชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร	ตำแหน่งทางวิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	ประเภท <<อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร>>	ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564					
1.นายวงศ์วัฒน์ เตมียบุตร	อ.	ว.ว.	โสต ศอ นาสิกวิทยา	ผู้รับผิดชอบ	√
2.นายวัชเรสร พันธ์พัฒนกุล	อ.	ว.ว.	ประสาทวิทยา	ผู้รับผิดชอบ	√
3.นางสาวอชิรญา ชนะพาล	อ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	√
4.นางสาวทัศนีย์ ศรีโพธิ์	อ.	วท.ม.	กายวิภาคศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	√
5.นายเกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม	อ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	ผู้รับผิดชอบ	√
6.นายสรวิศ บุญญฐี	ผศ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ครอบครัว	อาจารย์ประจำ	√
7.นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์	อาจารย์ประจำ	√
8.นางอรทัย เกตุขาว	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์	อาจารย์ประจำ	√
9.นาสุนันทา วงศ์รัตนกมล	อ.	ปริญญาเอก	พยาบาลศาสตร์	อาจารย์ประจำ	√
10.นางสุรางคนา ไชยรินคำ	อ.	ปริญญาเอก	พยาบาลศาสตร์	อาจารย์ประจำ	√

อาจารย์ผู้สอน (อัพเดท อาจารย์ที่สอนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2568)

ชื่ออาจารย์ผู้สอน	ตำแหน่งทางวิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
1.นายวงศ์วัฒน์ เตมียบุตร	อ.	ว.ว.	โสต ศอ นาสิกวิทยา
2.นางอรทัย เกตุขาว	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์
3.นายประจวบ แหลมหลัก	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์
4.นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์
5.นางอุรัชชา สัจจาพงศ์	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์
6.นายสรวิศ บุญญฐี	ผศ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ครอบครัว
7.นางสาวเพ็ญนิภัท นภีรงค์	อ.	ว.ว.	รังสีวิทยาวินิจฉัย
8.นายคามิน สุทธิกุลบุตร	อ.	ว.ว.	อายุรศาสตร์

ชื่ออาจารย์ผู้สอน	ตำแหน่งทางวิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
9.นายกฤติน นาราเวชสกุล	อ.	ว.ว.	ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
10.นายวัชเรสร พันธ์พัฒนกุล	อ.	ว.ว.	ประสาทวิทยา
11.นายภาษา สุขสอน	อ.	ว.ว.	อายุรศาสตร์
12.นางสาวชญานี วิวัฒนเศรษฐ์	อ.	ว.ว.	จักษุวิทยา
13.นางสาวอรอนงค์ มาลา	อ.	ว.ว.	วิสัญญีวิทยา
14.นางสาวเพ็ญพรรณ กัณฑะษา	อ.	ว.ว.	กุมารเวชศาสตร์
15.นายนิติภูมิ สินณฐากร	อ.	ว.ว.	ออร์โธปิดิกส์
16.นางสาวภัทรณี ศรีชัยรัตนกูล	อ.	ว.ว.	วิสัญญีวิทยา
17.นางสาวเบญจวรรณ ตาแก้ว	อ.	ว.ว.	สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
18.นางสาวมัลลิกา ขวัญเมือง	อ.	ว.ว.	อายุรศาสตร์
19.นายดนัยภัทร วงษ์วรศรีโรจน์	อ.	ว.ว.	จักษุวิทยา
20.นางสาวกานต์จิรา ทิตย์สีแสง	อ.	ว.ว.	อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
21.นางสาวณัฐชยา กันทะเสนา	อ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ฟื้นฟู
22.นายสิรวิชญ์ สุนทรชัยยะ	อ.	ว.ว.	โสต ศอ นาสิกวิทยา
23.นายสุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล	อ.	ว.ว.	รังสีวิทยา
24.นางสาวทัศนีย์ ศรีโพธิ์	อ.	ปริญญาโท	กายวิภาคศาสตร์
25.นายวรัญญู เหงี่ยมไพศาล	อ.	ว.ว.	วิสัญญีวิทยา
26.นางสาวอชิรญา ชนะพาล	อ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ป้องกัน
27.นางสุรางคนา ไชยรินคำ	อ.	ปริญญาเอก	พยาบาลศาสตร์
28.นางสาวสุนันทา วงศ์รัตนกมล	อ.	ปริญญาเอก	พยาบาลศาสตร์
29.นางสาวชนกนันท์ เนติศุภลักษณ์	อ.	ว.ว.	เวชศาสตร์ป้องกัน
30.นายพชรพล อุดมลักษณ์	อ.	ว.ว.	ออร์โธปิดิกส์
31.นายวรกันต์ วรธำรงผไท	อ.	ว.ว.	ออร์โธปิดิกส์
32.นางสาวสรัสวดี เถลิงศก	อ.	ว.ว.	กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
33.นางสาวเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์	อ.	ว.ว.	อายุรศาสตร์
34.นายจิรพัฒน์ คล้อยปาน	ผศ.	ปริญญาเอก	Health Sciences
35.นายณรงค์ศักดิ์ มั่นคง	ผศ.	ปร.ด	วิทยาศาสตร์การแพทย์
36.นางรัษฎา ประภาสะวัต	รศ.	Ph.D.	Medical Science
37.นายกฤษฎา สารทอง	ผศ.	ปริญญาโท	กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
38.นายนัฐพล ปันสกุล	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์
39.นางสาวเนตรนภา พรหมมา	ผศ.	ปริญญาตรี	สาธารณสุขศาสตร์
40.นายศราวุฒิ แสงคำ	ผศ.	ปริญญาโท	อนามัยสิ่งแวดล้อม
41.นายมณุเชษฐ์ มะโนธรรม	ผศ.	ปริญญาโท	อาชีวเวชศาสตร์
42.นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล	ผศ.	ปริญญาเอก	Chinese and Western Integrative Medicine
43.นายศักดิ์สิน สิมสินธุ์	อ.	ปริญญาโท	ชีวสถิติ
44.นางสาวปิยะนุช โลนันท์	อ.	ปริญญาโท	การแพทย์แผนจีน
45.นางสาวกิ่งกนก รักษนาเวศ	อ.	ปริญญาโท	กายวิภาคศาสตร์
46.นางสาวตวงพร พิกุลทอง	อ.	ปริญญาโท	สาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์พิเศษ (อัพเดทปีการศึกษา 2568)

ชื่ออาจารย์พิเศษ	ตำแหน่งทางวิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
1.นางรพีพร โรจน์แสงเรือง	อาจารย์พิเศษ	ว.ว.	อายุรศาสตร์
2.นายณัฐกรณ์ สุปรียาพร	อาจารย์พิเศษ	ว.ว	ศัลยศาสตร์
3.นายอนณ ปัญโญใหญ่	อาจารย์พิเศษ	ว.ว	นิติเวชศาสตร์
4.นายพีรณัฐ ผลวิชา	อาจารย์พิเศษ	ว.ว.	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
5.นางสาวกิตติยา ไทยธวัช	อาจารย์พิเศษ	ว.ว.	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
6.นายอุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา	อาจารย์พิเศษ	ว.ว.	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7.นายธนกร ศรีธิยศ	อาจารย์พิเศษ	ว.ว.	กุมารเวชศาสตร์
8.นายณัฐกรณ์ สุปรียาพร	อาจารย์พิเศษ	ว.ว.	ศัลยศาสตร์
9.นางสาวภาวิตา เลาหกุล	อาจารย์พิเศษ	ว.ว.	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
10.นางสาววัชรัญ จิรรัชวาริช	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
11.นายพยนต์ ดวงทิพย์	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	พยาบาล
12.นายอนุรักษ์ ขุนอ้อย	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	พยาบาล
13.นายธานนท์ ยอดยา	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	พยาบาล
14.นายพัชรพล ไผเครือ	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	พยาบาล
15.นางสาวคุณิตา ไชยวงศ์	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
16.นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
17.นายณรงค์ชัย วงค์วาน	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
18.นางสาวพนัชกร สุนันต๊ะ	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
19.นายจิตรติกร ไชยปัดถา	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
20.นายศิวพันธ์ เพชรอุดม	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง

☑ เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการดำเนินการกำกับมาตรฐาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด ทั้ง 5 ท่านเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยที่ทุกท่านมีผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ผลงานเมื่อนับย้อนหลังไป 5 ปี จนถึงปีพุทธศักราช 2566

เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง

☑ เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการดำเนินการกำกับมาตรฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2564 ถึง 2569 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และไม่เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตรอื่นๆ แต่อย่างใด

เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด

☑ เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการดำเนินการกำกับมาตรฐาน

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)

คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

☑ เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการดำเนินการกำกับมาตรฐาน

อาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในปีการศึกษา 2568 มีอาจารย์พิเศษสอนในบางรายวิชา เนื่องจากเป็นหัวข้อเฉพาะด้านและผู้สอนต้องมีความรู้ เฉพาะด้านมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 3 ปี

เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

คณะได้เริ่มดำเนินการเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 ในปีพ.ศ. 2559 ซึ่งหลักสูตรปัจจุบันได้ปรับปรุงตามรอบหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. 2564 นับเป็นการปรับปรุงในรอบที่ 2 ของหลักสูตร

☑ เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการดำเนินการกำกับมาตรฐาน



สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ ข้อ 1-5 และข้อ12

☑ เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ

☐ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ.....

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร

AUN - QA criterion 1 Expected Learning Outcomes

Sub Criterion 1

1. The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.
2. The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.
3. The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline).
4. The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes.
5. The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate.

ผลการดำเนินงาน

1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.

การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตรและมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของสถาบัน

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้คำกริยาที่สามารถวัดและประเมินผลได้ (measurable action verbs) และอ้างอิง Revised Bloom's Taxonomy ครอบคลุมทั้งด้าน Cognitive, Psychomotor และ Affective domains เพื่อสะท้อนสมรรถนะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2564) มาจาก



ภาพที่ 1.1-1 แสดงกระบวนการออกแบบ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ในปีการศึกษา 2568 คณะฯ ได้จัดการการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4

ในการออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้ดำเนินการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการกำหนดผลการเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes: ELOs) ที่ชัดเจน

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรยึดตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ซึ่งกำหนดสมรรถนะวิชาชีพไว้ 6 ด้าน และเพิ่มเติมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยาอีก 2 ด้าน รวมเป็นทั้งหมด 8 ด้าน เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะเชิงสังคมที่เหมาะสมต่อบริบทการทำงานในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ความต้องการของระบบบริการสุขภาพ แนวโน้มสถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบัน และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น ส่วนใหญ่มาจากการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การใช้แบบสอบถามและแบบประเมินที่มุ่งวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Focus Group Discussion) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร อาจารย์ประจำแหล่งฝึก หรือผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มุมมองที่หลากหลาย นำไปสู่การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแบบประเมิน โดยเพิ่มความชัดเจนของคำถาม และเสริมคำถามปลายเปิด เพื่อกระตุ้นให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นที่ลึกซึ้งและหลากหลายได้มากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การเก็บข้อมูลและประมวลผลสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มีความสอดคล้องอย่างเคร่งครัดกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และข้อบังคับของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา หรือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ พ.ศ. 2554 สำหรับหลักสูตรปี พ.ศ. 2559 รวมถึงมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2565 สำหรับหลักสูตรปี พ.ศ. 2564 และการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ (อศป.) เพื่อรับรองความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

การได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกระบวนการดังกล่าว ทำให้ข้อมูลมีความครบถ้วน สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้กำหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม โดยหลังจากการประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะและระดับความพึงพอใจของนิสิตและแหล่งฝึกปฏิบัติงานแล้ว สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้วางแผนปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ตารางที่ 1.1-1 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Requirements)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	วิธีการเก็บข้อมูล	ประเด็นความต้องการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
ผู้ใช้บัณฑิต	แบบประเมินความพึงพอใจ การสัมภาษณ์ และการประชุมร่วมกับหน่วยงาน	ต้องการบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางคลินิกสูง สามารถดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ศิษย์เก่า	การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และแบบสอบถามออนไลน์	ต้องการทักษะการเป็นผู้นำ การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
แหล่งฝึกปฏิบัติ	แบบประเมินการฝึกปฏิบัติและการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำแหล่งฝึก	ต้องการนิสิตที่มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม สื่อสารได้ดี และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
นิสิต	แบบประเมินรายวิชา การสะท้อนความคิดเห็น และการประชุมระหว่างอาจารย์กับนิสิต	ต้องการการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Hands-on Learning) การใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) และการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติจริง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และองค์กรวิชาชีพ	มาตรฐานวิชาชีพ เกณฑ์รับรองหลักสูตร และข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการวิชาชีพ	ต้องการให้บัณฑิตมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ทั้งด้าน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	วิธีการเก็บข้อมูล	ประเด็นความต้องการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
		ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และการปฏิบัติงานภาคสนาม

ในด้านการตั้งผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี (Yearly Learning Outcomes) สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- **เมื่อจบชั้นปีที่ 1**

นิสิตต้องมีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย์ฉุกเฉิน และสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในการเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (First Responder) ได้อย่างเหมาะสม

- **เมื่อจบชั้นปีที่ 2**

นิสิตต้องสามารถประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน และปฏิบัติหัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ รวมถึงมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Technician: EMT)

- **เมื่อจบชั้นปีที่ 3**

นิสิตต้องสามารถประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำ และปฏิบัติหัตถการขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสามารถปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced EMT) ได้

- **เมื่อจบชั้นปีที่ 4**

นิสิตต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งในสถานที่เกิดเหตุและในสถานพยาบาลอย่างมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ได้อย่างเต็มศักยภาพ

การดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ทำให้หลักสูตรมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ ทักษะ คุณธรรม และความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตรงตามความคาดหวังของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และความต้องการของสังคมโดยรวม

ตารางที่ 1.1-2 PLO Progression by Year

ชั้นปี	PLO ที่เน้น
ปี 1	PLO1,2
ปี 2	PLO2,3
ปี 3	PLO2,3,4,5
ปี 4	PLO1–8

หลักสูตรได้ปรับปรุงถ้อยคำของผลลัพธ์การเรียนรู้โดยเลือกใช้คำกริยาที่สามารถวัดและประเมินผลได้ เช่น อธิบาย (Explain), ประยุกต์ใช้ (Apply), วิเคราะห์ (Analyze), ประเมิน (Evaluate) และสร้างสรรค์ (Create) เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes: PLOs) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยยึดกรอบจากมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่กำหนดมาตรฐานไว้ 6 ด้านและเพิ่มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยาอีกจำนวน 2 ด้านรวมเป็น 8 ด้านได้แก่

PLO.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม

(1) แสดงออกซึ่งจิตสำนึกและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(2) แสดงออกซึ่งจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม

(3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งในการดำรงตนและการปฏิบัติงานได้

(4) เคารพกฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

PLO.2 ด้านความรู้

(1) อธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) อธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านฉุกเฉินการแพทย์ สามารถบูรณาการและประยุกต์กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ

(3) อธิบายความรู้ความเข้าใจในคำสั่ง กฎ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์

(4) ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความรู้งานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นคว้า กับศาสตร์ด้านฉุกเฉินการแพทย์

PLO.3 ด้านทักษะทางปัญญา

(1) แสดงความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ รวมทั้งประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้

(2) แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติการด้านฉุกเฉินการแพทย์

(3) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในการวิเคราะห์และหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย

PLO4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(1) แสดงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

(2) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน วางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

(3) แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) แสดงความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

PLO5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน

(2) ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

(3) แสดงทักษะการเลือกใช้ภาษาและรูปแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

PLO6. ด้านสุนทรียศิลป์

(1) ประยุกต์ความรู้และคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม กับศาสตร์ที่ศึกษาได้

PLO7. ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ

(1) ประยุกต์ความรู้และสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

(2) แสดงบุคลิกภาพตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

PLO8. ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ

(1) แสดงทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์

(2) เลือกใช้มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินได้ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน

(3) ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้

(5) เลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตารางที่ 1.1-3 ช่องทางการสื่อสาร PLOs

Stakeholder	ช่องทางการสื่อสาร
อาจารย์	ประชุมหลักสูตร
นิสิต	ปฐมนิเทศ / มคอ.3

Stakeholder	ช่องทางการสื่อสาร
แหล่งฝึก	คู่มือฝึกปฏิบัติ
ผู้ใช้บัณฑิต	เว็บไซต์ / stakeholder meeting
ผู้สมัครเรียน	เว็บไซต์คณะ/ facebook page MED-UP และ Paramedic UP

หลักสูตรมีการสื่อสารผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมหลักสูตร การปฐมนิเทศ การจัดทำ มคอ.3 คู่มือฝึกปฏิบัติ เว็บไซต์ของคณะ และการประชุมร่วมกับแหล่งฝึกและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เข้าใจ และสามารถนำผลลัพธ์การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกัน

จากการพัฒนาหลักสูตร คณะฯ ดำเนินการตามภาพที่ 1.1-1 เมื่อหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว การดำเนินการถ่ายทอดหลักสูตรสู่การปฏิบัติจะดำเนินไปอย่างรอบคอบ โดยกระบวนการนี้จะครอบคลุมการสื่อสารหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้สอน ผู้เรียน ไปจนถึงผู้ใช้บัณฑิต และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการดำเนินการดังนี้

- **การออกแบบหลักสูตร** การออกแบบหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จะมุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาทางการแพทย์ที่ทันสมัยและตรงตามมาตรฐานที่รับรอง โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะคำนึงถึงความต้องการของสังคมและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้หลักสูตรตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- **การรับรองหลักสูตร** หลังจากการออกแบบหลักสูตรเสร็จสิ้น หลักสูตรจะได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและอบรมผู้ปฏิบัติการ (อศป.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรมีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
- **การส่งมอบหลักสูตร** เมื่อหลักสูตรได้รับการรับรองแล้วคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะส่งมอบหลักสูตรไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดำเนินการสื่อสารต่อไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ
- **การสื่อสารสู่ผู้สอน** คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้แทนจากทุกภาควิชา จะทำการสื่อสารหลักสูตรไปยังผู้สอนแบบ Top-Down โดยเริ่มจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนในรายวิชา รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ผู้สอนทุกคนเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการถ่ายทอดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **การสื่อสารสู่ผู้เรียน** การสื่อสารกับผู้เรียนจะเริ่มต้นด้วยการปฐมนิเทศในช่วงแรกของการรับสมัคร รวมถึงการจัดการปฐมนิเทศรายวิชาเพื่อแนะนำหลักสูตรและวิธีการเรียนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้รับคู่มือรายวิชาที่มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียน

- **การสื่อสารกับลูกค้าในอนาคต** การสื่อสารกับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในอนาคตจะทำผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับหลักสูตร การสมัครเรียน และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- **การสื่อสารกับผู้ใช้บัณฑิต** เว็บไซต์ของคณะฯ จะเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างบัณฑิตกับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการจ้างงานหรือใช้บริการจากบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถตามมาตรฐาน
- **การสื่อสารกับมหาวิทยาลัยและองค์กรรับรอง** คณะฯ จะจัดการประชุมเพื่อการนำเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและอบรมผู้ปฏิบัติการ (อศป.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่านการประชุมเพื่อการพิจารณาและเสนอหลักสูตรตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ได้การรับรองและคำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- **การปรับปรุงหลักสูตร** หลังจากหลักสูตรได้เริ่มดำเนินการแล้ว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะทำการประเมินผลการเรียนรู้และการปฏิบัติการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย รวมถึงการปรับเนื้อหาหรือวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในวงการแพทย์ฉุกเฉินและความต้องการของผู้เรียน

ด้วยกระบวนการที่มีความเป็นระบบและการสื่อสารที่ชัดเจนในทุกขั้นตอนนี้ หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ตารางที่ 1.1-4 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านอย่างเป็นระบบ

ประเด็น	รายละเอียด
การกำหนดผลการเรียนรู้ (PLOs)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน รวม 8 ด้าน (PLO1–PLO8) ครอบคลุมทั้งคุณลักษณะตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (6 ด้าน) และเพิ่มเติมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (2 ด้าน)
กรอบอ้างอิงมาตรฐาน	1. มาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (สพฉ.) พ.ศ.2559 2. เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ.2565 3. ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยการรับรององค์กร/หลักสูตร พ.ศ.2554
ความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์-พันธกิจ	- วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม นำความรู้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม - พันธกิจเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพเชิงวิชาการ วิชาชีพ และสังคม ⇒ PLO1 (คุณธรรมจริยธรรม), PLO2 (ความรู้), PLO3 (ทักษะปัญญา), และ PLO8 (ปฏิบัติวิชาชีพ) สอดคล้องชัดเจน

การพัฒนาผลการเรียนรู้ (PLOs)	ใช้การสำรวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิตปีสุดท้าย อาจารย์ประจำแหล่งฝึก และผู้ใช้บัณฑิต ผ่านแบบสอบถามและแบบประเมินออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมปรับปรุงแบบประเมินให้ตรงประเด็นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเชิงลึกด้วยคำถามปลายเปิด
กระบวนการเก็บข้อมูลและประมวลผล	พัฒนาระบบประเมินออนไลน์เพื่อการเข้าถึงง่ายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็ว แม่นยำ นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 เพื่อปรับปรุงให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น
การตั้งผลลัพธ์รายชั้นปี	- ปี 1: ความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ⟶ เป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ - ปี 2: ประเมินและปฏิบัติหัตถการพื้นฐาน ⟶ เป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ - ปี 3: หัตถการขั้นสูง ⟶ เป็นเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ - ปี 4: ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะครบวงจร ⟶ เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ตารางที่ 1.1-5 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรตามชั้นปี (PLO Progression by Year)

ชั้นปี	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ที่มุ่งเน้น
ชั้นปีที่ 1	PLO1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ PLO2 ด้านความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ชั้นปีที่ 2	PLO2 ด้านความรู้ และ PLO3 ด้านทักษะทางปัญญาและการวิเคราะห์สถานการณ์
ชั้นปีที่ 3	PLO2 ด้านความรู้, PLO3 ด้านทักษะทางปัญญา, PLO4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและภาวะผู้นำ และ PLO5 ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นปีที่ 4	พัฒนาครบทุกด้านของ PLO1–PLO8 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์อย่างสมบูรณ์

ตารางที่ 1.1-6 การเชื่อมโยง PLO กับวิธีประเมินผล

PLO	วิธีประเมินหลัก
PLO1	การประเมินพฤติกรรมวิชาชีพ
PLO2	OSCE / การประเมินภาคปฏิบัติ
PLO3	Simulation / Case study
PLO4	Team-based assessment
PLO5	งานวิจัย / Assignment
PLO8	Clinical competency assessment

ตารางที่ 1.1-7 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรและความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ฯ ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ลำดับ	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร : PLOs	ความเชื่อมโยงกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร			
		เอกลักษณ์ มพ.	อัตลักษณ์ มพ.	มคอ. 1	คณะ
1	คุณธรรมจริยธรรม	√	√		√
2	ความรู้	√	√		√
3	ทักษะทางปัญญา	√	√		√
4	ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	√	√		√
5	ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	√			√
6	สุนทรียศิลป์	√	√		√
7	ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ	√	√	√	√
8	ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ	√		√	√

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.

หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยถูกออกแบบมาและได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

ผลการดำเนินงาน:

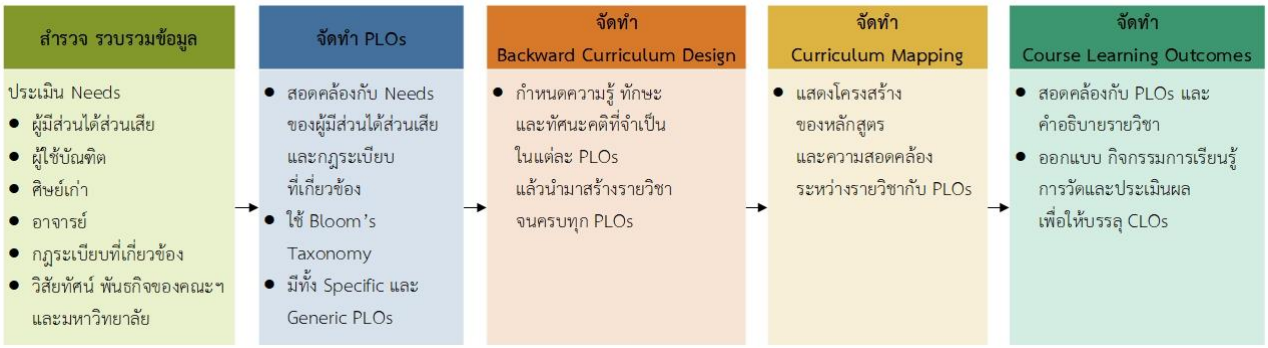
หลักสูตรการศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร โดยมีการออกแบบที่เน้นการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ลงในแต่ละรายวิชา ซึ่งในกระบวนการนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้าน โดยใช้แนวคิดการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward Curriculum Design) เพื่อให้มั่นใจว่านิสิตจะบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หลักสูตรกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยออกแบบให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และใช้คำกริยาที่สามารถวัดและประเมินผลได้ตาม Revised Bloom's Taxonomy เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลได้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ

เมื่อได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้าน (TQF) ทั้ง 8 ด้านแล้ว หลักสูตรได้มีการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ไปยังรายวิชาต่าง ๆ โดยใช้แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (Curriculum Mapping) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนจะบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังได้อย่างครบถ้วน

ในกระบวนการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนจะถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยทุกๆ รายวิชาจะรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (LO) อย่างน้อย 4 ด้านตามความเหมาะสมของลักษณะวิชานั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา หลักการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน จะรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 7 ด้าน โดยปรับข้อย่อยในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับลักษณะของวิชานั้น ๆ เพื่อให้นิสิตสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 1.2 แสดงการถ่ายทอด PLOs ลงสู่ CLOs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564



หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้รับการพัฒนาภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs)

เมื่อได้กำหนด PLOs แล้ว ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด Backward Curriculum Design โดยมีการกำหนดองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะจำเพาะและทั่วไป (Specific Skills และ Generic Skills) และทัศนคติ (Attitude/Affection) ซึ่งได้รับการร้อยเรียงอย่างมีระบบและสอดคล้องกัน เพื่อสร้างรายวิชาที่สามารถผลักดันให้นิสิตไปสู่การบรรลุเป้าหมาย PLOs ได้อย่างครบถ้วน

ต่อจากนั้น ได้มีการจัดทำ Curriculum Mapping เพื่อแสดงโครงสร้างหลักสูตรโดยรวม และแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับ PLOs ของหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายวิชาในหลักสูตรมีบทบาทในการสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรตามที่กำหนด หลักสูตรได้ดำเนินการตรวจสอบความครอบคลุมของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรในทุกรายวิชา เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกข้อได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม และไม่มีช่องว่างของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สำคัญต่อสมรรถนะวิชาชีพ ได้ดำเนินการทบทวนความครอบคลุมของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรในทุกหมวดรายวิชา เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนและลดช่องว่างของผลลัพธ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งกำหนดลำดับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเหมาะสมในแต่ละชั้นปี

ในขั้นตอนถัดมา ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ดำเนินการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) ในการออกแบบรายวิชา หลักสูตรใช้แนวคิด Constructive Alignment โดยเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) กิจกรรมการเรียนรู้ (Teaching and Learning Activities) และวิธีการประเมินผล (Assessment Methods) เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนสามารถสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง PLOs ของหลักสูตรกับเนื้อหาคำอธิบายรายวิชา จากนั้นกำหนด CLOs ให้ชัดเจน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งการวัดและประเมินผล เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถนำไปสู่การบรรลุ CLOs ได้ครบถ้วนในทุกข้อ ดังแสดงใน ภาพที่ 1.2 ซึ่งแสดงกระบวนการออกแบบ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และการปรับปรุงหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรได้ทบทวนถ้อยคำของ CLOs ให้มีความชัดเจน กระชับ และสามารถวัดผลได้ โดยเลือกใช้คำกริยาที่สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สังเกตและประเมินผลได้ เช่น อธิบาย วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ ประเมิน และปฏิบัติ ตามระดับการเรียนรู้ของ Revised Bloom’s Taxonomy

หลักสูตรออกแบบการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้แบบลำดับขั้น (Progressive Learning) โดยเริ่มจากการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานในชั้นปีต้น และเพิ่มระดับความซับซ้อนของการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจทางคลินิก การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และภาวะผู้นำในชั้นปีที่สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรเมื่อสำเร็จการศึกษา

ตัวอย่างการกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs ลงสู่ CLOs ของรายวิชา ตัวอย่าง แสดงดัง ตารางที่ 1.2-1

ตารางที่ 1.2-1 ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

รายวิชา	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	PLO ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน	✓	✓	✓	✓	PLO1,2,3,4,8
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)	✓	✓	✓	✓	PLO1,2,4,5,8
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical System)	✓	✓	✓	✓	PLO1,2,3,4,5
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1 (Emergency Medical Care I)	✓	✓	✓	✓	PLO1,2,3,4,8
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced Life Support)	✓	✓	✓	✓	PLO1,2,3,4,5,8

รายวิชา	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	PLO ที่เกี่ยวข้อง
การจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Simulation for Emergency Operations)	✓	✓	✓	✓	PLO1–8

คำอธิบายเพิ่มเติม

CLO คำอธิบาย

CLO1, อธิบาย ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

CLO2, วิเคราะห์ สถานการณ์ฉุกเฉิน ตัดสินใจทางคลินิก และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

CLO3, ปฏิบัติ การช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างปลอดภัย

CLO4, สื่อสาร ทำงานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นำ และปฏิบัติตนตามหลักวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

จากการวิเคราะห์ Curriculum Mapping พบว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกข้อได้รับการสนับสนุนผ่านรายวิชาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร โดยมีการกระจายผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการเรียนรู้จากระดับพื้นฐานสู่ระดับขั้นสูง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสำเร็จการศึกษา

ตารางที่ 1.2-2 การเชื่อมโยง CLO กับกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล

CLO	กิจกรรมการเรียนรู้	วิธีประเมิน
CLO1	Lecture / Discussion	Written examination
CLO2	Case-based learning	Case analysis
CLO3	Simulation / Skill lab	OSCE
CLO4	Team-based learning	Group assessment

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลในแต่ละรายวิชามีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผ่านการใช้กรณีศึกษา การจำลองสถานการณ์ (Simulation) การสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) และการประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติงานจริง

หลักสูตรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายทั้งการสอบข้อเขียน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) การประเมินจากสถานการณ์จำลอง การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติงานจริง และการสะท้อนผลการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ

ตารางที่ 1.2-3 ตารางการกระจายความรับผิดชอบของ LO หลักสูตรและ LO รายวิชาปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน

ผลการเรียนรู้หลักสูตร	ผลการเรียนรู้หลักสูตร (PLO หลักสูตร)	CLO รายวิชาปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน
1. คุณธรรม จริยธรรม	(1) แสดงออกซึ่งจิตสำนึกและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	นิสิตสามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยจิตสำนึกทางสังคม โดยปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการให้การดูแลผู้ป่วย
	(2) แสดงออกซึ่งจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม	นิสิตแสดงความมีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถทำงานร่วมกับทีมแพทย์และบุคลากรอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
	(3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งในการดำรงตนและการปฏิบัติงานได้	นิสิตสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเคารพกฎหมายสิทธิของผู้อื่น
	(4) เคารพกฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	นิสิตแสดงความเคารพกฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. ความรู้	(2) อธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านฉุกเฉินการแพทย์ สามารถบูรณาการและประยุกต์กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ	นิสิตสามารถอธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านฉุกเฉินการแพทย์และบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ เช่น การประเมินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน
	(4) ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความรู้งานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นคว้า กับศาสตร์ด้านฉุกเฉินการแพทย์	นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับในหลักสูตรและงานวิจัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยและพัฒนากระบวนการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
3. ทักษะทางปัญญา	(1) แสดงความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ รวมทั้งประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้	นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลและประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินในเบื้องต้น โดยใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
	(2) แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติการด้านฉุกเฉินการแพทย์	นิสิตแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาผู้ป่วย

	(3) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในการวิเคราะห์และหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย	นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	(1) แสดงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม	นิสิตสามารถแสดงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม
	(2) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน วางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	นิสิตแสดงภาวะผู้นำในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
	(3) แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นิสิตแสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(4) แสดงความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	นิสิตแสดงความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
6. สุนทรียภาพ	(1) ประยุกต์ความรู้และคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม กับศาสตร์ที่ศึกษาได้	นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการใช้แนวทางศิลปะในการบรรเทาความเครียดและความวิตกกังวลของผู้ป่วย
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ	(1) ประยุกต์ความรู้และสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม	นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ฉุกเฉิน
	(2) แสดงบุคลิกภาพตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม	นิสิตสามารถแสดงบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในการทำงานในภาวะฉุกเฉิน
8. ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ	(1) แสดงทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์	นิสิตสามารถปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	(2) เลือกใช้มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินได้ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน	นิสิตสามารถเลือกและนำมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในระดับบุคคลและชุมชนมาใช้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
	(3) ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	นิสิตสามารถปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
	(4) บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้	นิสิตสามารถบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
	(5) เลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	นิสิตสามารถใช้ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้ตรรกะ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุง CLOs กิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อมูลจากผลการประเมินรายวิชา การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง Continuous Quality Improvement (CQI)

จากกระบวนการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาอย่างเป็นระบบ หลักสูตรสามารถแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ได้รับการกำหนดอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลอย่างชัดเจน ซึ่งสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา และสะท้อนแนวทางการจัดการศึกษาตาม Outcome-Based Education (OBE)

ตารางที่ 1.2-3 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรและความสอดคล้องกับ Bloom's Taxonomy และความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ฯ ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ลำดับ	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร : PLOs	Generic	Specific	ความเชื่อมโยงกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร				Bloom's Taxonomy (Revised)			Bloom's Taxonomy (Revised)
		Leaning Outcome	Leaning Outcome	เอกลักษณ์ มพ.	อัตลักษณ์ มพ.	มคอ. 1	คณะ	Cognitive Domain (Knowledge)	Psychomotor Domain (Skills)	Affective Domain (Attitude)	
1	คุณธรรมจริยธรรม	√		√	√		√	√		√	Remember, Understand, Apply
2	ความรู้		√	√	√		√	√			Remember, Understand, Apply
3	ทักษะทางปัญญา	√		√	√		√	√	√		Analyze, Evaluate, Create
4	ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	√		√	√		√		√	√	Apply, Analyze
5	ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	√		√			√	√	√		Apply, Evaluate
6	สุนทรียศิลป์	√		√	√		√			√	Understand, Apply

7	ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ	√		√	√	√	√	√	√		Apply, Create
8	ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ		√	√		√	√	√	√		Apply, Analyze, Create

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรของหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ประกอบด้วยทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป (Generic Learning Outcomes) และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา (Discipline-specific Learning Outcomes) โดยผลลัพธ์ทั่วไปครอบคลุมด้านคุณธรรมจริยธรรม การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะที่ผลลัพธ์เฉพาะสาขาวิชามุ่งเน้นสมรรถนะด้านการประเมิน การดูแลรักษา และการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมินรายวิชา ผลการประเมินการฝึกปฏิบัติ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลอย่างเหมาะสม

หลักสูตรใช้กระบวนการ Continuous Quality Improvement (CQI) ในการทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ผลการประเมินผู้เรียนและผลการฝึกปฏิบัติ การประชุมทบทวนหลักสูตร และการนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ รายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลในรอบการปรับปรุงหลักสูตรถัดไป

จากกระบวนการกำหนด พัฒนา ถ่ายทอด และประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างเป็นระบบ หลักสูตรสามารถแสดงให้เห็นว่า PLOs ได้รับการออกแบบตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ Revised Bloom's Taxonomy มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย มาตรฐานวิชาชีพ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงได้รับการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline).

หลักสูตรแสดงให้เห็นถึง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั่วไป (ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารทั้งด้านการเขียนและการพูด ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะการทำงานเป็นทีม ฯลฯ) และผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะ เฉพาะของสาขาวิชา)

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) รวม 8 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยครอบคลุมทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง ของหลักสูตร (Specific Learning Outcomes) และผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป (Generic Learning Outcomes)

หลักสูตรได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยครอบคลุมทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป (Generic

Learning Outcomes) และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา (Discipline-specific Learning Outcomes) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้:

ตารางที่ 1.3-1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั่วไป และเฉพาะทาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ลำดับ	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	Generic Learning Outcome	Specific Learning Outcome
1	**PLO1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม** (1) แสดงออกซึ่งจิตสำนึกและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (2) แสดงออกซึ่งจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม (3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งในการดำรงตนและการปฏิบัติงานได้ (4) เคารพกฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	√	
2	**PLO2 ด้านความรู้** (1) อธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (2) อธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านฉุกเฉินการแพทย์ สามารถบูรณาการและประยุกต์กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ (3) อธิบายความรู้ความเข้าใจในคำสั่ง กฎ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ (4) ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความรู้งานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นคว้า กับศาสตร์ด้านฉุกเฉินการแพทย์		√
3	**PLO3 ด้านทักษะทางปัญญา** (1) แสดงความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ รวมทั้งประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้ (2) แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติการด้านฉุกเฉินการแพทย์	√	

	(3) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในการวิเคราะห์และหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย		
4	**PLO4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ** (1) แสดงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม (2) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน วางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (3) แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) แสดงความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	√	
5	**PLO5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ** (1) ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน (2) ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3) แสดงทักษะการเลือกใช้ภาษาและรูปแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้	√	
6	**PLO6 ด้านสุนทรียศิลป์** (1) ประยุกต์ความรู้และคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม กับศาสตร์ที่ศึกษาได้	√	
7	**PLO7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ** (1) ประยุกต์ความรู้และสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม (2) แสดงบุคลิกภาพตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม	√	
8	**PLO8 ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ** (1) แสดงทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์ (2) เลือกใช้มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินได้ทั้งใน		√

	ระดับบุคคลและชุมชน (3) ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4) บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ (5) เลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต		

ในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพ การปฏิบัติหัตถการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการตัดสินใจทางคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไปของหลักสูตรครอบคลุมทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในบริบทของระบบสุขภาพปัจจุบัน

ตารางที่ 1.3-2 การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไปและเฉพาะสาขาวิชากับรายวิชา

รายวิชา	**ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป**	**ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา**
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม	สมรรถนะด้าน BLS
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ภาวะผู้นำ การแก้ปัญหา	การบริหารจัดการระบบ EMS
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1	การสื่อสาร	การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ	สมรรถนะด้าน ALS
การจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน	การจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน การทำงานเป็นทีมและการคิดวิเคราะห์	การตัดสินใจทางคลินิก

หลักสูตรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสอบข้อเขียน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) การประเมินจากสถานการณ์จำลอง (Simulation) การประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติงานจริง และการประเมินจากผลงานของผู้เรียน เพื่อให้สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ

หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมินผู้เรียน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง

จากการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรอย่างเป็นระบบ หลักสูตรสามารถแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ครอบคลุมทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไปและผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริบทของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพในอนาคต

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that these are reftected in the expected learning outcomes.

หลักสูตรแสดงให้เห็นถึง กระบวนการรวบรวมข้อกำหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มาประกอบการจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรได้กำหนดกระบวนการรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดและทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยมุ่งเน้นให้ผลลัพธ์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงาน และบริบทของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

กระบวนการรวบรวมข้อกำหนดและความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Stakeholders)

หลักสูตรได้เริ่มต้นการรวบรวมข้อกำหนดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโดยการสำรวจความคิดเห็นจากนิสิตปัจจุบันผ่าน Google Form ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากมุมมองของผู้เรียนเอง การสำรวจนี้ช่วยให้คณะสามารถเห็นถึงความต้องการและความคาดหวังของนิสิตในเรื่องของเนื้อหาวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัย

นอกจากนั้น อาจารย์ผู้สอนก็มีส่วนสำคัญในการรวบรวมข้อกำหนดและข้อเสนอแนะผ่านการประชุมร่วมกัน โดยคณาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะอย่างละเอียดและครอบคลุม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholders)

กระบวนการรวบรวมข้อกำหนดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกถูกดำเนินการด้วยการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต เช่น โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการจ้างบัณฑิตของหลักสูตร ผ่าน Google Form การสำรวจนี้ช่วยให้คณะได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพและความสามารถที่ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวังจากผู้ที่จบการศึกษา โดยเฉพาะในด้านความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานการณ์จริง

การสำรวจจากศิษย์เก่าก็มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อกำหนดและความคิดเห็น โดยมีการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายหรือการจัดกิจกรรมที่ทำให้ศิษย์เก่าสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะและความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร รวมทั้งการประเมินผลว่าหลักสูตรช่วยให้บัณฑิตพร้อมสำหรับการทำงานในส่วนงานการแพทย์ฉุกเฉินได้ดีและมีประสิทธิภาพหรือไม่

หลักสูตรให้ความสำคัญกับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต แหล่งฝึกปฏิบัติ และองค์กรวิชาชีพ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สะท้อนความต้องการของวิชาชีพและตลาดแรงงานโดยตรง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 1.4-1 วิธีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	วิธีการรวบรวมข้อมูล
นิสิต	แบบสอบถามออนไลน์ / การสะท้อนความคิดเห็น
อาจารย์	การประชุมหลักสูตร
ศิษย์เก่า	แบบสอบถาม
ผู้ใช้บัณฑิต	แบบประเมินความพึงพอใจ
แหล่งฝึก	การประชุมร่วม / Practicum feedback/นิเทศน์แหล่งฝึก
องค์กรวิชาชีพ	มาตรฐานวิชาชีพ / ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ตารางที่ 1.4-2 ประเด็นความต้องการสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการสำคัญ
ผู้ใช้บัณฑิต	ต้องการบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางคลินิก สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศิษย์เก่า	ต้องการทักษะภาวะผู้นำและสมรรถนะด้านการจัดการสาธารณภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน
นิสิต	ต้องการการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง และการเรียนผ่านสถานการณ์จำลอง (Simulation)
แหล่งฝึกปฏิบัติ	ต้องการนิสิตที่มีความเป็นวิชาชีพ มีทักษะการสื่อสาร และสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมได้
องค์กรวิชาชีพ	ต้องการบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าความต้องการส่วนใหญ่สะท้อนถึงความสำคัญของสมรรถนะด้านการปฏิบัติการทางคลินิก การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งถูกนำมาบูรณาการในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) อย่างชัดเจน

กระบวนการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs)

เมื่อข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกได้รับการรวบรวมอย่างครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการกำหนดทิศทางของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการที่ได้รวบรวมมา กระบวนการพัฒนาผลการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นักวิชาการ และผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้มีความสมบูรณ์และตรงกับความต้องการที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

กระบวนการวิพากษ์นี้เป็นส่วนสำคัญในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยใช้หลักการของการประเมินที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลัก (Outcome-Based Education: OBE) ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรสามารถตอบสนองความคาดหวังของทั้งผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในหลักสูตรนี้จะดำเนินการในรอบระยะเวลา 5 ปี โดยในทุกๆ รอบจะมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตามข้อมูลที่รวบรวมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการพัฒนาทักษะต่างๆ ของบัณฑิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติการในภาคการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองในสายงานวิชาชีพต่อไป

ตารางที่ 1.4-2 การถ่ายทอดความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายในและภายนอกสถาบันแต่ละกลุ่มเข้าสู่ PLOs ของหลักสูตร)

ลำดับ	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร : PLOs	เอกลักษณ์ มพ.	อัตลักษณ์บัณฑิต มพ	มคอ. 1 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	จุดมุ่งหมายของคณะแพทยศาสตร์	ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)					ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)
						นิสิต	อาจารย์	ศิษย์เก่า	ผู้ปกครองนิสิต	ผู้ใช้บัณฑิต	
1	คุณธรรม จริยธรรม	●		●	●	√	√	√	√	√	ต้องการบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตสาธารณะ กล้าแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์
2	ความรู้	●		●	●	√	√	√	√	√	ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการแพทย์

											ฉุกเฉินและประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
3	ทักษะทางปัญญา	●		●	●	√	√	√	√	√	ต้องการบัณฑิตที่มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
4	ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	●		●	●	√	√	√	√	√	ต้องการบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ ร่วมงานสหสาขาวิชาชีพ สื่อสารกับทีมและผู้รับบริการได้
5	ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	●			●		√	√	√	√	ต้องการบัณฑิตที่มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะ 3R และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
6	สุนทรียศิลป์	●	●		●		√	√		√	ต้องการบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและสุนทรียะในชีวิต สร้างความสมดุลของชีวิตการทำงาน
7	ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ	●	●	●	●	√	√	√		√	ต้องการบัณฑิตที่ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาบุคลิกภาพตนเอง มีร่างกายที่แข็งแรง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8	ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ	●		●	●	√	√	√	√	√	ต้องการบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

หลักสูตรมีการทบทวนข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทาง Continuous Quality Improvement (CQI)

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate.

หลักสูตรแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเมื่อสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรดำเนินการติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) อย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถบรรลุสมรรถนะที่กำหนดไว้เมื่อสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Programme Learning Outcomes: PLOs) ภายในระยะเวลาการศึกษาที่กำหนด ดังนี้

1. ระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตร

หลักสูตรมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด

2. การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักสูตรได้รับการปรับปรุงโดยอ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ได้แก่ นิสิต อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. การทบทวนและวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ก่อนเปิดภาคการศึกษามีการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ของหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) และผลการประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนใน

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4. การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรสู่รายวิชา

มีการกระจายผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรในภาพรวม ทั้งนี้มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ Sub-PLOs ผ่านการวัดผลในรายวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

5. การประเมินและติดตามผลการเรียนรู้

หลักสูตรมีระบบการประเมินและติดตามผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการดังนี้

- กำกับและติดตามกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
- วิพากษ์ข้อสอบ ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือประเมิน และการนำเครื่องมือประเมินไปใช้จริง
- ทวนสอบการให้คะแนนในรายวิชาและการสอบทวนสอบเพื่อรับรองคุณภาพผลการประเมิน
- สรุปผลการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา (CLOs) และในระดับหลักสูตร (PLOs)

6. การประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิต

หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา หลักสูตรมีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและประเมินสมรรถนะของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยผลการประเมินดังกล่าวจะสะท้อนในรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)

7. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร

การดำเนินงานทั้งกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร ได้รับการกำกับติดตามภายใต้ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรที่ชัดเจน โดยแสดงรายละเอียดใน ภาพที่ 1.5-1 ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีการประเมินว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ทั้ง 8 ด้านเป็นระยะโดยผู้เรียนประเมินตนเอง ตามที่กำหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดรายวิชาดังแสดงใน มคอ.5 ของรายวิชาทฤษฎี และมคอ.6 ของรายวิชาปฏิบัติ นอกจากนี้เมื่อนิสิตปี 4 สำเร็จการศึกษา คณะฯ ให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินหลักสูตรฯตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐาน วิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ทั้ง 8 ด้าน ในปีการศึกษา 2567 ผู้ใช้บัณฑิต ได้ประเมินบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 การประเมินพบว่า บัณฑิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสรุปได้ว่าบรรลุผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน ดังตารางที่ 1.5-1 แสดงการประเมิน ผลการเรียนรู้ ทั้ง 8 ด้าน

การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

หลักสูตรดำเนินการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทั้งทางตรง (Direct Assessment) และทางอ้อม (Indirect Assessment) เพื่อให้การประเมินมีความครอบคลุมและน่าเชื่อถือ ดังนี้

ประเภทการประเมิน	เครื่องมือประเมิน
การประเมินทางตรง (Direct Assessment)	การสอบ Comprehensive Examination, การสอบ OSCE, การประเมินการฝึกปฏิบัติงาน (Practicum Assessment), การประเมินจากสถานการณ์จำลอง (Simulation Assessment)
การประเมินทางอ้อม (Indirect Assessment)	การประเมินตนเองของผู้เรียน (Self-assessment), การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (Employer Satisfaction Survey), การสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิต (Graduate Survey)

ตารางที่ 1.5-1 การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง PLO	ปีการศึกษา 2565		ปีการศึกษา 2566		ปีการศึกษา 2567		ปีการศึกษา 2568	
	$\bar{x}$	S.D.	$\bar{x}$	S.D.	$\bar{x}$	S.D.	$\bar{x}$	S.D.
คุณธรรมจริยธรรม	4.63	0.01	4.8	0.19	4.76	0.03	4.75	0.5
ความรู้	4.66	0.02	4.72	0.15	4.56	0.10	4.75	0.5
ทักษะทางปัญญา	4.63	0.01	4.67	0.17	4.7	0.01	4.75	0.5
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	4.7	0.05	4.6	0.01	4.73	0.11	4.75	0.5
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	4.47	0.08	4.4	0.1	4.63	0.01	4.5	0.58
สุนทรียศิลป์	4.4	0.66	4.4	0.8	4.5	0.67	4.5	0.58
ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ	4.6	0.02	4.5	0.17	4.65	0.01	4.5	0.58
ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ	4.62	0.01	4.56	0.19	4.78	0.02	4.5	0.58
รวม	**4.59**	**0.21**	**4.58**	**0.24**	**4.67**	**0.21**	**4.63**	**0.49**

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เรียนมีระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกด้านสูงกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด (3.50) อย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะวิชาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติของหลักสูตร

จากผลการประเมินพบว่า ผู้เรียนและบัณฑิตมีระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะวิชาชีพ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีการประเมินว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เป็นระยะโดยผู้เรียนประเมินตนเอง ตามที่กำหนดไว้ไว้ในหลักฐาน ผลการประเมินการบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้โดยผู้เรียน ดังแสดงในมคอ. 5 ของรายวิชาทฤษฎี และมคอ. 6 ของรายวิชาปฏิบัติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จากผลการประเมินของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2564 ในทุกรายวิชาพบว่าผู้เรียนสามารถ บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้ โดยแสดงผลการประเมินเป็นเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ที่สะท้อนว่าผู้เรียนประเมินตนเองว่า บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับใด ดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 4 คะแนน หมายถึง มาก 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง น้อย และ 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด ซึ่งจากการ ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กระจายสู่รายวิชา พบว่าผู้เรียนประเมินตนเองว่าสามารถ บรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้อยู่ในระดับมากกว่า 3.50 ในทุกรายวิชา นอกจากนี้หลักสูตรมีการรายงานผล การจัดการเรียน การสอนของอาจารย์ ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการ เรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ว่า ได้ดำเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผน ที่วางไว้ ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต้องให้เหตุผล และข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป นอกจากนี้ หลักสูตร ยังมีการประเมิน การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตรายชั้นปี เพื่อสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเป็นการพัฒนาระดับการเรียนรู้ จากขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นที่ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในสมรรถนะและทักษะที่กำหนด โดยประเมิน นิสิตชั้นปีที่ 1-4 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ผลการประเมินดังตาราง 1.5-2

ตารางที่ 1.5-2 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) ของนิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Sub PLOs	รายละเอียด	การบรรลุของ PLOs							
		นิสิตชั้นปีที่1 รหัส 68		นิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 67		นิสิตชั้นปีที่ 3 รหัส 66		นิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 65	
		$\bar{x}$	S.D.	$\bar{x}$	S.D.	$\bar{x}$	S.D.	$\bar{x}$	S.D.
PLO1	แสดงออกซึ่งจิตสำนึกและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	4.25	0.46	4.28	0.57	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO2	แสดงออกซึ่งจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม	4.38	0.52	4.28	0.67	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO3	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งในการดำรงตนและการปฏิบัติงานได้	4.25	0.46	4.33	0.59	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO4	เคารพกฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	4.25	0.46	4.56	0.62	5.0	0.0	4.71	0.49
PLO5	อธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง	4.25	0.46	4.06	0.54	4.8	0.45	4.43	0.53

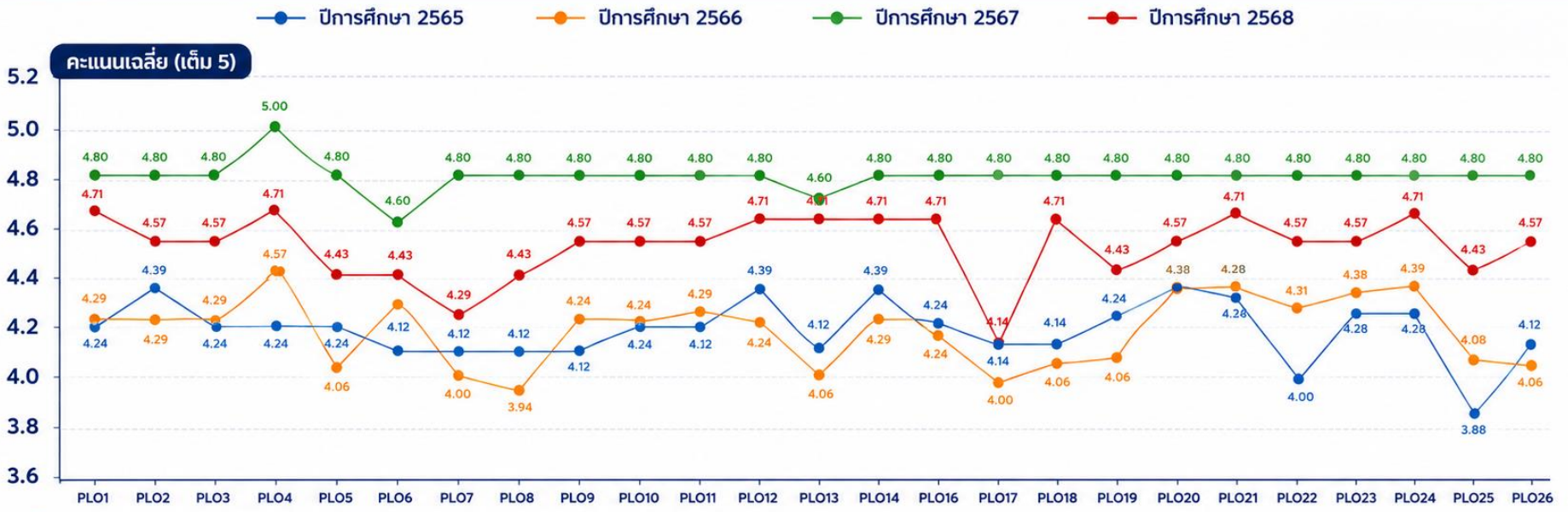
PLO6	อธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านฉุกเฉินการแพทย์ สามารถบูรณาการและประยุกต์กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ	4.12	0.64	4.33	0.49	4.6	0.55	4.43	0.79
PLO7	อธิบายความรู้ความเข้าใจในคำสั่ง กฎ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์	4.12	0.64	4.0	0.69	4.8	0.45	4.29	0.76
PLO8	ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความรู้งานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นคว้า กับศาสตร์ด้านฉุกเฉินการแพทย์	4.12	0.83	3.94	0.54	4.8	0.45	4.43	0.98
PLO9	แสดงความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ รวมทั้งประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้	4.12	0.64	4.22	0.55	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO10	แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติการด้านฉุกเฉินการแพทย์	4.25	0.46	4.22	0.65	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO11	ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในการวิเคราะห์และหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย	4.25	0.71	4.28	0.46	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO12	แสดงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม	4.38	0.52	4.33	0.69	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO13	แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน วางตัว	4.12	0.64	4.06	0.64	4.6	0.55	4.71	0.49

	และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม								
PLO14	แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.38	0.52	4.28	0.67	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO15	แสดงความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	4.25	0.46	4.22	0.55	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO16	ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน	4.5	0.53	4.0	0.69	4.8	0.45	4.14	0.9
PLO17	ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	4.12	0.64	4.06	0.73	4.8	0.45	4.14	0.9
PLO18	แสดงทักษะการเลือกใช้ภาษาและรูปแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้	4.25	0.46	4.06	0.73	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO19	ประยุกต์ความรู้และคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม กับศาสตร์ที่ศึกษาได้	4.38	0.52	4.17	0.71	4.8	0.45	4.43	0.79
PLO20	ประยุกต์ความรู้และสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม	4.38	0.52	4.39	0.61	4.8	0.45	4.57	0.53

PLO21	แสดงบุคลิกภาพตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม	4.25	0.46	4.39	0.7	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO22	แสดงทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์	4.0	0.76	4.33	0.49	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO23	เลือกใช้มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินได้ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน	4.25	0.46	4.39	0.5	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO24	ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	4.25	0.46	4.39	0.61	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO25	บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้	3.88	0.83	4.11	0.83	4.8	0.45	4.43	0.79
PLO26	เลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	4.12	0.64	4.06	0.73	4.8	0.45	4.57	0.53

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Sub-PLO Attainment) รายปีการศึกษา

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)



ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว: ค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละปีการศึกษาตรงกับข้อมูลต้นฉบับทุกจุด (PLO1–PLO26)

ปีการศึกษา 2567
คะแนนเฉลี่ยรวม **4.80**
สูงที่สุด

ปีการศึกษา 2568
คะแนนเฉลี่ยรวม **4.57**
เพิ่มขึ้นจากปี 2566

ปีการศึกษา 2566
คะแนนเฉลี่ยรวม **4.19**
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ปีการศึกษา 2565
คะแนนเฉลี่ยรวม **4.21**
ฐานการพัฒนาที่ดี

เป้าหมาย ≥ 4.00 ทุก PLO

ภาพรวมทุกปีการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยทุก PLO สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (≥ 4.00) แสดงถึงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินรายชั้นปีสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถรักษาระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องในทุกชั้นปี และสามารถพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพในบริบทที่ซับซ้อนมากขึ้นตามลำดับชั้นปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบหลักสูตรแบบ Outcome-Based Education (OBE)

จากกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ หลักสูตรสามารถแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร โดยผลการประเมินสะท้อนถึงความพร้อมของบัณฑิตในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)

การสอบ Comprehensive Examination ถูกออกแบบให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทั้งด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ โดยมีการจัดทำ Blueprint และเชื่อมโยงข้อสอบกับ PLOs อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

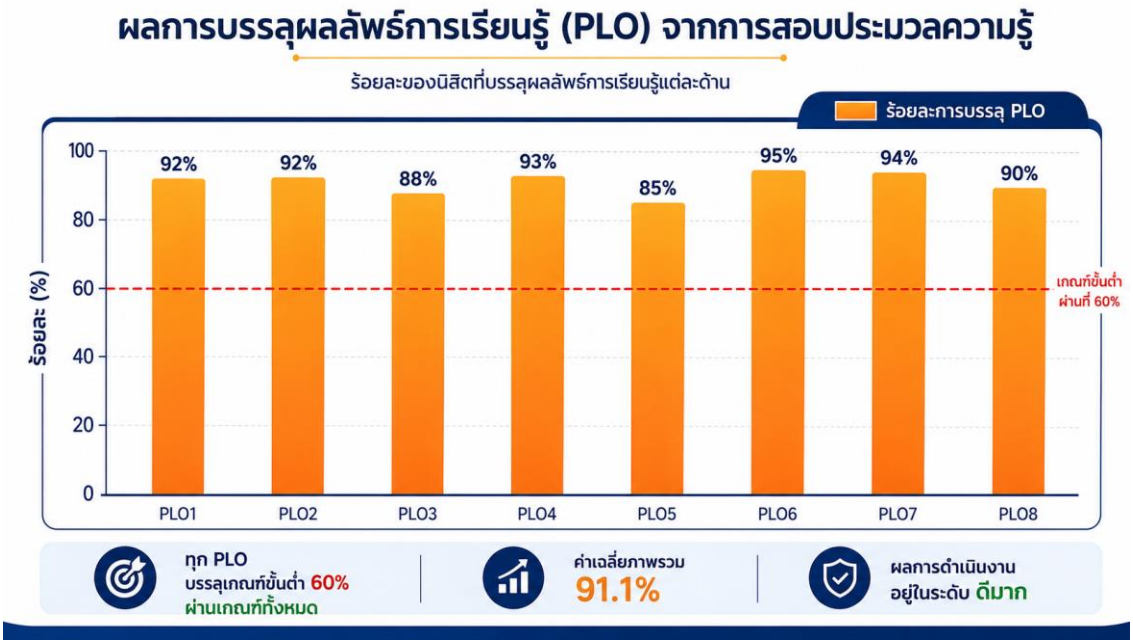
ตารางที่ 1.5-3 สรุปผลการสอบ Comprehensive Test ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2568

ตัวชี้วัด	ผลการประเมิน	การแปลผล
จำนวนนิสิตเข้าสอบ	28 คน	ครอบคลุมนิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยรวม	68.39 คะแนน	อยู่ในระดับดี
คะแนนสูงสุด	82.20 คะแนน	ดีเยี่ยม
คะแนนต่ำสุด	47.72 คะแนน	ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ ≥ 60%	27 คน	ผ่านเกณฑ์เกือบทั้งหมด
ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์	96.43%	สะท้อนการบรรลุ PLOs ในระดับสูง
จำนวนผู้ได้คะแนน ≥ 70%	11 คน	มีสมรรถนะระดับดีถึงดีเยี่ยม
ร้อยละผู้ได้คะแนน ≥ 70%	39.29%	แสดงศักยภาพด้านวิชาชีพที่ดี
จำนวนผู้ต่ำกว่าเกณฑ์	1 คน	ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม
ร้อยละผู้ต่ำกว่าเกณฑ์	3.57%	อยู่ในระดับต่ำ

ตารางที่ 1.5-4 ระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO Attainment) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 จากผลการสอบ Comprehensive Examination

PLO	รายวิชาที่ใช้ประเมิน	คะแนนเฉลี่ยโดยประมาณ	ร้อยละการบรรลุ	การแปลผล
PLO1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	กฎหมาย จริยธรรม และนิติเวชศาสตร์	62%	88%	นิสิตส่วนใหญ่มีความเข้าใจจริยธรรมวิชาชีพและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในระดับหนึ่ง
PLO2 ด้านความรู้	Basic Sciences, EMS, Emergency Care, Pharmacology	68%	92%	นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และฉุกเฉินการแพทย์ได้ในระดับดี
PLO3 ด้านทักษะทางปัญญา	Emergency Care, ECG, ALS, Trauma	64%	88%	นิสิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจทางคลินิกในระดับปานกลางถึงดี
PLO4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	Psychology, Disaster Management	70%	93%	นิสิตสามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น และแสดงภาวะผู้นำได้อย่างเหมาะสม
PLO5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ IT	Research, ECG	60%	85%	นิสิตสามารถใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจได้ระดับหนึ่ง แต่ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติม
PLO6 ด้านสุนทรียศิลป์	กิจกรรมเสริมหลักสูตร	75%	95%	นิสิตสามารถประยุกต์ใช้คุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับวิชาชีพได้เหมาะสม
PLO7 ด้านสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ	Health Care Principles, EMS Psychology	72%	94%	นิสิตมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมวิชาชีพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
PLO8 ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ	Procedures, CPR, Trauma, EMS Operations	66%	90%	นิสิตสามารถปฏิบัติทักษะทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับที่น่าพอใจ

หมายเหตุ: ข้อมูลระดับการบรรลุ PLOs เป็นการวิเคราะห์จากผลการสอบ Comprehensive Examination ร่วมกับผลการประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินจากการฝึกปฏิบัติงาน และการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของนิสิต



สรุปผลการบรรลุ PLOs ของนิสิตชั้นปีที่ 4

จากผลการประเมิน Comprehensive Examination และการประเมินร่วมกับการฝึกปฏิบัติงาน พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ได้ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด โดยเฉพาะด้านความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (PLO2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (PLO4) และด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (PLO8)

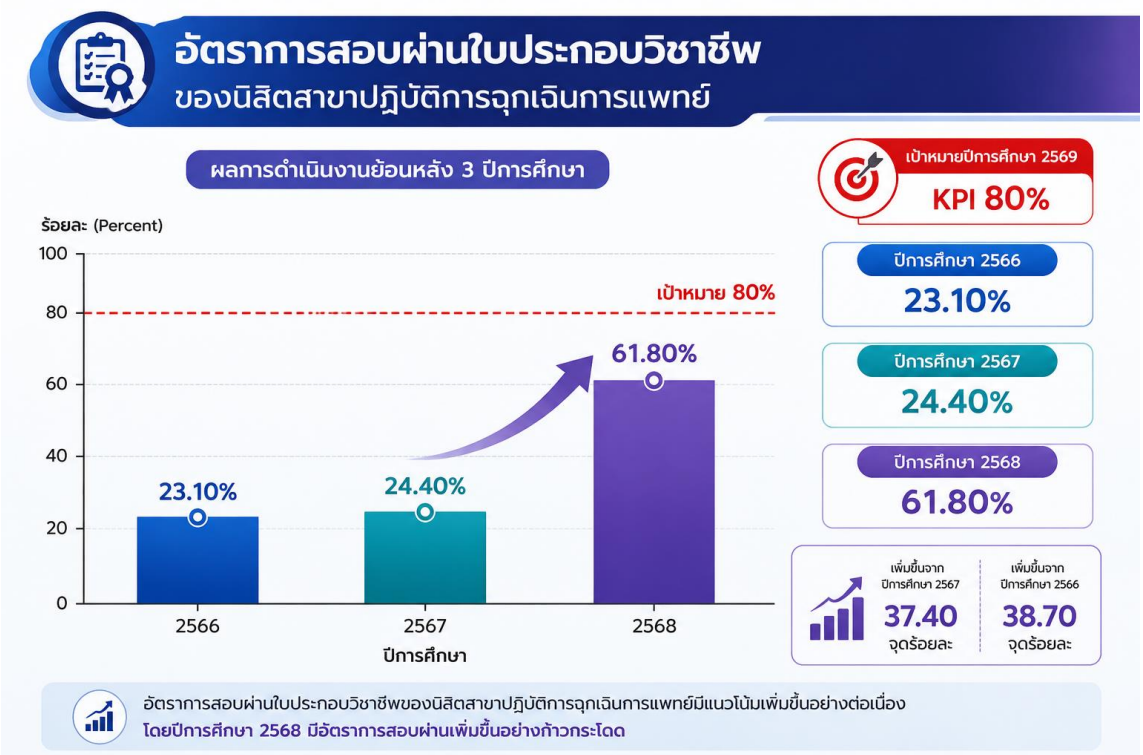
อย่างไรก็ตาม ยังพบประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมในด้านการคิดวิเคราะห์ทางคลินิกขั้นสูง การแปลผลข้อมูลทางการแพทย์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางคลินิก ซึ่งหลักสูตรได้นำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรม Simulation การฝึก Clinical Reasoning และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพ ตามแนวทาง Continuous Quality Improvement (CQI) อย่างต่อเนื่อง

จากผลการประเมินทั้งทางตรงและทางอ้อม หลักสูตรสามารถแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะด้านสมรรถนะวิชาชีพ การตัดสินใจทางคลินิก และการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ทั้งนี้ หลักสูตรได้นำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ Continuous Quality Improvement (CQI)

ผลการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพของนิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในช่วง 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง พบว่าอัตราการสอบผ่านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2566 มีอัตราการสอบผ่านร้อยละ 23.10 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.40 ในปีการศึกษา 2567 และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นร้อยละ 61.80 ในปีการศึกษา 2568

เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2566 พบว่าอัตราการสอบผ่านเพิ่มขึ้น 38.70 จุดร้อยละและเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2567 จำนวน 37.40 จุดร้อยละ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของมาตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมก่อนสอบและระบบติดตามผลการเรียนของนิสิตที่หลักสูตรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายของหลักสูตรในปีการศึกษา 2569 ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ยังมีช่องว่างจากเป้าหมาย (Gap) อยู่ 18.20 จุดร้อยละ หลักสูตรจึงมีแผนดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดสอบเสมือนจริง (Mock Examination) การวิเคราะห์ผลสอบรายบุคคล การติดตามนิสิตกลุ่มเสี่ยง และการเสริมความรู้ในหัวข้อที่มีอัตราการตอบผิดสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของหลักสูตร



ผลการประเมินตนเอง

AUN-QA Criterion 1 – Checklist	ระดับ 2568
1.1The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.	4
1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.	4
1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline).	4
1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes.	4
1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate.	4
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)	**4**

ตารางสรุปเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน AUN-QA Criterion 1.1–1.5

Criterion	รหัสหลักฐาน	เอกสารหลักฐาน
AUN-QA 1.1	AUN1.1-1	มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
	AUN1.1-2	PLO Statements
	AUN1.1-3	PLO–Mission Alignment Matrix
	AUN1.1-4	Bloom’s Taxonomy Mapping
	AUN1.1-5	Curriculum Mapping
	AUN1.1-6	เอกสารปฐมนิเทศนิสิต
	AUN1.1-7	เว็บไซต์หลักสูตร
AUN-QA 1.2	AUN1.2-1	CLO–PLO Mapping
	AUN1.2-2	ตาราง CLO-PLO Alignment
	AUN1.2-3	มคอ.3 รายวิชา

Criterion	รหัสหลักฐาน	เอกสารหลักฐาน
	AUN1.2-4	Curriculum Mapping
	AUN1.2-5	Teaching-Learning-Assessment Alignment
	AUN1.2-6	Blueprint การประเมิน
	AUN1.2-7	Rubric การประเมิน
	AUN1.2-8	รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
	AUN1.2-9	แบบประเมิน OSCE และการฝึกปฏิบัติ
AUN-QA 1.3	AUN1.3-1	รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
	AUN1.3-2	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
	AUN1.3-3	รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
	AUN1.3-4	แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต
	AUN1.3-5	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
	AUN1.3-6	แบบสอบถามศิษย์เก่าและนิสิต
	AUN1.3-7	แบบสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิต
	AUN1.3-8	เอกสารมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
AUN-QA 1.4	AUN1.4-1	Curriculum Mapping
	AUN1.4-2	CLO–PLO Alignment
	AUN1.4-3	มคอ.3 รายวิชา
	AUN1.4-4	Blueprint การประเมิน
	AUN1.4-5	Rubric การประเมิน
	AUN1.4-6	แบบประเมิน OSCE
	AUN1.4-7	แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน
	AUN1.4-8	รายงานกิจกรรม Simulation
AUN-QA 1.5	AUN1.5-1	รายงานผลการสอบ Comprehensive Examination
	AUN1.5-2	Blueprint การสอบ Comprehensive Examination
	AUN1.5-3	รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ (Item Analysis)
	AUN1.5-4	รายงานผลการสอบ OSCE
	AUN1.5-5	แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน (Practicum Assessment)

Criterion	รหัสหลักฐาน	เอกสารหลักฐาน
	AUN1.5-6	แบบประเมินจากแหล่งฝึก
	AUN1.5-7	รายงานผลการฝึกปฏิบัติ
	AUN1.5-8	รายงานผลการประเมิน PLO Attainment
	AUN1.5-9	มคอ.5 และ มคอ.6
	AUN1.5-10	มคอ.7
	AUN1.5-11	หลักฐานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
	AUN1.5-12	รายงานผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต
	AUN1.5-13	แบบสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิต
	AUN1.5-14	แผน CQI (Continuous Quality Improvement)
	AUN1.5-15	รายงานกิจกรรม Simulation
	AUN1.5-16	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

QR CODE เอกสารหลักฐาน

AUN QA criterion Programme Structure andContent

Sub Criterion 2

1. The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.
2. The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes.
3. The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders.
4. The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear.
5. The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.
6. The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations.
7. The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.

AUN-QA 2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.

ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายวิชาทั้งหมด มีความครอบคลุม ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ และมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับ พ.ศ. 2564 ได้ทำการทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดของหลักสูตรจากการดำเนินงานภายใต้ระบบและกลไกออกแบบจากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง ประเทศ โลก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเป็นพลวัตรอยู่ตลอดเวลาดังภาพ 1.1-1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ออกแบบตามกรอบแนวคิด สำหรับการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง มุ่งเน้นการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะศตวรรษที่ 21 เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะปฏิบัติการ วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้เพิ่มรายวิชาว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วย ทางน้ำ

นอกจากนี้ยังเพิ่มความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเท่าทัน สังคมปัจจุบัน และกำหนดให้เรียนรายวิชา จิตสาธารณะและภาวะผู้นำ การเสริมสร้าง กระบวนการคิด และการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ตลอดจนจัดให้รายวิชา เป็นรายวิชาใหม่ให้เป็นวิชาเลือกเสรี สนับสนุนการนำการวิจัยทางการแพทย์ฉุกเฉินสู่การนำเสนออื่นๆผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้ก้าวทันศตวรรษที่ 21

POLs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง website, Facebook ของคณะฯ และกิจกรรม แนะนำสัญจร ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในช่วงของการรับสมัคร คณะกรรมการรับสมัครนิสิตได้เปิดช่องทางกลุ่ม line เพื่อให้ผู้สมัครและผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสับที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้ตลอดระยะเวลาของการรับสมัครจนถึงการรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษา และก่อนสอบสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรจะมีการนำเสนอหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย กิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตที่เข้าสัมภาษณ์และผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมูล เมื่อเข้าเป็นนิสิต นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครอง คณบดีและทีมบริหาร สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กรและภาพรวมขององค์กร ในส่วนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร สื่อสารกับนิสิตและผู้ปกครองอีกครั้งถึงข้อมูลภาพรวม ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร และเปิดโอกาส ให้ซักถามสำหรับข้อมูลรายวิชา courses specification ของรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าภาควิชา เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ รายวิชา และร่วมสร้าง มคอ.3, มคอ.4 ขึ้นครบถ้วนทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาครั้งแรก และเมื่อหลักสูตรเปิดดำเนินการแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดำเนินการกำกับติดตามให้ ผู้รับผิดชอบ รายวิชาประชุมร่วมกับผู้สอน นำข้อเสนอแนะข้อควรพัฒนาจากการดำเนินการ จัดการเรียนรู้ ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา

นำมาปรับปรุง มคอ.3, มคอ.4 เพื่อดำเนินการในวงรอบต่อไป เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาการสื่อสาร courses specification ของรายวิชา ดำเนินการ ตามกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

1) กลุ่มผู้สอน ทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ สื่อสาร ผ่านการประชุม ปรับปรุงรายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบวิชาทำหน้าที่ในการสื่อสาร ให้อาจารย์พี่เลี้ยง (preceptor) ทราบโดยอธิบาย ประกอบคู่มือรายวิชาเป็นรายบุคคล

2) กลุ่มผู้เรียน ผู้รับผิดชอบวิชา เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสาร โดยผ่านการปฐมนิเทศรายวิชา การแจกคู่มือรายวิชา และจัดเก็บเอกสารใน Team class room และหากนิสิตมีข้อสงสัย สามารถสอบถามผู้รับผิดชอบวิชาได้ตลอดภาคการศึกษา

ผลการดำเนินการพบว่าในปีการศึกษา 2567 และ 2568 ไม่มีนิสิตที่มีข้อร้องเรียน คกก.บริหารหลักสูตรจึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมในปีการศึกษา 2568

ตาราง 2.1 ร้อยละการรับรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) และข้อมูลหลักสูตร

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางการสื่อสาร	ร้อยละการรับรู้ (%)
นิสิตชั้นปีที่ 1	การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คู่มือนิสิต และเว็บไซต์หลักสูตร	**85.71**
นิสิตชั้นปีที่ 2–4	การชี้แจงรายวิชา (Course Specification/มคอ.3) และการปฐมนิเทศรายวิชา	**81.30**
ผู้ปกครอง	การปฐมนิเทศผู้ปกครอง	**66.67**
ค่าเฉลี่ยรวม		**70.92**

จากตารางที่2.1พบว่านิสิตชั้นปีที่1มีการรับรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและข้อมูลหลักสูตรร้อยละ 85.71 จากการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การใช้คู่มือนิสิต และเว็บไซต์หลักสูตร ขณะที่นิสิตชั้นปีที่ 2–4 มีการรับรู้เฉลี่ยร้อยละ 81.30 จากการชี้แจงรายวิชา (CourseSpecification/มคอ.3) และการปฐมนิเทศรายวิชาส่วนผู้ปกครองมีการรับรู้ร้อยละ66.67จากการปฐมนิเทศผู้ปกครองโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ร้อยละ0.92สะท้อนว่าหลักสูตรสามารถสื่อสารผลลัพธ์การเรียนรู้และข้อมูลหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักได้ในระดับที่ดีทั้งนี้หลักสูตรมีแผนพัฒนาช่องทางการสื่อสารและขยายการประเมินการรับรู้ไปยังอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง Continuous Quality Improvement (CQI)

AUN-QA 2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes.
การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกระบวนการและผลการดำเนินงาน

กราฟระบบและกลไกการดำเนินงาน



ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สร้างโดยได้ออกแบบหลักสูตรตามกรอบ แนวคิดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education) มุ่งเน้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลง (change) ผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งการออกแบบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสำคัญคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกรอบมาตรฐานหลักสูตร นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปมาประกอบการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

ขั้นที่ 2 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs/Sub PLOs)

ขั้นที่ 3 การจัดทำรายวิชาใช้แบบ backward design โดย

1. วิเคราะห์ PLOs และ Sub PLOs เพื่อกำหนดกลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒนากาการเรียนรู้ และกำหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ PLOs ผลการดำเนินการ หลักสูตรนี้มี 26 Sub PLOS

2. วิเคราะห์ PLOs ตามกรอบของ Bloom's Taxonomy (knowledge/ cognitive domain: K = 6 ข้อ) เจตคติ (attitude/ affective domain: A= 3 ข้อ) และด้านทักษะ (skill/psychomotor domain = 5 ข้อ)

3. กำหนดคำอธิบายรายวิชา เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (CLOs) ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่รายวิชารับผิดชอบดังที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร กลยุทธ์

การสอนและกลยุทธ์การประเมินผล ตามหลักการของ backward curriculum design เพื่อให้มั่นใจว่านิสิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หลักสูตร

4. วิเคราะห์ความสอดคล้องของชุดวิชาและรายวิชาทั้งหมดกับ PLOS, Sub PLOs, และ KSA อีกครั้ง ตรวจสอบโครงสร้างของรายวิชาพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ขั้นที่ 4 การจัดเวทีวิพากษ์ร่างหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิ สาขา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาปรับปรุงร่างหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ขั้นที่ 5 เมื่อหลักสูตรมีการดำเนินการแล้ว/ครบวงรอบ ต้องตรวจสอบความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้กลยุทธ์การสอน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และวัตุประสงค์ของหลักสูตร (PLOs/Sub PLOs) ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปได้

ตารางที่ 2.2.1 แสดงความสอดคล้องระหว่าง PLOs, CLOs, วิธีการจัดการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผล (Constructive Alignment)

PLO	CLO	วิธีการจัดการเรียนรู้	วิธีการประเมินผล
PLO1 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ	CLO1 ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย	การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case-based Learning), การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion), การสะท้อนคิด (Reflection)	การประเมินพฤติกรรมทางวิชาชีพ (Professional Behavior Assessment), รายงานการสะท้อนคิด (Reflection Report), การประเมินการฝึกปฏิบัติงาน (Practicum Evaluation)
PLO2 ความรู้ทางวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	CLO2 อธิบายหลักการประเมินและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง	การบรรยาย (Lecture), การเรียนรู้แบบทีม (Team-Based Learning: TBL), ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)	การสอบข้อเขียน (Written Examination), แบบทดสอบย่อย (Quiz), การมอบหมายงาน (Assignment)
PLO3 การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจทางคลินิก	CLO3 วิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินและวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม	การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL), การศึกษากรณีศึกษา (Case Study)	การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Analysis), การสอบตามสถานการณ์จำลอง (Scenario-Based Examination)
PLO4 ความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่น	CLO4 ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การเรียนรู้แบบทีม (Team-Based Learning), การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation-Based Learning)	การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment), การประเมินการทำงานเป็นทีม (Teamwork Evaluation)
PLO5 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	CLO5 สื่อสารข้อมูลทางการแพทย์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม	การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง (Simulation), การนำเสนอ (Presentation), การเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning)	แบบประเมินการนำเสนอ (Presentation Rubric), การประเมินทักษะการสื่อสาร (Communication Assessment)

PLO	CLO	วิธีการจัดการเรียนรู้	วิธีการประเมินผล
PLO6 สุนทรียศิลป์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต	CLO6 แสดงออกถึงการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning), การสัมมนา (Seminar)	การประเมินแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment), การประเมินการสัมมนา (Seminar Evaluation)
PLO7 การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ	CLO7 สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยได้	การเรียนรู้จากชุมชน (Community-Based Learning), การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)	โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Education Project), แบบสังเกตพฤติกรรม (Observation Checklist)
PLO8 ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	CLO8 ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพได้	การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation-Based Learning), การฝึกปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practicum), ห้องปฏิบัติการทักษะ (Skills Laboratory)	การสอบปฏิบัติแบบ OSCE, การประเมินการฝึกปฏิบัติงาน (Practicum Assessment), การประเมินสมรรถนะทางคลินิก (Clinical Performance Evaluation)

หลักสูตรใช้แนวคิดการจัดการศึกษาตามหลักการ Constructive Alignment โดยเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) ไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) วิธีการจัดการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่านิสิตสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

AUN-QA 2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders.
มีการนำข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาประกอบการออกแบบหลักสูตร

ผลการดำเนินงาน:

การออกแบบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดำเนินการตามขั้นตอนในคณะ ตามภาพที่ 1.1-1 และภาพที่ 2.2-1 โดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตจากสถานพยาบาลที่รับบัณฑิตของคณะฯ กลุ่มเป้าหมาย คือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือหัวหน้างานของบัณฑิต อีกทั้งยังรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย ของผู้ใช้บัณฑิตร่วมกับผู้สอน นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ดำเนินการประเมินหลักสูตร โดยรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากอาจารย์ผู้ผู้สอน ผู้เรียน ในทุกปี ตลอดจนข้อมูลจากการประเมินรายวิชา มคอ 5, มคอ 6 มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อนำมาปรับปรุง หลักสูตร ในแต่ละวงรอบยกตัวอย่าง เช่น การนำ feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับหลักสูตร การดำเนินงานหลักสูตร 2559 ถึงรอบการปรับหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้รวบรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่ปี

การศึกษา 2562-2663 พบว่า ทักษะที่ผู้ใช้บัณฑิต ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น คือ ทักษะด้านเทคโนโลยี จึงมาปรับในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 กำหนด เป็น PLO ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเด่นชัดมากขึ้นเมื่อเทียบกับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม หากมีโรคอุบัติใหม่ องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ หรือ feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาคการศึกษา /ปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะนำเข้าพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน การประเมินผลให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา ประชุมที่กำหนดไว้สม่ำเสมอในทุกเดือน

ในปีพ.ศ.2568หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2569 โดยใช้แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบนพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามาตรฐานวิชาชีพและทิศทางการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ

ในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวหลักสูตรได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันผู้ปกครองอาจารย์ผู้สอนอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มการสัมภาษณ์การตอบแบบสอบถาม และการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

ผลการสำรวจพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการให้บัณฑิตมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นสูงการตัดสินใจทางคลินิกการสื่อสารและการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรจึงได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและสังคมในอนาคตตลอดจนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ในปีการศึกษาพ.ศ.2568 หลักสูตรได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของวิชาชีพผู้ใช้บัณฑิตและการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพ

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาหลักสูตรผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการประชุมวิพากษ์หลักสูตรและการพิจารณาความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร(ProgramLearningOutcomes:PLOs) โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับได้ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนดังแสดงในตารางที่ 2.3.1

ตารางที่ 2.3.1 การนำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อเสนอแนะที่ได้รับ	การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ใช้บัณฑิต	เพิ่มทักษะการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Interpretation)	เพิ่มเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ศิษย์เก่า	เพิ่มการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง (Simulation-Based Learning)	เพิ่มชั่วโมงการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการสถานการณ์จำลอง
ครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก	เพิ่มทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced Life Support: ALS)	เพิ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติและการประเมินทักษะ ALS
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)	เพิ่มเนื้อหาด้านการจัดการสาธารณภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่	ปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มรายวิชาด้านการจัดการทางการแพทย์ในสาธารณภัย

AUN-QA 2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear.
การกระจายความรับผิดชอบสู่แต่ละรายวิชามีความชัดเจน และสามารถผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้นำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรทั้ง 8 ด้านมาจัดทำแผนที่แสดงการกระจาย ความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยจำแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่งได้แสดงใน มคอ.2 ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ ควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยก่อนการเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องนำเสนอ มคอ.3 หรือ มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ที่กำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่มุ่งหวัง ในการพัฒนานิสิต แผนการสอน และข้อกำหนดในการประเมิน ผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความเหมาะสม ของรายวิชาก่อนจะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอน หลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้ร่วมสอนจะเป็นผู้ดำเนินการให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่รายวิชากำหนด และเมื่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเสร็จสิ้นอาจารย์ผู้รับผิดขอบรายวิชาจะรายงานผล การดำเนินการของรายวิชาใน มคอ.5 หรือ มคอ.6 ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ผลการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการผลการประเมินรายวิชา โดยนักศึกศึกษา และอาจารย์ผู้ร่วมสอน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ทุกรายวิชาจะได้รับ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะติดตามผลการดำเนินการของแต่ละรายวิชาว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หรือไม่ และรวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในรอบต่อไปยกตัวอย่าง เช่น PLO 8 นิสิตจะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์อย่างเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่การให้การดูแลขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ซับซ้อน และสถานการณ์พิเศษโดยมีการฝึกปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง ทั้งในโรงพยาบาล หน่วยกู้ชีพ และพื้นที่สาธารณภัยการกระจายความรับผิดชอบ สู่แต่ละรายวิชาและการผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรได้ถูกจัดระเบียบและชัดเจนผ่านการเชื่อมโยงระหว่าง รายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่คาดหวัง (PLO) โดยเฉพาะ PLO8 ซึ่งเป็นการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยในภาวะเร่งด่วนและวิกฤต

ตารางที่ 2.4.1 ตารางแสดงแต่ละวิชามีส่วนช่วยในการบรรลุ PLO8 อย่างชัดเจนในแต่ละปีการศึกษา

ชั้นปี	ภาคการศึกษา	รายวิชา	CLO ที่เกี่ยวข้อง	ระดับการสนับสนุน ต่อ PLO8
ปี 1	ฤดูร้อน	หัตถการทางฉุกเฉิน การแพทย์ขั้นพื้นฐาน	สามารถปฏิบัติหัตถการเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย	★★★
ปี 1	ฤดูร้อน	การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	มีทักษะ CPR และการใช้ AED	★★★
ปี 1	ฤดูร้อน	ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน	ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ทั่วไปได้	★★★
ปี 2	ปลาย	การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	ฝึกทักษะภาคสนามในสถานการณ์จริง	★★★
ปี 2	ฤดูร้อน	การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1	ฝึกฝนงานภาคสนามกับทีม EMS	★★★
ปี 3	ต้น	การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1	ให้การดูแลผู้ป่วย เช่นระบบหายใจ/ไหลเวียนโลหิต	★★★
ปี 3	ต้น	การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1	ประเมินและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น	★★★
ปี 3	ต้น	การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	ACLS/BLS ตามมาตรฐาน	★★★
ปี 3	ปลาย	การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2	ดูแลผู้ป่วยภาวะซับซ้อน เช่น (ระบบประสาท/ต่อมไร้ท่อ)	★★★
ปี 3	ปลาย	การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2	จัดการผู้บาดเจ็บหลายระบบ/สาหัส	★★★
ปี 3	ปลาย	การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง	ฝึกสถานการณ์เสมือนจริง	★★★
ปี 3	ฤดูร้อน	การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2	ปฏิบัติการในระบบ EMS กับผู้ป่วยจริง	★★★
ปี 4	ต้น	การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3	ฝึกปฏิบัติกับเคสเฉพาะทาง/วิกฤต	★★★

ปี 4	ปลาย	การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4	ฝึกเต็มเวลาในสถานพยาบาล	★★★
ปี 4	ปลาย	สัมมนา	วิเคราะห์กรณีศึกษาและเสนอแนวทางการจัดการผู้ป่วย	★★☆

- CLO ที่เกี่ยวข้อง เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละวิชา
- ระดับการสนับสนุนต่อ PLO8 ใช้สัญลักษณ์ ★ ที่แสดงระดับการสนับสนุนตามลำดับ (เช่น ★★★ = สนับสนุนอย่างเต็มที่, ★★☆ = สนับสนุนบางส่วน)

การกระจายความรับผิดชอบในแต่ละรายวิชาและการผลักดันการบรรลุ PLO8 ได้รับการจัดระเบียบ อย่างชัดเจนจากตาราง Mapping Table ข้างต้น โดย PLO8 คือการปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์ตามมาตรฐาน วิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยในภาวะเร่งด่วนและวิกฤตในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งการฝึกฝนที่ได้รับจากรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม (เช่น การฝึกภาคสนามกับ EMS การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน ในสถานการณ์จริง) สามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ ในการปฏิบัติการทางการแพทย์ ฉุกเฉินในสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตาราง Mapping Table แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของแต่ละวิชากับ PLO8 โดยมีการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในด้านทักษะทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการรับมือกับสถานการณ์ ฉุกเฉินที่ซับซ้อนโดยทุกรายวิชามีการฝึกทักษะและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

ตาราง Curriculum Mapping (ตัวอย่าง)

รหัสวิชา	รายวิชา	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
323111	หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	I	I	I	I	I	-	-	R
323131	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	I	I	I	R	R	I	I	I
323212	เทคนิคหัตถการ 1	I	R	R	I	I	-	-	R
323244	พยาธิสรีรวิทยา	-	R	R	-	I	-	-	I
341334	เภสัชวิทยาเบื้องต้น	I	R	R	-	I	-	-	R
323314	การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1	I	R	R	R	I	-	I	R

คำอธิบาย (Legend)

- **I (Introduce)** = เริ่มพัฒนา/แนะนำผลลัพธ์การเรียนรู้
- **R (Reinforce)** = เสริมสร้างและพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
- **M (Master)** = บรรลุความเชี่ยวชาญหรือความสามารถตามผลลัพธ์การเรียนรู้

AUN-QA 2.5 The curiculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.

หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างหลักสูตร การจัดเรียงลำดับรายวิชามีความเหมาะสมเป็นเหตุเป็นผล (ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน ระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง) และมีการบูรณาการกัน

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีการจัดรายวิชาของหลักสูตรมีการจัดเรียงตามลำดับองค์ความรู้และเนื้อหาที่สำคัญ ในการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วค่อยเป็นการเรียนการสอนในเนื้อหาและฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยได้แสดงไว้ในตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ซึ่งได้มีการเรียงตามแผนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4 และมีการเรียงลำดับจาก IRPM ซึ่งได้แสดงใน มคอ.2 หน้า 23-29 สามารถสรุปโดยสังเขป ดังนี้

แผนภาพที่ 2.5 แผนภาพสรุปภาพรวมหลักสูตรการเรียนรู้ตามชั้นปีในหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์



ตารางที่ 2.5 สรุปลักษณะการเรียนรู้ตามชั้นปีในหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์

ชั้นปี / ภาคการศึกษา	รายวิชาหลักที่เรียน	วัตถุประสงค์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 1 / ภาคต้น	- การใช้ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม - ศิลปะในการดำเนินชีวิต	ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทยและอังกฤษ พัฒนาทักษะชีวิต เข้าใจหลักเคมีและชีววิทยาที่จำเป็นต่อวิชาชีพด้านสุขภาพ พร้อมเริ่มเรียนรู้แนวคิด

	- เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ - ชีววิทยา 1 - หลักการจัดการสุขภาพ	การจัดการสุขภาพ แบบองค์รวม
ปี 1 / ภาคปลาย	- ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง - การสื่อสารในสังคมดิจิทัล - ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน - หลักการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน - สรีรวิทยาภาวะฉุกเฉิน - หลักการกายวิภาคศาสตร์	ปูพื้นฐานด้านภาษา การสื่อสาร ความรู้โครงสร้างร่างกายและการทำงานของระบบต่าง ๆ เริ่มรู้จักระบบการแพทย์ฉุกเฉินและหลักการดูแลเบื้องต้น
ปี 1 / ฤดูร้อน	- หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน - การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน -ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน	ฝึกปฏิบัติจริงด้านทักษะพื้นฐาน เช่น การ CPR การใช้อุปกรณ์เบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง
ปี 2 / ภาคต้น	- ภาษาอังกฤษก้าวหน้า - พลเมืองใจอาสา - สังคมพหุวัฒนธรรม - ฟิสิกส์ทางการแพทย์ - พยาธิสรีรวิทยา - ชีวเคมีพื้นฐาน - วิชาเลือกเสรี	พัฒนาทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษขั้นสูง และเสริมพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ฟิสิกส์ ชีวเคมี และกลไกของโรค พร้อมเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจริยธรรม
ปี 2 / ภาคปลาย	- การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม - บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม - อาการวิทยาทางฉุกเฉิน - การยกและการเคลื่อนย้าย - การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ - จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉิน - เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและฉุกเฉิน - จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา	เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานฉุกเฉินในสถานการณ์จริง ทั้งในด้านทักษะการเคลื่อนย้าย การใช้ยา การสื่อสารกับผู้ป่วย และจิตวิทยาการให้บริการ
ปี 2 / ฤดูร้อน	- การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1	ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง เรียนรู้ระบบงานของสถานพยาบาล ฝึกประสบการณ์จริงภาคสนาม 375 ชั่วโมง
ปี 3 / ภาคต้น	- ว่ายน้ำและการช่วยชีวิตทางน้ำ - การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1 - การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1 - หัตถการทางฉุกเฉินขั้นสูง - การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง - การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ - การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน - ระบาดวิทยาทางการแพทย์ฉุกเฉิน	เสริมทักษะเชิงลึกด้านหัตถการ การวิเคราะห์สัญญาณชีพ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง และเริ่มต้นกระบวนการวิจัยและคิดวิเคราะห์จากข้อมูลจริง
ปี 3 / ภาคปลาย	- การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2 - การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2	พัฒนาทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ซับซ้อน รู้จักข้อกฎหมายและจริยธรรม พร้อมการสรุป

	- การปฏิบัติการในสถานการณ์จำลอง - กฎหมาย จริยธรรม และนิติเวชศาสตร์ - การจัดการทางการแพทย์ในสาธารณภัย - ภาคนิพนธ์วิจัย - วิชาเลือกเสรี	ภาคนิพนธ์เพื่อเตรียมเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ปี 3 / ฤดูร้อน	- การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2	เพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในระดับเชิงลึก เรียนรู้การรับมือในเหตุการณ์ที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติ 375 ชั่วโมง
ปี 4 / ภาคต้น	- การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3	ปฏิบัติงานจริงในสถานบริการทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบ ฝึกงาน 600 ชั่วโมง
ปี 4 / ภาคปลาย	- สัมมนา - การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4	นำเสนอแนวคิด วิจัย และปัญหาจากประสบการณ์ พร้อมฝึกงานขั้นสูงเต็มเวลาในหน่วยงานทางการแพทย์อีก 600 ชั่วโมง

AUN-QA 2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specializations
หลักสูตรมีทางเลือกในการเลือกเรียนวิชาเอก หรือวิชาโท ตามความสนใจของผู้เรียน

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ดังนั้น หลักสูตรจึงไม่มีการกำหนดสาขาวิชาเอก (Major) หรือสาขาวิชาโท (Minor) อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเลือกเรียนตามความสนใจผ่านรายวิชาเลือกเสรี การทำโครงงานวิจัย การสัมมนา และการเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความสนใจและเป้าหมายทางวิชาชีพของตน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ได้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน โดยกำหนดให้มีรายวิชาเลือกเสรีจำนวน 6 หน่วยกิตจากหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 140 หน่วยกิต ซึ่งเป็นช่องทางให้นิสิตได้เลือกเรียนในรายวิชาที่ตนสนใจหรือสอดคล้อง กับเป้าหมาย วิชาชีพในอนาคต ทั้งนี้ รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งทักษะเฉพาะทาง และทักษะข้ามศาสตร์ เช่น การปฐมพยาบาลและการดูแล ผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน การขับร้อง ประสานเสียง การเงินสำหรับผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจการบิน การจัดกิจกรรมนันทนาการ และกลุ่มสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเลี้ยงปลาสวยงาม ไปจนถึง การออกแบบงาน 3 มิติขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

แนวทางการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี ได้รับการจัดวางไว้อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 2 ระยะหลัก คือในช่วงชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของคณะอื่นภายในมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะหรือหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ ทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาหลัก ในช่วงชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 นิสิต ยังคงมีโอกาส เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี

เพิ่มเติมตามที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยเปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ก่อนการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรี นิสิตจะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการเรียน มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพของนิสิตอย่างแท้จริง โดยการลงทะเบียนดำเนินการผ่านระบบ REG ของมหาวิทยาลัย การจัดโครงสร้าง รายวิชาเลือกเสรีดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของหลักสูตร ในการสร้างทางเลือกทางการศึกษา ส่งเสริมให้นิสิต ได้พัฒนาทักษะและความรู้รอบด้าน เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพ ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว

แนวทางดังกล่าวช่วยให้นิสิตสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่ตนสนใจ ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และยังคงสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) ที่กำหนดไว้

AUN-QA 2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.

มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะ ๆ ตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้มันใจว่าหลักสูตรมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของภาคการทำงาน

ผลการดำเนินงาน:

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการทบทวนหลักสูตรทุก 1 ปี และ ปรับปรุงทุก 5 ปี โดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สร้างปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ ความต้องการของ Stakeholder และแนวโน้มสถานการณ์สังคมปัจจุบัน โดยหัวหน้าภาภาควิชารับผิดชอบตามรายวิชา ที่เกี่ยวข้องและมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทำรายวิชา มคอ.3,4 นำเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการปรับแก้ไข เพื่อให้เหมาะสมและสมบูรณ์ จัดทำ มคอ.3, 4 ฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเรียน การสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาผู้รับผิดชอบวิชาจะรวบรวมคะแนน และตัดเกรด ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และจัดทำ มคอ.5,6 การทวนสอบรายวิชาทุกภาคการศึกษา อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคกก.บริหารหลักสูตร เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา และจัดประชุมประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิตความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน และประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต นำมาจัดทำ มคอ.7 รายปี ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตามผลการประเมินในระดับรายวิชาอย่างต่อเนื่องทุกปีตามวงจร PDCA ตามภาพ 1.5-1 ระบบกลไก การบริหารจัดการหลักสูตร สำหรับจดเด่นของหลักสูตรฉบับปรับปรับปรุง 2564 ต้องการสร้างบัณฑิต ในยุดปัจจุบันให้มีคณลักษณะตามแผนการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมี รายวิชาเกี่ยวกับการจัดการทางการแพทย์ฉุกเฉินวิกฤตและสาธารณภัยซึ่งเป็นสถานการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัยที่พบได้บ่อยในสังคมเมือง เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองให้มีสุขภาพดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน การเรียนการ สอนในหลักสูตร 2564 มุ่งเห็นความสำคัญของสถานการณ์ สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย การดำเนินการเป็นไปตามภาพ 1.5-1 ระบบและกลไก การบริหารหลักสูตร

ตารางที่ 2.7 การนำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและผลการดำเนินงาน (Continuous Quality Improvement: CQI)

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Feedback)	การดำเนินการปรับปรุง (Action)	ผลการดำเนินงาน (Result)
ผู้ใช้บัณฑิตเสนอให้เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมทางการแพทย์	ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (PLO5) พร้อมบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้	นิสิตมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์เพิ่มขึ้น และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบัณฑิตในระดับดี
ผู้ใช้บัณฑิตและแหล่งฝึกเสนอให้เพิ่มทักษะการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Interpretation)	เพิ่มเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติและ Workshop เพิ่มเติม	ผลการประเมินทักษะการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจของนิสิตดีขึ้น และคะแนนการสอบปฏิบัติ (OSCE) ด้าน ECG สูงขึ้น
ครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกเสนอให้เพิ่มทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced Life Support: ALS)	เพิ่มชั่วโมงฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การฝึกในสถานการณ์จำลอง และการประเมินทักษะ ALS	นิสิตมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และผลการประเมินจากแหล่งฝึกด้านทักษะ ALS อยู่ในระดับดีมาก
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้เพิ่มเนื้อหาด้านการจัดการสาธารณภัยและอุบัติภัยหมู่	ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย และเพิ่มการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์จำลอง	นิสิตมีสมรรถนะด้านการจัดการสาธารณภัยเพิ่มขึ้น และได้รับผลประเมินด้านการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ในระดับดี
ศิษย์เก่าเสนอให้เพิ่มการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง (Simulation-Based Learning)	เพิ่มจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองในรายวิชาหลักและรายวิชาฝึกปฏิบัติ	นิสิตสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้ดีขึ้น และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
แหล่งฝึกเสนอให้เพิ่มทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ	เพิ่มกิจกรรม Team-Based Learning (TBL) การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ (Interprofessional Education: IPE) และการประเมินการทำงานเป็นทีม	ผลการประเมินด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมของนิสิตจากแหล่งฝึกอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

ผลการประเมินตนเอง

AUN-QA Criterion 2 – Checklist	ระดับ 2568
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.	3
2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes.	3
2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders.	4
2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear.	3
2.5The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.	4
2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations.	3
2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.	4
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)	**3**

ตารางสรุปเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน AUN-QA Criterion 2.1–2.7

Criterion	รหัสหลักฐาน	เอกสารหลักฐาน
AUN-QA 2.1	AUN2.1-1	มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
	AUN2.1-2	เว็บไซต์หลักสูตร
	AUN2.1-3	Facebook Page สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
	AUN2.1-4	คู่มือนิสิต
	AUN2.1-5	มคอ.3 รายวิชา
	AUN2.1-6	มคอ.4 รายวิชาฝึกปฏิบัติ
	AUN2.1-7	เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Brochure)
	AUN2.1-8	รายงานการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
	AUN2.1-9	รายงานการประชุมสื่อสารหลักสูตรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
AUN-QA 2.2	AUN2.2-1	Curriculum Mapping

Criterion	รหัสหลักฐาน	เอกสารหลักฐาน
	AUN2.2-2	PLO-CLO Mapping
	AUN2.2-3	CLO-PLO Alignment Matrix
	AUN2.2-4	Teaching-Learning-Assessment Alignment Matrix
	AUN2.2-5	มคอ.3 รายวิชา
	AUN2.2-6	Blueprint การประเมินผล
	AUN2.2-7	Rubric การประเมินผล
	AUN2.2-8	รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
	AUN2.2-9	ตัวอย่างข้อสอบและการประเมิน CLO
AUN-QA 2.3	AUN2.3-1	รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
	AUN2.3-2	รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
	AUN2.3-3	แบบสำรวจผู้ใช้บัณฑิต
	AUN2.3-4	แบบสำรวจศิษย์เก่า
	AUN2.3-5	แบบสำรวจนิสิตปัจจุบัน
	AUN2.3-6	แบบสำรวจครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
	AUN2.3-7	Stakeholder Feedback Summary
	AUN2.3-8	รายงานการปรับปรุงหลักสูตรจากข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
AUN-QA 2.4	AUN2.4-1	Curriculum Mapping
	AUN2.4-2	PLO-CLO Mapping
	AUN2.4-3	Contribution Matrix ของรายวิชาต่อ PLOs
	AUN2.4-4	มคอ.3 รายวิชา
	AUN2.4-5	มคอ.4 รายวิชาฝึกปฏิบัติ
	AUN2.4-6	Blueprint การประเมินผล
	AUN2.4-7	Rubric การประเมินผล
	AUN2.4-8	รายงานผลการบรรลุ CLO
AUN-QA 2.5	AUN2.5-1	โครงสร้างหลักสูตร
	AUN2.5-2	Study Plan 4 ปี
	AUN2.5-3	Curriculum Flowchart
	AUN2.5-4	Course Sequence Diagram
	AUN2.5-5	Prerequisite Mapping
	AUN2.5-6	มคอ.2 หลักสูตร

Criterion	รหัสหลักฐาน	เอกสารหลักฐาน
	AUN2.5-7	แผนการเปิดรายวิชา
AUN-QA 2.6	AUN2.6-1	รายการวิชาเลือกเสรี
	AUN2.6-2	คู่มือนิสิต
	AUN2.6-3	รายวิชาสัมมนา
	AUN2.6-4	ภาคนิพนธ์การวิจัย
	AUN2.6-5	หัวข้อวิจัยนิสิต
	AUN2.6-6	รายงานการเลือกแหล่งฝึกตามความสนใจ
AUN-QA 2.7	AUN2.7-1	ระเบียบการทบทวนหลักสูตร
	AUN2.7-2	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
	AUN2.7-3	รายงานการประชุมพัฒนาหลักสูตร
	AUN2.7-4	รายงานวิพากษ์หลักสูตร
	AUN2.7-5	Stakeholder Survey Report
	AUN2.7-6	Employer Satisfaction Survey
	AUN2.7-7	Benchmarking Report
	AUN2.7-8	รายงานการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2569
	AUN2.7-9	CQI Report

QR CODE เอกสารหลักฐาน



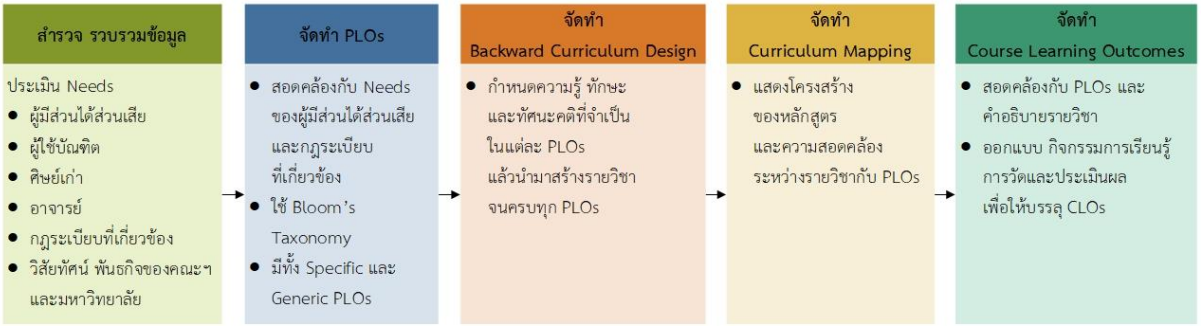
AUN - QA criterion 3 Teaching and Learning Approach

Sub Criterion 3

1. The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.
2. The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process.
3. The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students.
4. The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices).
5. The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
6. The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.
ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน

ผลการดำเนินงาน:



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ

"ประสบการณ์สร้างปัญญา (True Wisdom Springs From Lived Experiences)"

ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Learning) ควบคู่กับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะทางวิชาชีพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสังคม

หลักสูตรได้นำปรัชญาการศึกษาดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบในการออกแบบ **ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs)** การออกแบบรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดจนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

1. การสื่อสารปรัชญาการศึกษาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักสูตรสื่อสารปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางและกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่

ตารางที่ 3.1 การสื่อสารปรัชญาการศึกษาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	วิธีการสื่อสาร	หลักฐาน	ผลที่เกิดขึ้น
นิสิต	การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คู่มือนิสิต เว็บไซต์หลักสูตร ระบบ Microsoft Teams และกิจกรรมพัฒนานิสิต	รายงานการปฐมนิเทศ คู่มือนิสิต เว็บไซต์หลักสูตร	นิสิตเข้าใจปรัชญาการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	วิธีการสื่อสาร	หลักฐาน	ผลที่เกิดขึ้น
อาจารย์และบุคลากร	การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุมคณะ ระบบ E-Document และ Line Official	รายงานการประชุม มคอ.3 และ มคอ.5	อาจารย์สามารถนำปรัชญาการศึกษาไปออกแบบรายวิชา วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน	การประชุมเครือข่ายแหล่งฝึก การนิเทศงาน และการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน	รายงานการประชุมเครือข่ายแหล่งฝึก	แหล่งฝึกเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนิสิต
ผู้ใช้บัณฑิต	การประชุมวิพากษ์หลักสูตร การสำรวจความพึงพอใจ และการประชุมร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต	รายงานผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต	ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ศิษย์เก่า	แบบสอบถามออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ และการประชุมศิษย์เก่า	รายงานผลการสำรวจศิษย์เก่า	ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นและเสนอแนวทางพัฒนาหลักสูตร

2. การสะท้อนปรัชญาการศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรได้นำปรัชญา **"ประสบการณ์สร้างปัญญา"** มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การลงมือปฏิบัติ และการสะท้อนผลการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังตาราง

ตารางที่ 3.3 การสะท้อนปรัชญาการศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอน

ปรัชญาการศึกษา	การนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้	ตัวอย่างรายวิชา
ประสบการณ์สร้างปัญญา	Problem-Based Learning (PBL)	323334 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
ประสบการณ์สร้างปัญญา	Simulation-Based Learning (SBL)	323322 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง, 323326 การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง
ประสบการณ์สร้างปัญญา	Case Study-Based Learning	323314, 323315, 323324 และ 323325
ประสบการณ์สร้างปัญญา	Demonstration และ Return Demonstration	323111 และ 323321
ประสบการณ์สร้างปัญญา	Clinical Practice และ Work-based Learning	323292, 323393, 323494 และ 323495
ประสบการณ์สร้างปัญญา	Research-based Learning	323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ประสบการณ์สร้างปัญญา	Reflective Learning	323438 สัมมนา และรายวิชาฝึกงานทุกระดับ

กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ฝึกการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจทางคลินิก การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการสะท้อนผลการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและสมรรถนะของนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

3. ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2568 พบว่า รายวิชาที่เปิดสอนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีมากถึงดีเยี่ยม** โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง **4.22–4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00** สะท้อนว่าผู้เรียนรับรู้และเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ หลักสูตรยังจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1–4 รวมระยะเวลามากกว่า **2010 ชั่วโมง** โดยผลการประเมินการฝึกปฏิบัติในปีการศึกษา 2568 พบว่านิสิตผ่านการประเมินในรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามทั้ง 4 รายวิชา คิดเป็น **ร้อยละ 100** สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

4. การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: CQI)

หลักสูตรนำผลการประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะจากนิสิต อาจารย์ แหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามวงจร **Plan–Do–Check–Act (PDCA)** อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Simulation การปรับแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ และการปรับลำดับรายวิชาฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสมรรถนะของนิสิต

การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดเชิงนโยบาย แต่ได้รับการถ่ายทอดและบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมสู่การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและพร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด **Outcome-Based Education (OBE)** และ **Student-centred Learning** เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองตลอดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการวิจัย โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) และเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินกิจกรรม การประเมินผล และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมของนิสิตในการประเมินและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา นิสิตทุกคนประเมินผู้สอน รายวิชา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การให้คำปรึกษา และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

ผลการประเมินถูกนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา เพื่อวิเคราะห์และใช้ประกอบการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามวงจร **Plan–Do–Check–Act (PDCA)** อย่างต่อเนื่อง

ในปีการศึกษา 2568 ผลการประเมินรายวิชาและผู้สอนอยู่ในระดับ **ดีมากถึงดีเยี่ยม** โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง **4.22–4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00** สะท้อนว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม การให้คำปรึกษาของผู้สอน และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตารางที่ 3.2-1 ผลการประเมินรายวิชาและผู้สอน ปีการศึกษา 2568

ผลการประเมินรายวิชาและผู้สอนจากระบบประเมินของมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าทุกรายวิชามีผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีมากถึงดีเยี่ยม** โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง **4.22–4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00** ดังตาราง

รหัสวิชา	รายวิชา	จำนวนผู้ตอบ (คน)	ค่าเฉลี่ย (/ 5.00)	ระดับคุณภาพ
323142	หลักการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน	15	4.36	ดีมาก
323213	อาการวิทยาและอาการแสดงทางฉุกเฉินการแพทย์	14	4.59	ดีมาก
323243	จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	14	4.22	ดีมาก
323324	การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2	14	4.57	ดีมาก
323326	การปฏิบัติหัตถการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง	13	4.52	ดีมาก
323335	กฎหมาย จริยธรรม และนิติเวชศาสตร์	16	4.78	ดีเยี่ยม
323131	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	17	4.74	ดีเยี่ยม
323232	การยกและการเคลื่อนย้าย	17	4.65	ดีเยี่ยม
323233	การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	17	4.51	ดีมาก
323325	การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2	12	4.81	ดีเยี่ยม
323336	การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย	19	4.85	ดีเยี่ยม
323337	ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	11	4.84	ดีเยี่ยม
323438	สัมมนา	9	4.85	ดีเยี่ยม
323111	หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	16	4.38	ดีมาก
323112	การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	18	4.24	ดีมาก

รหัสวิชา	รายวิชา	จำนวนผู้ตอบ (คน)	ค่าเฉลี่ย (/ 5.00)	ระดับคุณภาพ
323191	ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน	15	4.39	ดีมาก
323393	การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2	14	4.73	ดีเยี่ยม

จากผลการประเมินพบว่า **ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.20 จากคะแนนเต็ม 5.00** สะท้อนให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับสูง

2. การมีส่วนร่วมของนิสิตในการพัฒนาหลักสูตร

ปลายปีการศึกษา 2567 หลักสูตรได้จัดประชุมร่วมระหว่างคณาจารย์และตัวแทนนิสิตทุกชั้นปี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและร่วมวางแผนการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2568 (Master Plan)

ข้อเสนอแนะจากนิสิตที่ได้รับการนำไปดำเนินการ ได้แก่

- ปรับแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและกิจกรรม Simulation ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการสำเร็จการศึกษา การสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ฉุกเฉิน และการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
- ปรับลำดับการจัดรายวิชาฝึกปฏิบัติ โดยย้ายรายวิชาการปฏิบัติการตอบโต้เหตุสาธารณภัยไปจัดในชั้นปีที่ 3 เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาสมรรถนะด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของนิสิตชั้นปีที่ 4

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านิสิตมีบทบาทในการเสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม

ตารางที่ 3.2-2 การนำข้อเสนอแนะของนิสิตไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน (CQI)

ข้อเสนอแนะจากนิสิต	การดำเนินการของหลักสูตร	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ต้องการให้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามสอดคล้องกับช่วงเวลาการสอบใบประกอบวิชาชีพ	ปรับ Master Plan และตารางฝึกภาคสนามให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการสำเร็จการศึกษาและการสอบใบประกอบวิชาชีพ	นิสิตสามารถเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและเข้าสอบได้ตามแผน
ต้องการเพิ่มเวลาฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง (Simulation)	ปรับตารางเรียนและเพิ่มกิจกรรม Simulation ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง	นิสิตได้รับโอกาสฝึกทักษะก่อนขึ้นฝึกภาคสนาม เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะจากนิสิต	การดำเนินการของหลักสูตร	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เสนอให้แยกรายวิชาการตอบโต้เหตุสาธารณภัยออกจากการฝึกงานชั้นปีที่ 4	ปรับย้ายรายวิชาการปฏิบัติการตอบโต้เหตุสาธารณภัยไปจัดในชั้นปีที่ 3	นิสิตชั้นปีที่ 4 มีเวลาฝึกสมรรถนะทางคลินิกในรายวิชาฝึกงานได้มากขึ้น
ต้องการเพิ่มโอกาสฝึกหัตถการพื้นฐานก่อนขึ้นฝึกงาน	เพิ่มการฝึกในห้องปฏิบัติการ (Skills Laboratory) เช่น การเจาะเลือด การฝึกใน OPD, IPD และ ER	นิสิตมีทักษะพื้นฐานที่พร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม และผ่านการประเมินการฝึกงานครบทุกคน

จากผลการประเมินรายวิชาและผู้สอน รวมทั้งการนำข้อเสนอแนะของนิสิตเข้าสู่กระบวนการพัฒนาหลักสูตร พบว่าหลักสูตรมีระบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการประเมินรายวิชา การเสนอความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง **Continuous Quality Improvement (CQI)**

3. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการวิจัย

หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Experiential Learning) และการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning)

ในรายวิชา **323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน** นิสิตเป็นผู้เลือกหัวข้อวิจัยตามความสนใจ ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การกำหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2568 นิสิตดำเนินโครงงานวิจัยจำนวน **12 เรื่อง** ครอบคลุมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พิษวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

ตารางที่ 3.2-3 โครงงานวิจัยของนิสิต ปีการศึกษา 2568

ลำดับ	หัวข้อวิจัย	กลุ่มสาขา
1	การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของยาที่ออกฤทธิ์จำเพาะต่อไมเกรนในการรักษาไมเกรนที่สัมพันธ์กับรอบเดือน	Systematic Review & Meta-analysis

ลำดับ	หัวข้อวิจัย	กลุ่มสาขา
2	การทบทวนอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดกับเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
3	กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของภาวะเลือดออกในตับจากอะเซตามิโนเฟน และผลการรักษาด้วยเอ็น-อะเซทิลซิสเทอีนในหนูทดลอง	พิษวิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์
4	การประเมินอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการก่อกลายพันธุ์ที่นำไปสู่การก่อมะเร็งจาก PM2.5 ในเซลล์ HepG2	วิทยาศาสตร์การแพทย์
5	การประเมินฤทธิ์การกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากดอกงิ้ว	วิทยาศาสตร์การแพทย์
6	ผลของการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ต่อความรู้และความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	การศึกษาทางการแพทย์ฉุกเฉิน
7	ฤทธิ์ป้องกันสมองของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ในหนูที่ได้รับอะเซตามิโนเฟนเกินขนาดแบบเฉียบพลัน	เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์
8	ฤทธิ์ต้านภาวะดื้อต่ออินซูลินของเนเฟอรีนที่หัวใจของหนูที่เป็นโรคเบาหวานจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง	เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์
9	การประเมินการให้การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการจราจรโดยหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
10	ผลของการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังได้รับบาดแผลจากสัตว์	สาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับ	หัวข้อวิจัย	กลุ่มสาขา
11	การพัฒนาผงโจ๊กฟังก์ชันจากข้าวสีแดงและข้าวสีม่วงดำที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและโปรตีนสูง	นวัตกรรมด้านสุขภาพและอาหาร
12	ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการจัดการภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอแม่กา จังหวัดพะเยา	การส่งเสริมสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ

จากตารางที่ 3.2-3 พบว่าโครงงานวิจัยของนิสิตครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การศึกษาทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษวิทยา เภสัชวิทยา สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ โดยนิสิตมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกหัวข้อ การออกแบบการศึกษา การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอผลงาน ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งผลให้นิสิตพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา

4. การเรียนรู้ผ่านการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

หลักสูตรจัดให้นิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1–4 โดยนิสิตมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจริงภายใต้การกำกับของอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ได้ฝึกการตัดสินใจทางคลินิก การสื่อสาร การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และการสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflection) ภายหลังการฝึกปฏิบัติ

ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในปีการศึกษา 2568 พบว่านิสิตผ่านการประเมิน **ร้อยละ 100** ในรายวิชาฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1–4 สะท้อนถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด

5. ผลลัพธ์ของการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CQI)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้นิสิตสามารถวางแผนการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่น และประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะจากนิสิตและผลการประเมินรายวิชาถูกนำเข้าสู่กระบวนการ **Continuous Quality Improvement (CQI)** อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลักสูตรมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรม Simulation และการฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของวิชาชีพ

ตารางที่ 3.2-4 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตตามชั้นปี

ชั้นปี	รายวิชา	แหล่งฝึก/ลักษณะการฝึก	สมรรถนะที่พัฒนา	ผลการประเมิน
ปี 1	**323292 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1**	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, Skills Laboratory, OPD, IPD และ ER	การประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และหัตถการพื้นฐาน	**ผ่าน 100%**
ปี 2	**323393 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2**	หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และห้องฉุกเฉิน (ER)	การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม	**ผ่าน 100%**
ปี 3	**323494 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3**	โรงพยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ALS) การปฏิบัติหัตถการขั้นสูง และการตัดสินใจทางคลินิก	**ผ่าน 100%**
ปี 4	**323495 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4**	โรงพยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	การปฏิบัติงานในบทบาทนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ภาวะผู้นำ และการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ	**ผ่าน 100%**

หลักสูตรจัดการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1–4 โดยออกแบบให้สมรรถนะของผู้เรียนพัฒนาอย่างเป็นลำดับจากทักษะพื้นฐานสู่การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น นิสิตได้รับการกำกับดูแลจากอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก พร้อมทั้งได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ของรายวิชา ผลการประเมินในปีการศึกษา 2568 พบว่านิสิตผ่านการประเมินในรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามทั้ง 4 รายวิชา คิดเป็น **ร้อยละ 100** สะท้อนถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะวิชาชีพตามที่หลักสูตรกำหนด

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับผู้เรียน

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนโดยยึดแนวคิด **Outcome-Based Education (OBE)** และ **Student-centred Learning** เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Active Learning) และพัฒนาสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียศิลป์ การส่งเสริมสุขภาพ และทักษะวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centred Learning) โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็น **Facilitator** สนับสนุนให้นิสิตแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ปัญหา ลงมือปฏิบัติ สะท้อนผลการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนและทีมสหวิชาชีพ ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้

- **Problem-Based Learning (PBL)** นิสิตวิเคราะห์ปัญหา สืบค้นข้อมูล และนำเสนอแนวทางแก้ไขในรายวิชาการวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน (323334) และภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (323337)
- **Simulation-Based Learning (SBL)** นิสิตฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ALS) การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุหมู่ และการจัดการสาธารณภัย พร้อมรับการอภิปรายสะท้อนผลการเรียนรู้ (Debriefing)
- **Case Study-Based Learning** นิสิตวิเคราะห์กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริงของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาการตัดสินใจทางคลินิก
- **Team-Based Learning (TBL)** นิสิตทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
- **Demonstration และ Return Demonstration** นิสิตฝึกปฏิบัติหัตถการทางการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน
- **Clinical Practice / Work-Based Learning** นิสิตฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมระยะเวลามากกว่า **1,950 ชั่วโมง**
- **Reflective Learning** นิสิตจัดทำ Reflection Report และอภิปรายร่วมกับอาจารย์และพี่เลี้ยงภายหลังการฝึกปฏิบัติ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และกำหนดแนวทางพัฒนาตนเอง

ตารางที่ 3.3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568

รูปแบบ Active Learning	รายวิชา	รหัสวิชา	PLOs ที่เกี่ยวข้อง	วิธีการประเมินผล
Problem-Based Learning (PBL)	การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน	323334	PLO3, PLO5, PLO7	รายงานวิจัย การนำเสนอผลงาน
Problem-Based Learning (PBL)	ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	323337	PLO3, PLO5, PLO7	รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์
Simulation-Based Learning (SBL)	การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	323322	PLO3, PLO4, PLO8	การประเมินสถานการณ์จำลอง (Simulation Assessment)
Simulation-Based Learning (SBL)	การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง	323326	PLO3, PLO4, PLO5, PLO8	OSCE และ Reflection Report
Simulation-Based Learning (SBL)	การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย	323336	PLO3, PLO4, PLO5, PLO8	การประเมินสถานการณ์จำลองภัยพิบัติ

รูปแบบ Active Learning	รายวิชา	รหัสวิชา	PLOs ที่เกี่ยวข้อง	วิธีการประเมินผล
Case Study-Based Learning	การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1	323314	PLO2, PLO3, PLO8	การวิเคราะห์กรณีศึกษา
Case Study-Based Learning	การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2	323324	PLO2, PLO3, PLO8	Case Analysis
Case Study-Based Learning	การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1	323315	PLO2, PLO3, PLO8	การวิเคราะห์กรณีศึกษา
Case Study-Based Learning	การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2	323325	PLO2, PLO3, PLO8	Scenario-Based Assessment
Demonstration & Return Demonstration	หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	323111	PLO2, PLO8	Skill Checklist
Demonstration & Return Demonstration	เทคนิคหัตถการ 1	323212	PLO2, PLO8	Practical Examination
Demonstration & Return Demonstration	หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง	323321	PLO2, PLO8	OSCE
Team-Based Learning (TBL)	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	323131	PLO3, PLO4, PLO5	Group Assignment
Team-Based Learning (TBL)	การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	323322	PLO4, PLO8	Team Performance Assessment
Project-Based Learning	การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน	323334	PLO3, PLO5, PLO7	โครงงานวิจัย
Project-Based Learning	ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	323337	PLO3, PLO5, PLO7	วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
Reflective Learning	สัมมนา	323438	PLO3, PLO4, PLO5	Reflection Report
Reflective Learning	การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2	323393	PLO1, PLO3, PLO4, PLO8	Reflective Report
Reflective Learning	การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3	323494	PLO1, PLO3, PLO4, PLO8	Reflective Report
Reflective Learning	การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4	323495	PLO1, PLO3, PLO4, PLO8	Reflective Report

รูปแบบ Active Learning	รายวิชา	รหัสวิชา	PLOs ที่เกี่ยวข้อง	วิธีการประเมินผล
Clinical Practice / Work-Based Learning	การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2	323393	PLO1, PLO3, PLO4, PLO8	Practicum Assessment
Clinical Practice / Work-Based Learning	การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3	323494	PLO1, PLO3, PLO4, PLO8	Preceptor Evaluation
Clinical Practice / Work-Based Learning	การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4	323495	PLO1, PLO3, PLO4, PLO8	Clinical Competency Assessment

หลักสูตรจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Active Learning อย่างหลากหลาย ได้แก่ Problem-Based Learning (PBL), Simulation-Based Learning (SBL), Case Study-Based Learning, Team-Based Learning (TBL), Project-Based Learning, Reflective Learning และ Clinical Practice เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อันนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 3.4 ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

รูปแบบการเรียนรู้	สมรรถนะที่พัฒนา	หลักฐานการประเมิน
Problem-Based Learning	การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา	รายงานวิจัย การนำเสนอผลงาน
Simulation-Based Learning	การตัดสินใจทางคลินิกและการทำงานเป็นทีม	Simulation Assessment, OSCE
Case Study-Based Learning	Clinical Reasoning	Case Analysis
Team-Based Learning	การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น	Group Assignment, Team Assessment
Demonstration & Return Demonstration	ทักษะหัตถการ	Skill Checklist, Practical Examination
Clinical Practice	สมรรถนะวิชาชีพ	Practicum Assessment, Preceptor Evaluation
Reflective Learning	การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาตนเอง	Reflection Report

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และสมรรถนะทางวิชาชีพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

ในปีการศึกษา 2568 รายวิชาที่เปิดสอนมีผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ **ดีมากถึงดีเยี่ยม** โดยมีคะแนนเฉลี่ย **4.22–4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00** และนิสิตผ่านการประเมินรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามทั้ง 4 รายวิชา คิดเป็น **ร้อยละ 100** สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสามารถส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)

หลักสูตรนำผลการประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะจากนิสิต และผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามวงจร **Plan–Do–Check–Act (PDCA)** อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่มกิจกรรม Simulation การปรับรูปแบบ Debriefing และการเพิ่มการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการก่อนการฝึกภาคสนาม เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงมากยิ่งขึ้น

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ ทักษะในการรับและประมวลผลข้อมูล การนำเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ และแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ)

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตามแนวคิด **Outcome-Based Education (OBE)** และปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา **"ประสบการณ์สร้างปัญญา (True Wisdom Springs From Lived Experiences)"**

หลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) โดยเฉพาะ

- **PLO3** การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสร้างองค์ความรู้
- **PLO4** การแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- **PLO5** การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศทางวิชาการอย่างเหมาะสม
- **PLO7** การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Lifelong Learning

หลักสูตรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด **Learning how to learn** ผ่านการค้นคว้า วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ และสะท้อนผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. Information Literacy

นิสิตได้รับการฝึกสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวิชาการและวารสารนานาชาติ เพื่อค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Practice) ในรายวิชาการวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน (323334) และภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (323337)

2. Critical Inquiry and Critical Thinking

นิสิตฝึกตั้งคำถาม วิเคราะห์สถานการณ์ และเลือกแนวทางการดูแลผู้ป่วยจากกรณีศึกษา การเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning (PBL) และสถานการณ์จำลอง (Simulation-Based Learning) เพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และการตัดสินใจทางคลินิก

3. Research-based Learning

นิสิตทุกคนดำเนินโครงงานวิจัยหรือภาคนิพนธ์ โดยเป็นผู้กำหนดประเด็นวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลงานด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ในปีการศึกษา 2568 นิสิตจัดทำโครงงานวิจัยจำนวน **12 เรื่อง** ครอบคลุมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษวิทยา สาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพ

4. Experiential Learning

นิสิตฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมระยะเวลามากกว่า **2010 ชั่วโมง** พร้อมเรียนรู้การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

5. Reflective Learning

ภายหลังการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง นิสิตจัดทำ Reflection Report เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เรียนรู้ ประเมินตนเอง และกำหนดแผนพัฒนาตนเองสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต

ตารางที่ 3.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรมการเรียนรู้	รายวิชาที่เกี่ยวข้อง	ทักษะที่พัฒนา
การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์	323334 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน	Information Literacy, Evidence-based Practice
การจัดทำภาคนิพนธ์และโครงงานวิจัย	323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	Critical Thinking, Research Skills
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ	323438 สัมมนา	Communication Skills, Scientific Presentation
การเขียน Reflection Report	323393, 323494, 323495	Self-directed Learning, Self-reflection
การวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง	323326 การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง	Clinical Reasoning, Decision Making
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง	323393, 323494, 323495	Experiential Learning, Adaptability
การทำงานเป็นทีม	รายวิชาฝึกปฏิบัติและรายวิชาวิจัย	Collaboration, Leadership

กิจกรรมการเรียนรู้	รายวิชาที่เกี่ยวข้อง	ทักษะที่พัฒนา
การใช้ Microsoft Teams และ ฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย	ทุกรายวิชา	Digital Literacy, Lifelong Learning

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวส่งเสริมให้นิสิตสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและการทำวิจัย

ในปีการศึกษา 2568 นิสิตทุกคนได้ดำเนินโครงงานวิจัยหรือภาคนิพนธ์ และนำเสนอผลงานทางวิชาการในรายวิชาสัมมนา (323438) ขณะที่ผลการประเมินรายวิชาในภาพรวมอยู่ในระดับ **ดีมาก (4.22–4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00)** สะท้อนถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)

หลักสูตรนำข้อเสนอแนะจากนิสิต ผลการประเมินรายวิชา และผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเพิ่มการใช้ฐานข้อมูลวิชาการ การฝึกการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ การจัดกิจกรรม Reflection และการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าเสนอแนวทางใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาในระบบบริการสุขภาพและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยบูรณาการแนวคิดด้าน **Creativity, Innovation, Problem-solving, Design Thinking และ Entrepreneurial Mindset** ไว้ในรายวิชาวิจัย รายวิชาภาคนิพนธ์ รายวิชาสถานการณ์จำลอง รายวิชาสาธารณภัย และรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ เพื่อให้นิสิตสามารถมองเห็นปัญหาในสถานการณ์จริง ออกแบบแนวทางแก้ไข และพัฒนาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย ชุมชน และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

หลักสูตรดำเนินการผ่านกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1. **Project-based Learning และ Research-based Learning**
   นิสิตจัดทำโครงงานวิจัยและภาคนิพนธ์ในรายวิชา **323334 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน** และ **323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน** โดยเริ่มจากการระบุปัญหา ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลงาน ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการสร้างองค์ความรู้ใหม่
2. **Design Thinking และ Problem-solving**
   ในรายวิชา **323326 การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง** และ **323336 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย** นิสิตฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉิน ออกแบบแนวทางการตอบโต้ วางแผนจัดการทรัพยากร และทดลองใช้แนวทางแก้ไขในสถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงระบบ
3. **Simulation-based Innovation**
   นิสิตเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง เช่น อุบัติเหตุหมู่ ภัยพิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง และการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อฝึกการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดของเวลา ทรัพยากร และความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดเชิงนวัตกรรมในระบบ EMS
4. **Academic Presentation and Knowledge Translation**
   ในรายวิชา **323438 สัมมนา** นิสิตนำเสนอผลงานวิจัยหรือแนวคิดพัฒนางานต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น ฝึกการสื่อสารเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการปรับปรุงแนวคิดจากข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริง
5. **Learning from Real EMS Contexts**
   ในรายวิชาฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นิสิตเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในโรงพยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทำให้สามารถมองเห็นปัญหาเชิงระบบ เช่น การสื่อสาร การประสานงาน การใช้ทรัพยากร และความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมและแนวทางปรับปรุงบริการ

ตารางที่ 3.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ

กิจกรรมการเรียนรู้	รายวิชาที่เกี่ยวข้อง	สมรรถนะที่พัฒนา
การจัดทำโครงงานวิจัยและภาคนิพนธ์	323334 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน, 323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิจัย การแก้ปัญหา และการสร้างองค์ความรู้ใหม่
การใช้ Design Thinking และ Problem-solving	323326 การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง, 323336 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย	การออกแบบแนวทางแก้ปัญหาใหม่ การคิดเชิงระบบ และการจัดการทรัพยากร
การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง	323322 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง, 323326 การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง,	การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการทดลองแนวทางปฏิบัติใหม่

กิจกรรมการเรียนรู้	รายวิชาที่เกี่ยวข้อง	สมรรถนะที่พัฒนา
	323336 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย	
การนำเสนอผลงานวิจัยและแนวคิดพัฒนางาน	323438 สัมมนา, 323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	การสื่อสารเชิงวิชาการ การรับข้อเสนอแนะ และการต่อยอดผลงาน
การทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการโครงการ	รายวิชาวิจัย รายวิชาภาคนิพนธ์ รายวิชาสถานการณ์จำลอง และรายวิชาฝึกงาน	ภาวะผู้นำ การบริหารเวลา การจัดการทรัพยากร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
การเรียนรู้จากปัญหาจริงในระบบ EMS	323292, 323393, 323494 และ 323495 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	การมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงบริการ การคิดเชิงนวัตกรรม และ Entrepreneurial Mindset
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางาน	ทุกรายวิชาผ่านระบบ Microsoft Teams ฐานข้อมูลออนไลน์ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	Digital Literacy การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน

ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2568 นิสิตได้ดำเนินโครงงานวิจัยจำนวน **12 เรื่อง** ครอบคลุมประเด็นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษวิทยา เภสัชวิทยา สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ สะท้อนให้เห็นว่านิสิตสามารถเลือกประเด็นปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาแนวคิดหรือองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อบริบทของระบบสุขภาพและชุมชน

นอกจากนี้ ผลการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ภาคนิพนธ์ สัมมนา สถานการณ์จำลอง และการฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง **4.22–4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00** และนิสิตผ่านรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามครบทุกชั้นปี คิดเป็น **ร้อยละ 100** สะท้อนถึงประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทจริง

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนำผลการประเมินรายวิชา ผลการประเมินภาคนิพนธ์ ข้อเสนอแนะจากนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และแหล่งฝึกปฏิบัติงานเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนำมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มกิจกรรมสถานการณ์จำลอง การส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัย การใช้ปัญหาจริงจากระบบ EMS เป็นโจทย์การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานดังกล่าวช่วยให้นิสิตมีโอกาสพัฒนาความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการริเริ่มพัฒนางาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สามารถพัฒนาระบบบริการและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างยั่งยืน

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก Outcome-Based Education (OBE) และดำเนินการตามวงจรคุณภาพ Plan–Do–Check–Act (PDCA) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และบริบทของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่การออกแบบรายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ซึ่งกำหนดความเชื่อมโยงระหว่าง Course Learning Outcomes (CLOs) กับ Programme Learning Outcomes (PLOs) พร้อมกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

ระหว่างการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนติดตามผลการเรียนรู้ของนิสิตจากผลการประเมินระหว่างเรียน ผลการสอบ ผลการประเมินทักษะปฏิบัติ ผลการประเมินจากอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะจากนิสิต เพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เพื่อรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชา จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 มาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง CLOs – Learning Activities – Assessment – PLOs ก่อนนำผลเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป

นอกจากข้อมูลจากรายวิชาแล้ว หลักสูตรยังรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์พี่เลี้ยง แหล่งฝึกปฏิบัติงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของวิชาชีพและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล และแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 3.6 การนำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการปรับปรุง	ผลการดำเนินงาน
นิสิตเสนอให้เพิ่มการฝึกก่อนขึ้นฝึกภาคสนาม	เพิ่มการฝึกในห้องปฏิบัติการทักษะ (Skills Laboratory) ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน โดยฝึกการเจาะเลือด การให้สารน้ำ และการฝึกปฏิบัติใน OPD, IPD และ ER	นิสิตมีความพร้อมในการปฏิบัติหัตถการพื้นฐานก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริง
แหล่งฝึกเสนอให้เพิ่มการฝึกสถานการณ์จำลอง	เพิ่มกิจกรรม Simulation-Based Learning และปรับสถานการณ์จำลองให้สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานของ EMS และห้องฉุกเฉิน	นิสิตมีความมั่นใจในการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมก่อนการฝึกภาคสนาม
ผู้ใช้บัณฑิตเสนอให้เพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการสาธารณภัย	ปรับปรุงรายวิชา 323336 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย ให้สอดคล้องกับแนวทางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)	เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
แหล่งฝึกเสนอให้เพิ่มทักษะ ECG Interpretation	เพิ่มกิจกรรม Workshop และกรณีศึกษาด้านการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง	นิสิตสามารถวิเคราะห์และแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
ผู้ใช้บัณฑิตและแหล่งฝึกเสนอให้เพิ่มทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม	เพิ่มกิจกรรม Team-Based Learning (TBL) และการเรียนรู้ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education: IPE)	นิสิตพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ และการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม	สนับสนุนการจัดทำโครงงานวิจัย ภาคนิพนธ์ และการนำเสนอผลงานในรายวิชา 323334, 323337 และ 323438	นิสิตจัดทำโครงงานวิจัยจำนวน 12 เรื่อง และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรได้ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่เปิดสอนทุกหมวดวิชา โดยใช้ข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 ประกอบการวิเคราะห์ พบว่ารายวิชาทั้งหมดมีความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ผลการประเมินรายวิชาและผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.22–4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00 ขณะที่นิสิตผ่านการประเมินรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามทั้ง 4 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะของวิชาชีพภายใต้การประเมินของอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง

นอกจากนี้ นิสิตได้จัดทำโครงงานวิจัยจำนวน 12 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษวิทยา การส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สะท้อนถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงและการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตและแหล่งฝึกปฏิบัติงานพบว่า บัณฑิตมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติวิชาชีพ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตได้

การวิเคราะห์ผลและการปรับปรุงคุณภาพ (Continuous Quality Improvement: CQI)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก มคอ.5 มคอ.6 ผลการทวนสอบรายวิชา ผลการประเมินรายวิชา ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และความต้องการของวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังคงดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. เพิ่มการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทักษะก่อนการฝึกภาคสนาม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความพร้อมของนิสิต
2. เพิ่มกิจกรรม Simulation-Based Learning และสถานการณ์จำลองที่มีความซับซ้อนสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานจริง
3. ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัยและอุบัติภัยหมู่ให้ทันต่อมาตรฐานวิชาชีพและสถานการณ์ปัจจุบัน
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
5. สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิต เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและชุมชน

การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า หลักสูตรมีกลไกการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ใช้ข้อมูลจากการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นฐานในการปรับปรุง และเชื่อมโยงผลการดำเนินงานกลับเข้าสู่การวางแผนในรอบปีการศึกษาถัดไปตามวงจร **PDCA** ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของวิชาชีพ และสามารถสนับสนุนให้นิสิตบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผลการประเมินตนเอง

AUN-QA Criterion 3 – Checklist	ระดับ 2568
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.	4
3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process.	4
3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students.	4
3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices).	4
3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.	4
3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.	4
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)	**4**

ตารางสรุปเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน AUN-QA Criterion 3.1–3.6

Criterion	รหัสหลักฐาน	เอกสารหลักฐาน
AUN-QA 3.1	AUN3.1-1	ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาหลักสูตร
	AUN3.1-2	มคอ.2 หลักสูตร
	AUN3.1-3	คู่มือนิสิต
	AUN3.1-4	เว็บไซต์หลักสูตร
	AUN3.1-5	เอกสารปฐมนิเทศนิสิต
	AUN3.1-6	เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
AUN-QA 3.2	AUN3.2-1	มคอ.3 รายวิชา
	AUN3.2-2	แผนการจัดการเรียนรู้
	AUN3.2-3	รายงานผลประเมินรายวิชาโดยนิสิต
	AUN3.2-4	Student Feedback Form
	AUN3.2-5	รายงานการประชุมสะท้อนผลการเรียนรู้

	AUN3.2-6	หลักฐานการมีส่วนร่วมของนิสิต
AUN-QA 3.3	AUN3.3-1	รายงานกิจกรรม Active Learning
	AUN3.3-2	Problem-Based Learning (PBL)
	AUN3.3-3	Case-Based Learning
	AUN3.3-4	Simulation-Based Learning
	AUN3.3-5	OSCE Activities
	AUN3.3-6	รายงานผลการประเมิน Active Learning
AUN-QA 3.4	AUN3.4-1	รายวิชาวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
	AUN3.4-2	ภาคนิพนธ์การวิจัย
	AUN3.4-3	Journal Club
	AUN3.4-4	Evidence-Based Practice Activities
	AUN3.4-5	รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
	AUN3.4-6	ผลงานวิจัยนิสิต
AUN-QA 3.5	AUN3.5-1	โครงงานนวัตกรรมของนิสิต
	AUN3.5-2	ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
	AUN3.5-3	รายงานการประกวดนวัตกรรม
	AUN3.5-4	รายงานการพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน
	AUN3.5-5	หลักฐานการส่งเสริม Entrepreneurial Mindset
AUN-QA 3.6	AUN3.6-1	รายงานผลประเมินรายวิชา
	AUN3.6-2	มคอ.5
	AUN3.6-3	มคอ.6
	AUN3.6-4	มคอ.7
	AUN3.6-5	รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
	AUN3.6-6	รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
	AUN3.6-7	CQI Report
	AUN3.6-8	PDCA Improvement Report
	AUN3.6-9	Stakeholder Feedback Report

QR CODE เอกสารหลักฐาน

AUN-QA 4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives.
มีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ผลการดำเนินงาน:

การจัดการศึกษาของคณะฯ ได้ยึดหลักไตรยางค์ทางการศึกษา โดยเริ่มที่การกำหนด PLOs ของหลักสูตร ถ่ายทอดลงสู่ CLOs รายวิชาแต่ละรายวิชาออกแบบการเรียนรู้ให้สอดรับกับ CLOs และออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละ CLOs และเนื่องด้วยแต่ละรายวิชารับผิดชอบ CLOs ที่แตกต่างกันวิธีการจัดการเรียนรู้จึงมีความหลากหลายแตกต่างกัน อีกทั้งการประเมินผลการเรียนรู้มีความหลากหลายสอดรับกับวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้แน่ใจได้ว่า การจัดการศึกษาจะบรรลุ CLOs ซึ่งนำไปสู่การบรรลุ PLO ตามลำดับ ในปีการศึกษา 2568 คณะฯ จัดการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีการปรับกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินจากที่พบว่าในการจัดการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในแต่ละรายวิชามีกลยุทธ์การสอนและการประเมินที่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้สอนได้นำไปใช้จัดการศึกษาตาม CLOs ที่แต่ละรายวิชารับผิดชอบ ทำให้ลดปัญหาความหลากหลายของการเขียนกลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินได้ เพราะอาจารย์ทุกท่านมีความเข้าใจตรงกัน

เพื่อให้การจัดการศึกษามีการกลยุทธ์การเรียนการสอนและการประเมินผลที่สอดคล้องกับ PLOs CLOs คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ก่อนเปิดภาคการศึกษาผู้รับผิดชอบรายวิชาและรองผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอนแต่ละรายวิชาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ นำเสนอ มคอ.3, 4 ในการประชุมภาควิชาแล้วจึงนำเสนอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลตลอดจนสัดส่วนการประเมินผลในแต่ละ CLOs ระหว่างภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเป็นผู้กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนการประเมินผลผู้เรียนของอาจารย์ผู้สอน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการรวบรวมผลการประเมินจากผู้สอนตัดเกรดตามแนวทางของคณะฯ/มหาวิทยาลัยฯ

การดำเนินการเป็นไปในปีการศึกษา 2568 สำหรับหลักสูตรปรับปรง พ.ศ. 2564 ดำเนินการเช่นเดียวกันแต่เพิ่มเติม คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการสอบวัดสมรรถนะรายชั้นปี เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตารางที่ 4.1-1 ตัวอย่างรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผล ที่หลากหลายและสอดคล้องกับ PLO

รายวิชา	การวัดและประเมินผล
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	สอบเก็บคะแนนในคาบเรียน (กลุ่ม, รายบุคคล)
	การสอบประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)
	การสอบวัดผลระหว่างภาคและปลายภาค (MCQ)
การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง	การสอบประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)
	การสอบวัดผลระหว่างภาคและปลายภาค (MCQ)

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2	สอบเก็บคะแนนในคาบเรียน (กลุ่ม,รายบุคคล)
	การสอบประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)
	การสอบวัดผลระหว่างภาคและปลายภาค (MCQ)
	เก็บคะแนน Logbook (ขณะขึ้นปฏิบัติงานในโรงพยาบาล)

AUN-QA 4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to students and applied consistently.

การประเมินผลและนโยบายการอุทธรณ์ผลการประเมินถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน มีการสื่อสารไปยังผู้เรียนและนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงาน:

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความโปร่งใสของการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จึงได้กำหนดนโยบายการประเมินผลและการอุทธรณ์ผลการประเมินที่แสดงไว้ในกลไกการบริหารหลักสูตร โดยกำหนดให้ในคาบแรกของการเรียนแต่ละวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชาปฐมนิเทศ ให้ข้อมูลก่อนการเรียนเพื่อให้นิสิตทุกคนได้รับทราบรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ คำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา CLOs วิธีการเรียนการสอนในรายวิชา วิธีการประเมินผล สัดส่วนของคะแนน ตารางสอน กำหนดการสอบ และรายละเอียดอื่น ๆ ของรายวิชาตาม มคอ.3, 4 และขั้นตอนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ และจัดทำเป็นคู่มือรายวิชาที่นิสิตและผู้สอนทุกคนเข้าถึงได้ ทั้งนี้ระหว่างภาคการศึกษาในการสอบวัดประเมินผลแต่ละครั้ง ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะแจ้งผลคะแนนให้นิสิตทราบเป็นรายบุคคล และหากนิสิตมีความสงสัยสามารถแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ทันที เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนคณะฯ มีขั้นตอนการนำเสนอผลการตัดเกรดและการอุทธรณ์ผลการเรียน ดำเนินการโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้

1. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมคะแนนจากทุกส่วน ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในทุกรายวิชาประชุมผู้สอน เพื่อวิพากษ์เกรด นำข้อมูลลงระบบการตัดเกรดตัดเกรดในระบบ REG

2. ผู้รับผิดชอบรายวิชานำเสนอเกรดต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาความถูกต้องของที่มาของคะแนนการคิดคำนวณ สัดส่วนคะแนนตามที่กำหนดตาม มคอ.3, 4

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาและให้การรับรองผลการเรียน

4. ผู้รับผิดชอบรายวิชา Submit ในระบบ REG และพิมพ์เอกสารยืนยันเกรด ตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนามเสนอผลการเรียนต่อประธานหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี อนุมัติเกรด แล้วฝ่ายบริการทางการศึกษาของคณะฯ นำส่งเอกสารเกรดต่องานระเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย ประกาศเกรดแก่นิสิต

5. เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ผลการเรียน หลังทราบผลการเรียน 1 สัปดาห์

6. กรณีต้องการอุทธรณ์ผลการเรียน นิสิตสามารถเขียนบันทึกข้อความหรือแจ้งด้วยวาจาเสนอต่อผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สายตรงคณบดี อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการเรียนให้นิสิตโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนิสิตและผู้รับผิดชอบรายวิชา

7. ผู้รับทราบเรื่องอุทธรณ์แจ้งต่อผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชาทำการทวนสอบคะแนน

- กรณีผลการประเมินผลการเรียนรู้มีความถูกต้องสอดคล้องกับคะแนนผลการเรียน ผู้รับผิดชอบรายวิชา แจ้งผลกับนิสิตและให้นิสิตเซ็นรับทราบผลเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งต่อประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

- กรณีผลการประเมินผลการเรียนไม่ถูกต้องตามข้อร้องเรียน ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการแก้ไขโดยผ่านการรับรองของประธานหลักสูตร นำเข้าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเกรดอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามข้อ 4 อีกครั้ง และให้นิสิตเซ็นรับทราบผลเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้ ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์จากการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แต่ละปีการศึกษา และคู่มือนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่มีนิสิตอุทธรณ์ผลการเรียนในรายวิชาที่สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รับผิดชอบ

AUN-QA 4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.

มีการกำหนดมาตรฐานของการประเมินผลและขั้นตอนการประเมินผู้เรียนที่ชัดเจนสำหรับติดตามความก้าวหน้าและการสำเร็จการศึกษาของผู้เรียนและมีการสื่อสารไปยังผู้เรียน ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงาน:

คณะฯจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564จากเล่มคู่มือนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2566ซึ่งมีเนื้อหาสาระเรื่องระบบการศึกษาการรับเข้าและการขึ้นทะเบียนนิสิตหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษาการลงทะเบียนศึกษารายวิชาการวัดผลการศึกษาการจำแนกสถานภาพทางวิชาการและฐานะชั้นปีของนิสิตการลาพักการศึกษาและการพักการศึกษาการกระทำผิดเกี่ยวกับการศึกษาการพ้นสภาพนิสิตการสำเร็จการศึกษาและการให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลข้อบังคับที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาที่สำคัญได้แก่การสำเร็จการศึกษา ข้อ 36 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี

(1) ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

(2) นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(2.1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P

(2.2) ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้

(2.2.1) การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 2 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

(2.2.2) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

(2.2.3) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

(2.2.4) หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

(2.2.5) หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเต็มเวลา

(2.2.6) นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือประสบการณ์วิชาชีพต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

(2.3) มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

(2.4) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย

(2.5) ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย

(3) ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอสำเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป

(4) นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 (2) แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนิสิตที่โอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(4.1) มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดันดับสอง

(4.2) ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใด ข้อบังคับดังกล่าวจะถูกสื่อสารให้ผู้เรียนทราบผ่านการปฐมนิเทศ คู่มือนิสิต website ของมหาวิทยาลัยฯ และมีการสื่อสารต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และ การสื่อสารผ่านการสอนงาน (coaching) ของอาจารย์พี่เลี้ยงที่สาขาวิชามอบหมายให้ดูแลอาจารย์ใหม่เพื่อให้มั่นใจได้ว่านิสิตจะสำเร็จการศึกษา ตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด คณะฯ มีระบบการดูแลนิสิตและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนหลายระดับ ได้แก่

ระดับผู้เรียน - มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา (Academic Advisor) ให้ดูแลนิสิตตั้งแต่แรกเข้าศึกษาและดูแลติดตามเนื่องจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาการดูแลนิสิตครอบคลุมทั้งเรื่องการเรียนสุขภาพและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ ติดตามผลการเรียนนิสิตได้จากระบบ REG ซึ่งเปิดสิทธิให้อาจารย์เข้าถึงข้อมูลผลการเรียนของนิสิตได้

ระดับรายวิชา - ผู้รับผิดชอบรายวิชาในรายวิชาทฤษฎีเมื่อประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ถ้าพบนิสิตที่มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ60ของการประเมินแต่ละครั้งจะดำเนินการสอบถามประเมินปัญหาและให้การดูแล ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ต่อไป สำหรับรายวิชายวิชาภาคปฏิบัติหากนิสิตได้รับผลการประเมินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ80ของการประเมินหรือมีความแตกต่างกันของผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติจะดำเนินการประชุมหารือให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสิตเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์สำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาค หากนิสิตมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดรายวิชาจะจัดให้มีการสอบแก้ตัวหรือการประเมินซ้ำตามหลักเกณฑ์ของรายวิชาพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและติดตามผลการเรียนของนิสิตเป็นรายบุคคลเพื่อส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเองและบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับรายวิชา การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3 และการฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์4นิสิตจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพณโรงพยาบาลแหล่งฝึกโดยมีการกำหนดให้ฝึกปฏิบัติและบันทึกประสบการณ์การปฏิบัติหัตถการที่สำคัญตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาได้แก่ การสอดใส่หลอดคาในท่อลมทางปาก (Oroendotracheal Intubation) การผันคืนจังหวะหัวใจด้วยไฟฟ้า (Electrical Cardioversion) การผันคืนจังหวะหัวใจด้วยยาอะดีโนซีน (Pharmacological Cardioversion: Adenosine) และการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เป็นต้น

ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถฝึกปฏิบัติหรือบันทึกประสบการณ์หัตถการได้ครบถ้วนเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยหรือโอกาสในการพบหัตถการบางประเภทมีจำกัด เช่น การใส่หลอดสวนสายสะดือ (Umbilical

Catheter Insertion) การใส่เครื่องดึงกระดูกต้นขา (Traction Splint) และการสอดใส่หลอดคาในท่อลมทางปากในเด็ก (Pediatric Orotracheal Intubation) โรงพยาบาลแหล่งฝึกจะจัดการเรียนรู้ทดแทนในรูปแบบการจำลองสถานการณ์ (Simulation-based Learning) เพื่อให้นิสิตได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างครบถ้วนและบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ หลักสูตรกำหนด

ระดับชั้นเรียน - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ทำหน้าที่ดูแลนิสิตในภาพรวม หากพบนิสิตมีปัญหาทั้งด้านการเรียนด้านสุขภาพด้านพฤติกรรมซึ่งอาจส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาจะแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลนิสิตต่อไป มีการบันทึก และสรุปผลการเข้ารับการปรึกษา

ระดับหลักสูตร - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาใด ๆ อาจนำไปสู่การสำเร็จการศึกษาที่ช้ากว่าหลักสูตรกำหนด ผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2567 ผลการบริหารหลักสูตรทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษาตามหลักสูตร ดังตารางที่ 4.3-1

ตารางที่ 4.3-1 ตารางแสดงจำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ย้อนหลัง 3 ปี

ปี พ.ศ.	รหัส	จำนวนนิสิตแรกเข้า	จำนวนนิสิตจบตามแผน รวมตลอดหลักสูตร			
			สำเร็จการศึกษา (ล่าช้า)	Drop-Out ทั้งหมด	โอนย้ายมายังหลักสูตร ฯ	สำเร็จการศึกษา (ตามแผน)
2566	63	36	-	8	-	28
2567	64	39	-	5	-	34
2568	65	31	2	2	-	27

AUN-QA 4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.

วิธีการประเมินผู้เรียนครอบคลุม วิธีรูบริค (Rubric), การทำเฉลย (Marking Scheme) ช่วงเวลาการประเมินรวมไปถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและแสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวมีความถูกต้องความน่าเชื่อถือและยุติธรรม

ผลการดำเนินงาน:

ในการดำเนินการจัดศึกษา กลไกการบริหารจัดการการหลักสูตร หลักสูตรมีแนวปฏิบัติในการประเมินผลดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินผลให้ชัดเจนและมีการนำเสนอในที่ประชุมภาควิชาเพื่อให้พิจารณาร่วมกัน
2. ผู้รับผิดชอบรายวิชานำสนอหลักเกณฑ์ของการประเมินผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม
3. แจ้งแนวทางการประเมินผลแก่นิสิตตั้งแต่คาบแรกของการเรียนและกำหนดวันสอบลงในตารางสอนและเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม
4. แจ้งผลการประเมินแก่นิสิตทุกครั้งที่มีการประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นิสิตเพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเองและแก้ไขส่วนที่บกพร่องได้

การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ภายหลังจากที่ มคอ.3 และ มคอ.4 ได้รับการนำเสนอและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามที่ได้นำเสนอไว้ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 โดยแต่ละรายวิชาจะจัดทำแบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับวิธีการประเมินผู้เรียนที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4

ตัวอย่างเช่น ในภาคทฤษฎีซึ่งมุ่งวัดความรู้ของผู้เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนจะร่วมกันจัดทำข้อสอบ อาทิ MCQ ซึ่งผ่านกระบวนการวิพากษ์ข้อสอบจากอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชานั้น ๆ ในการดำเนินการสอบจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการสอบของคณะภายหลังการสอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำข้อสอบในครั้งถัดไป ตลอดจนใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการเรียน

นอกจากการวัดผลด้วยข้อสอบแล้ว ยังมีการประเมินผลด้วยวิธีการอื่นที่หลากหลาย อาทิ การจัดทำรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนร่วมกันพัฒนาเครื่องมือประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) และจัดทำคู่มือการทำรายงานและคู่มือการวิเคราะห์กรณีศึกษาสำหรับภาคปฏิบัติ

สำหรับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้จัดทำคู่มือแบบประเมินผลรายวิชาภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) โดยแบบประเมินดังกล่าวได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) และครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรครบทุกข้อ ทั้งนี้ ทุกรายวิชาสามารถนำแบบประเมินดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ โดยสามารถเลือกประเมินเฉพาะ PLOs ที่รายวิชานั้น ๆ รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น รายวิชาการวิจัยทางการแพทย์ฉุกเฉิน รายวิชาสัมมนา และภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

AUN-OA 4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning outcomes of the programme and its courses.

วิธีการประเมินผู้เรียนสามารถวัดผลสำเร็จของการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระยะเวลาของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของรายวิชา

ผลการดำเนินงาน:

ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเกิดพฤติกรรมตามข้อกำหนดของรายวิชานั้น ๆ

เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา จะมีการรวบรวมผลการเรียนรู้ในแต่ละ CLO ซึ่งได้จากการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การสอบ การจัดทำรายงาน หรือชิ้นงานต่าง ๆ ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 เพื่อดำเนินการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ของคณะฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การประเมินผู้เรียนในระดับรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการเรียน (เกรด) แล้วนำเสนอผลดังกล่าวต่อที่ประชุมระดับภาควิชา

2. การประเมินผู้เรียนในระดับภาควิชา อาจารย์ประจำภาควิชาร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการเรียน (เกรด) แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการประเมินเพื่อวัดผลสำเร็จของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมีการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนกำกับติดตามโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ กำหนดให้นิสิตประเมินตนเองเมื่อสำเร็จการศึกษา และให้นิสิตชั้นปีที่ 1-4 ประเมินตนเองตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes: LO) ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework: TQF) ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร (Sub-PLOs) จำนวน 26 ด้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.5-2 (ตาราง AUN-QA หมวดที่ 1)

ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ตามกรอบ Sub PLOs (ปีการศึกษา 2568)

หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร เพื่อวัดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (CLOs และ PLOs) โดยผลการประเมินการบรรลุ PLOs ของผู้เรียนในแต่ละชั้นปีสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถรักษาระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา และมีพัฒนาการด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และคุณลักษณะด้านวิชาชีพตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยการบรรลุ PLOs ทุกด้านอยู่ในระดับสูงตลอดทุกชั้นปี

นอกจากนี้ หลักสูตรใช้การสอบ Comprehensive Examination ก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร โดยออกแบบการสอบให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะการปฏิบัติวิชาชีพที่สอดคล้องกับ PLOs ผลการประเมินปีการศึกษา 2568 พบว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.43 (27 จาก 28 คน) และมีคะแนนเฉลี่ย 68.39 คะแนน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรได้

ผลการประเมินจากการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผลการสอบ Comprehensive Examination ยังแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพได้ตามที่หลักสูตรคาดหวัง

นอกจากนี้ ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพในช่วง 3 ปีการศึกษาย้อนหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 23.10 ในปีการศึกษา 2566 เป็นร้อยละ 24.40 ในปีการศึกษา 2567 และร้อยละ 61.80 ในปีการศึกษา 2568 ซึ่งเป็นหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมว่าวิธีการประเมินและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสามารถสะท้อนและส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

โดยภาพรวม ผลการประเมินทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรแสดงให้เห็นว่าวิธีการประเมินที่หลักสูตรนำมาใช้สามารถวัดผลสำเร็จของการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม และสะท้อนความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษาในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพ

AUN-QA 4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.
มีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เกิดจากการประเมินผู้เรียน และผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ผลการดำเนินงาน:

จากปรัชญาการศึกษาของคณะฯ ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรคาดหวังและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 จึงให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน โดยแต่ละรายวิชามีการดำเนินการประเมินผลใน 3 ลักษณะ ดังนี้

การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment as Learning: AaL) เป็นการประเมินโดยผู้เรียนเองเพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการประเมินตนเองและการสะท้อนคิด (Self-reflection) โดยอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเอง ระบุจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง รู้จักสะท้อนคิดถึงตนเอง ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง การประเมินในลักษณะนี้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดถึงตนเอง อาทิ ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง (Scenario-Based Learning: SBL) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลักสูตรนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดและประเมินตนเอง อาทิ ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีสิ่งใดที่ปฏิบัติได้ดีหรือโดดเด่น และมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงพัฒนา

นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งผลคะแนนสอบกลางภาคผ่านระบบ REG เพื่อให้นิสิตได้รับทราบผลการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบในครั้งถัดไป

ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้แก่ รายวิชาการปฏิบัติหัตถการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง (Simulation for Emergency Operations) ซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในหัวข้อการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในหัวข้อการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (เอกสารอ้างอิง 4.6-1)

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for learning: AfL) เป็นการประเมินโดยผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในระหว่างที่รายวิชาดำเนินการสอน แต่ละรายวิชามีการจัดและการประเมินหลากลายวิธีตามความเหมาะสมของ CLOS ที่ได้รับ และกำหนดไว้ใน มคอ.3, 4 โดย

- รายวิชาภาคทฤษฎี มีการประเมินด้วยวิธีการต่างๆ ตาม CLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ และกำหนดใน มคอ.3, 4 เมื่อมีการวัดประเมินผลแต่ละครั้ง ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะแจ้งผลการประเมิน ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนทุกครั้ง และผู้สอนได้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นิสิต ปรับปรุงพัฒนาตนเอง และเตรียมรับการประเมินในครั้งต่อไป เช่น การแจ้งคะแนนสอบทุกครั้งภายหลังการสอบ 1 สัปดาห์ ในกรณี นิสิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังมีข้อที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อาจารย์ จะมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ และรับฟังนิสิต เพื่อโอกาสในการพัฒนาตนเองของนิสิตให้ดียิ่งขึ้น ส่วนนิสิตที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ดำกว่าเกณฑ์ อาจารย์จะมีการให้ข้อมูลป้อนกลับและรับฟังนิสิตเช่นเดียวกัน และส่งต่อข้อมูลให้ข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด

- ในรายวิชาภาคปฏิบัติจะมีการประเมินนิสิตตามแบบประเมินรายวิชาภาคปฏิบัติของ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ประเมินผล การเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบัติ โดยจัดให้มีการประเมินเป็น 2 ช่วง ได้แก่การประเมินระหว่าง ฝึกปฏิบัติ (formative) อาจารย์บันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ นิสิต ทกสัปดาห์ ตามแบบประเมินกลาง เพื่อให้นิสิตให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีพฤติกรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ตัวอย่าง ในการประเมินรายวิชาหัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง ตามตัวอย่าง Rubric score แบบประเมินผลการให้คะแนน ภาคปฏิบัติของนิสิต โดยอาจารย์สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning: AoL) เป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะดำเนินการรวบรวมผลการประเมินตามสัดส่วนการให้คะแนนในแต่ละ CLO ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 จากนั้นจะจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาตัดสินผลการเรียน (เกรด) ของรายวิชา แล้วนำเสนอผล

ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมระดับภาควิชาเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอผลการเรียน (เกรด) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามลำดับ

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 4.5 การดำเนินการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ภายหลังจากที่นิสิตรับทราบผลการเรียนผ่านระบบ REG นิสิตสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการเรียนได้ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประกาศผลการเรียน

ในขั้นตอนนี้ กรณีที่นิสิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะดำเนินการให้ข้อมูลป้อนกลับและรับฟังปัญหาของนิสิตภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีการสอนเสริมในส่วนที่บกพร่อง ก่อนเปิดโอกาสให้นิสิตเข้ารับการสอบซ่อมเสริม หากผลการสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเสนอขอปรับผลการเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อขออนุมัติผลการเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ในปีการศึกษา 2568 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ตลอดจนใช้เป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะดำเนินการแจ้งผลการสอบกลางภาคแก่นิสิตภายใน 1 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการสอบ เพื่อให้นิสิตได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) อย่างทันท่วงที และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ก่อนการประเมินผลในช่วงปลายภาคการศึกษาต่อไป

AUN-QA 4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes.

การประเมินผู้เรียนและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือในสายงาน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการดำเนินงาน:

การจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ให้ความสำคัญกับการประเมินผู้เรียนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนดให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาเป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยดำเนินการปีละ2ครั้ง(สิ้นสุดภาคการศึกษาต้นและปลาย) ซึ่งครอบคลุมการตรวจ สอบความสอดคล้องของ CLOs, วิธีการจัดการเรียนรู้, วิธีการและสัดส่วนการประเมินผล ตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ในปีการศึกษา 2568 คณะกรรมการทวนสอบฯ ได้ดำเนินการทวนสอบรายวิชาในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2564 พบว่าทุกวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ CLOs และวัตถุประสงค์ของรายวิชามีการประเมินผู้เรียนและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และมีการนำข้อเสนอแนะจากการทวนสอบครั้งก่อน มาใช้ปรับปรุงรายวิชาอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายวิชา

ที่มีการประเมินทักษะปฏิบัติทางคลินิกด้วยการสอบแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เกณฑ์การตัดสินผลนิสิตจะต้องได้คะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ MPL (Minimum Passing Level: MPL) ของคะแนนแต่ละสถานี ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน จะต้องเข้ารับการสอบแก้ไขเฉพาะสถานีที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ MPLและจะต้องมีคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ MPL จึงจะถือว่าสอบผ่าน ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนว่าการจัดการศึกษาของหลักสูตร สามารถตอบสนองต่อ PLOs และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2569 ได้แก่การกำหนดให้มีข้อสอบใหม่อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของข้อสอบทั้งหมดในแต่ละรายวิชา เพื่อลดความเสี่ยงในการถ่ายทอดข้อสอบระหว่างรุ่นนักศึกษาและสร้างคลังข้อสอบที่มีคุณภาพ ครอบคลุม และเพียงพอสำหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงของผู้เรียน

ผลการทวนสอบทั้งหมดจะถูกรวบรวมและสรุปโดยเลขานุการคณะกรรมการทวนสอบฯ เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใช้ปรับปรุง การเรียนการสอนในรอบถัดไป

ผลการประเมินตนเอง

AUN-QA Criterion 4 – Student Assessment	ระดับ
	2568
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives.	4
4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.	4
4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.	4
4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.	4
4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning outcomes of the programme and its courses.	4
4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.	4

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes.	4
Overall opinion	4

รายการหลักฐาน AUN-QA 4

รหัสเอกสาร	รายละเอียดเอกสาร
AUN-QA 4.1-1	ภาพกิจกรรมรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผล
AUN-QA 4.2-1	ขั้นตอนการขอดูผลคะแนนสอบและการอุธรณ์ผลคะแนนสอบ
AUN-QA 4.3-1	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 2566
AUN-QA 4.3-2	คู่มือนิสิต 2568
AUN-QA 4.3-3	คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
AUN-QA 4.3-4	สมุดประจำตัวนิสิต
AUN-QA 4.3-5	- สรุปผลการเข้ารับการปรึกษาสุขภาพจิต ปี 68 - สรุปผลการเข้ารับการปรึกษาสุขภาพจิตนิสิต โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประจำปีการศึกษา 2568
AUN-QA 4.4-1	เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชาสัมมนา เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชาการวิจัยทางการแพทย์ฉุกเฉิน
AUN-QA 4.5-1	มคอ.3 รายวิชา การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน มคอ.3 รายวิชา การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2 มคอ.3 รายวิชา การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
AUN-QA 4.5-2	รายงานการประชุมวิพากษ์ผลการศึกษา
AUN-QA 4.6-1	มคอ.3 รายวิชา การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง มคอ.3 รายวิชา การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

QR CODE เอกสารหลักฐาน

AUN - QA criterion 5 Academic Staff

Sub Criterion 5

1. The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-deELOsyment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.
2. The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of education, research, and service.
3. The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, and communicated.
4. The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude.
5. The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which accounts for teaching, research, and service.
6. The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.
7. The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs.
8. The programme to show that performance management including reward and recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.

5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-deELOsyment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การโปรโมทขึ้นทำงานในตำแหน่งใหม่ การเลิกจ้างและแผนการเกษียณอายุ) ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางวิชาการตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาการวิจัยและการบริการ ทางวิชาการ

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการโดยครอบคลุมทั้งการสืบทอดตำแหน่งการเลื่อนตำแหน่งการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งการเลิกจ้างและการเกษียณอายุ ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

คำนวณอัตรากาลังโดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษาตามสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สัดส่วนอาจารย์ ต่อนักศึกษา ในภาพรวมกาหนด ดังนี้คือ

- สัดส่วนอาจารย์เต็มเวลาหรือเทียบเท่า 1 คน ต่อ นักศึกษาไม่มากกว่า 6 คน
- การฝึกภาคปฏิบัติทั่วไป อาจารย์เต็มเวลาหรือเทียบเท่า 1 คน ต่อ นักศึกษา ไม่มากกว่า 8 คน
- การฝึกปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 1 คน ต่อนักศึกษาไม่มากกว่า 6 คน

แผนดังกล่าวเชื่อมโยงกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2569–2572) ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ 1: เข็มมุ่ง มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมสร้างชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน (Societal Well-being)
- ยุทธศาสตร์ที่ 2: มุ่งบริหารจัดการคณะแพทยศาสตรีให้มีการบริการที่มีหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาทุกมิติเพื่อพึ่งพาตนเองได้ และสู่ความยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านวิจัยสู่ระดับชาติ นานาชาติ และนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

คณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากรได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2572) และแปลงสู่ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีหัวใจสำคัญ ได้แก่

1. การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (กลยุทธ์ที่ 1.1) ให้สอดคล้องกับพันธกิจและทิศทางคณะฯ
2. การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาการ (Career Path) (กลยุทธ์ที่ 2.1) เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของอาจารย์
3. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) (กลยุทธ์ที่ 2.2) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การดำเนินการคำนึงถึง สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาไม่เกิน 1:6 และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติไม่เกิน 1:8 เพื่อให้การเรียนการสอนและการนิเทศมีคุณภาพสูงสุด

แผนดังกล่าวถูกสื่อสารและถ่ายทอดผ่าน การประชุมคณะฯ การประกาศนโยบายจากคณบดีและการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของอาจารย์ ซึ่งถูกรวบรวมในระดับภาควิชาและคณะ

ตารางที่ 5.1-1 วุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการ (ข้อมูล วันที่ 30 มีนาคม 2569) อาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2568

ชื่ออาจารย์ผู้สอน	ตำแหน่งทางวิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
1.นายวงศ์วัฒน์ เตมียบุตร	อ.	วว.	โสต ศอ นาสิกวิทยา
2.นางอรทัย เกตุขาว	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์
3.นายประจวบ แหลมหลัก	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์
4.นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์
5.นางอุรัชชา สัจจาพงศ์	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์
6.นายสรวิศ บุญญฐี	ผศ.	วว.	เวชศาสตร์ครอบครัว
7.นางสาวเพ็ญนิภัท นภีรงค์	อ.	วว.	รังสีวิทยาวินิฉัย
8.นายคามิน สุทธิกุลบุตร	อ.	วว.	อายุรศาสตร์
9.นายกฤติน นาราเวชสกุล	อ.	วว.	ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
10.นายวัชเรสร พันธ์พัฒนกุล	อ.	วว.	ประสาทวิทยา
11.นายภาษา สุขสอน	อ.	วว.	อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
12.นางสาวชญานี วิวัฒนเศรษฐ์	อ.	วว.	จักษุวิทยา
13.นางสาวอรอนงค์ มาลา	อ.	วว.	วิสัญญีวิทยา
14.นางสาวเพ็ญพรรณ กัณฑะษา	อ.	วว.	กุมารเวชศาสตร์
15.นายนิติภูมิ สินณฐากร	อ.	วว.	ออร์โธปิดิกส์
16.นางสาวภัทรณี ศรีชัยรัตนกูล	อ.	วว.	วิสัญญีวิทยา
17.นางสาวเบญจวรรณ ตาแก้ว	อ.	วว.	สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
18.นางสาวมัลลิกา ขวัญเมือง	อ.	วว.	อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
19.นายดนัยภัทร วงษ์วรศรีโรจน์	อ.	วว.	จักษุวิทยา
20.นางสาวกานต์จิรา ทิตย์สีแสง	อ.	วว.	อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
21.นางสาวณัฐชยา กันทะเสนา	อ.	วว.	เวชศาสตร์ฟื้นฟู
22.นายสิรวิชญ์ สุนทรชัยยะ	อ.	วว.	โสต ศอ นาสิกวิทยา
23.นายสุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล	อ.	วว.	รังสีวิทยาวินิจฉัย
24.นางสาวทัศนีย์ ศรีโพธิ์	อ.	ปริญญาโท	กายวิภาคศาสตร์
25.นายวรัญญู เหงี่ยมไพศาล	อ.	วว.	วิสัญญีวิทยา
26.นางสาวอชิรญา ชนะพาล	อ.	วว.	เวชศาสตร์ป้องกัน
27.นางสุรางคนา ไชยรินคำ	อ.	ปริญญาเอก	พยาบาลศาสตร์
28.นางสาวสุนันทา วงศ์รัตนกมล	อ.	ปริญญาเอก	พยาบาลศาสตร์
29.นางสาวชนกนันท์ เนติศุภลักษณ์	อ.	วว.	เวชศาสตร์ป้องกัน
30.นายพชรพล อุดมลักษณ์	อ.	วว.	ออร์โธปิดิกส์
31.นายวรกันต์ วรธำรงผไท	อ.	วว.	ออร์โธปิดิกส์
32.นางสาวสรัสวดี เถลิงศก	อ.	วว.	กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
33.นางสาวเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์	อ.	วว.	อายุรศาสตร์
34.นายจิรพัฒน์ คล้อยปาน	ผศ.	ปริญญาเอก	Health Sciences
35.นายณรงค์ศักดิ์ มั่นคง	ผศ.	ปริญญาเอก	วิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่ออาจารย์ผู้สอน	ตำแหน่งทางวิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
36.นางรัษฎา ประภาสะวัต	รศ.	ปริญญาเอก	Medical Science
37.นายกฤษฎา สารทอง	ผศ.	ปริญญาโท	สุขภาพจิต
38.นายนัฐพล ปันสกุล	ผศ.	ปริญญาเอก	สาธารณสุขศาสตร์
39.นางสาวเนตรนภา พรหมมา	ผศ.	ปริญญาตรี	สาธารณสุขศาสตร์
40.นายศราวุฒิ แสงคำ	ผศ.	ปริญญาโท	อนามัยสิ่งแวดล้อม
41.นายมณุเชษฐ์ มะโนธรรม	ผศ.	ปริญญาโท	อาชีวเวชศาสตร์
42.นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล	ผศ.	ปริญญาโท	Chinese and Western Integrative Medicine
43.นายศักดิ์สิน สิมสินธุ์	อ.	ปริญญาโท	ชีวสถิติ
44.นางสาวปิยะนุช โลนันท์	อ.	ปริญญาโท	การแพทย์แผนจีน
45.นางสาวกิ่งกนก รักษนาเวศ	อ.	ปริญญาโท	กายวิภาคศาสตร์
46.นางสาวตวงพร พิกุลทอง	อ.	ปริญญาโท	สาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2568

ชื่ออาจารย์พิเศษ	ตำแหน่งทางวิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
1.นางรพีพร โรจน์แสงเรือง	อาจารย์พิเศษ	วว.	อายุรศาสตร์
2.นายณัฐกรณ์ สุปรียาพร	อาจารย์พิเศษ	วว.	ศัลยศาสตร์
3.นายอนณ ปัญโญใหญ่	อาจารย์พิเศษ	วว.	นิติเวชศาสตร์
4.นายพีรณัฐ ผลวิชา	อาจารย์พิเศษ	วว.	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
5.นางสาวกิตติยา ไทยธวัช	อาจารย์พิเศษ	วว.	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
6.นายอุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา	อาจารย์พิเศษ	วว.	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7.นายธนกร ศรีธิยศ	อาจารย์พิเศษ	วว.	กุมารเวชศาสตร์
8.นางสาวภาวิตา เลาหกุล	อาจารย์พิเศษ	วว.	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
9.นางสาววัชรัญ จิรรัชวาริช	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
10.นายพยนต์ ดวงทิพย์	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	พยาบาล
11.นายอนุรักษ์ ขุนอ้อย	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	พยาบาล
12.นายธานนท์ ยอดยา	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	พยาบาล
13.นายพัชรพล ไผเครือ	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	พยาบาล
14.นางสาวคุณิตา ไชยวงศ์	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
15.นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
16.นายณรงค์ชัย วงค์วาน	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
17.นางสาวพนัชกร สุนันต๊ะ	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
18.นายจิตรติกร ไชยปัดถา	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
19.นายศิวพันธ์ เพชรอุดม	อาจารย์พิเศษ	ปริญญาตรี	ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ตารางที่ 5.1-2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ข้อมูล ณ เดือนวันที่ 1 กรกฎาคม 2569

บุคลากร	ประเภท			คุณวุฒิ				ความก้าวหน้าในสายงาน			
	ลูกจ้าง	พนง. มหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ต่ำกว่า ป.ตรี	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก				
1.สายวิชาการ								อ.	ผศ.	รศ.	ศ.
อาจารย์	-	42	3	-	-	1	44	38	5	2	-
ผู้ช่วยสอน	-	2	-	-	2	-	-				

ผลการดำเนินงานด้านกำลังคนและพัฒนาบุคลากร (ปีการศึกษา 2568)

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Organization Development: OD) เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านทัศนคติและสมรรถนะในการทำงาน
- จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (Exam Plus) สำหรับอาจารย์และบุคลากร เพื่อยกระดับการจัดการสอบและสร้างคลังข้อสอบ
- ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมด้านวิจัย เช่น การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review & Meta-analysis) และ โครงการบ่มเพาะงานวิจัย (Routine to Research: R2R)

2. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล วางระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงบุคลากรมี Mindset ของการทำงานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มี ขีดความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าตามสายงาน ดังนี้

1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ครอบคลุม ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร และทุกช่วงอายุการปฏิบัติงาน โดยแบ่งหลักสูตรการพัฒนาออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรพื้นฐาน 2) หลักสูตรด้านวิชาการ 3) หลักสูตรด้าน การจัดการ 4) หลักสูตรด้านบริหาร

2. การพัฒนาเข้าสู่ความก้าวหน้าตามสายงาน มีระบบการเข้าสู่ความก้าวหน้าตามสายงานทั้งพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ชัดเจน รวมถึงมีโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

3. การสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก โดยให้ไปศึกษาต่อและสนับสนุน ทุนการศึกษา การไปปฏิบัติงานวิจัย เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ การฝึกอบรม และดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. การสนับสนุนความก้าวหน้าและแรงจูงใจในสายวิชาการ

- อาจารย์แพทย์ดีเด่น โดยแพทยสภา
- อาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านให้บริการรับผู้ป่วยในสูงสุด
- อาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกสูงสุด
- อาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านหัตถการและการผ่าตัดสูงสุด
- รางวัลหน่วยงานที่บุคคลสุขภาวะดี
- รางวัลประกาศนียบัตรบุคคลที่มีสุขภาพที่ดี
- รางวัลเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนให้ผู้อื่มเพื่อการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
- บุคลากรสายสนับสนุน รพ. ที่ผลงานดีเด่น (วันมหิดล)

4. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับภารกิจของคณะ ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการทางการแพทย์การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับตำแหน่งงานและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

คณะแพทยศาสตร์ดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง(Succession Planning) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็นผู้นำในอนาคตขององค์กร อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมบุคลากรทุกสายงาน ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน การดำเนินงานดังกล่าวใช้ข้อมูลจากระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Management andDevelopment) เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพรายบุคคล และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างชัดเจน และสามารถเติบโตตามศักยภาพของตน

(1) บุคลากรสายวิชาการ

คณะฯ จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)โดยส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพและปริมาณตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ จนถึงศาสตราจารย์ รวมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการต้องมีผลการประเมินการสอนที่ครอบคลุมด้านความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และต้องมีภาระการสอนประจำในรายวิชาที่มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตในระบบทวิภาค

(2) บุคลากรสายสนับสนุน

คณะฯสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานวิชาการจากงานประจำโดยเข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(RoutinetoResearch:R2Rเพื่อนำผลงานไปไปใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยแบ่งตามคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่

- ระดับบริญญาตรีขึ้นไป: ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
- ต่ำกว่าปริญญาตรี: ตำแหน่งชำนาญงาน และชำนานานาญงานพิเศษ

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of education, research, and service.

มีการวัดและติดตามปริมาณงานของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ

ผลการดำเนินงาน:

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภาระงานของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยมีการ วัดและติดตามภาระงาน (Workload Monitoring) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร

ระบบการติดตามและประเมินผลภาระงานปัจจุบัน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้ความสามารถครอบคลุมหลายด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีอาจารย์ประจำ 42 คน คณาจารย์มีตำแหน่ง ทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าจำนวน 44 คน

การจัดการภาระงาน

- ภาระการสอนและการควบคุมปฏิบัติการถูกจัดสรรผ่านการประชุมประจำสาขา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์และค่า FTEs (Full Time Equivalent)
- อาจารย์แต่ละคนต้องรับผิดชอบภาระการสอนเฉลี่ยตามสัดส่วนที่กำหนดเพื่อให้การกระจายภาระงานมีความสมดุล และเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน
- คณะมีการ ประชุมตกลงเรื่องภาระงานทุกภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาปรับภาระงานทั้งในด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ

การติดตามและปรับปรุง

- การประเมินภาระงานและค่า FTEs จัดทำเป็นรายภาคการศึกษา และมีการติดตามผลปีละ 1 ครั้ง
- ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อปรับสมดุลภาระงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากรและใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนา แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รวมถึงใช้ประกอบการจัดทำ SAR และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ตารางที่ 5.2-1 สรุปค่า FTEs และภาระงาน ปี 2568 ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประเภทงาน	FTE เฉลี่ย	FTE (Normalize)	เกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย	การประเมิน
งานสอน	0.2353	0.1641	0.43	ต่ำกว่าเกณฑ์
งานอื่น ๆ (วิจัย + บริการวิชาการ + ทำนุบำรุง + บริหาร)	1.1984	0.8359	0.57	สูงกว่าเกณฑ์
รวมทั้งหมด	1.4337	1.0000	1.00	-

ตารางที่ 5.2-2 สรุปค่า FTEs และภาระงาน ปี 2568 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ประเภทงาน	FTE เฉลี่ย	FTE (Normalize)	เกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย	การประเมิน
งานสอน	0.2495	0.1491	0.43	ต่ำกว่าเกณฑ์
งานอื่น ๆ (วิจัย + บริการวิชาการ + ทำนุบำรุง + บริหาร)	1.4234	0.8509	0.57	สูงกว่าเกณฑ์
รวมทั้งหมด	1.6730	1.0000	1.00	-

ตารางที่ 5.2-3 สรุปค่า FTEs และภาระงาน ปี 2568 ของอาจารย์ผู้สอนคณะแพทยศาสตร์

ประเภทงาน	FTE เฉลี่ย	FTE (Normalize)	เกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัย	การประเมิน
งานสอน	0.2531	0.2430	0.43	ต่ำกว่าเกณฑ์
งานอื่น ๆ (วิจัย+บริการวิชาการ+ทำนุบำรุง+บริหาร)	0.7884	0.7570	0.57	สูงกว่าเกณฑ์
รวมทั้งหมด	1.0415	1.0000	1.00	-

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

1. ผลการวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์แพทย์ผู้สอน พบว่า ภาระงานส่วนใหญ่ของคณาจารย์อยู่ในด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร และภารกิจสนับสนุนอื่น ๆ ในขณะที่สัดส่วนภาระงานด้านการสอนมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ส่งผลให้ค่า FTE รวมเฉลี่ยของคณาจารย์อยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด สะท้อนถึงภาระงานที่หลากหลายและความรับผิดชอบที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และการบริหารของคณะฯ
2. คณะควรมีการบริหารจัดการภาระงานของอาจารย์ให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดสัดส่วนภาระงานให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มอาจารย์ รวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนด้านงานบริหารและงานประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการดูแลผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์สามารถดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพตามพันธกิจของสถาบัน
3. ควรมีการติดตามและทบทวนค่า FTE ของอาจารย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง การกระจายภาระงาน และการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้เหมาะสม อันจะส่งผลต่อการรักษาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ อย่างยั่งยืน

ตารางที่ 5.2-4 สรุปค่า FTEs และภาระงาน ปี 2568 ของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ (แยกแต่ละด้าน 5 ด้านหลัก)

ประเภทงาน	FTE เฉลี่ย*	FTE (Normalize)**
งานสอน	0.2476	0.1728
บริการวิชาการ	0.6747	0.4707
งานวิจัย	0.0768	0.0536
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.0503	0.0351
งานบริหาร	0.2740	0.1911

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

1. ภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ในด้าน บริการวิชาการ (47.07%) รองลงมา คือ งานบริหาร (19.11%) และ งานสอน (17.28%) สะท้อนบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์และการบริหารจัดการคณะฯ
2. ภาระงานด้าน วิจัย (5.36%) และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (3.51%) มีสัดส่วนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับพันธกิจด้านอื่น ๆ ของคณะ
3. คณะควรใช้ผลการวิเคราะห์ภาระงานและค่า FTE เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยสนับสนุนให้อาจารย์มีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับการทำวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพตามความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งรักษาสมดุลของภาระงานในทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

การคำนวณค่า FTEs (Full-Time Equivalent) ของอาจารย์ ปีการศึกษา 2568

อ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดสูตรการคำนวณดังนี้:

FTEs = ชั่วโมงทำงาน / (35 ชั่วโมง × 36 สัปดาห์)

โดยใช้ชั่วโมงปฏิบัติงานมาตรฐาน 1,260 ชั่วโมงต่อปี (35 ชั่วโมง × 36 สัปดาห์) เป็นฐานคำนวณ กำหนดให้ค่า FTEs = ชั่วโมงทำงาน / (35 ชั่วโมงทำงาน x 36 สัปดาห์ต่อปีการศึกษา)

- ค่า FTEs ด้านภาระการสอน = 0.43
- ค่า FTEs ด้านอื่นๆ ได้แก่ ภาระงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
  ภาระงานบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ
  และภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมสุขภาพ และภาระงานบริหาร = 0.57
- ค่า FTEs รวมภาระงานทั้งหมด = 1.00

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, and communicated.
มีการกำหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ การประเมินผล และมีการสื่อสารให้ทราบ

ผลการดำเนินงาน:

สมรรถนะของคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาอาจพิจารณาได้จากภาระงานบุคลากรซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้าน คือ

1. ด้านการสอน
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2565กำหนดให้บุคลากรสายวิชาการต้องมีภาระงาน ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 35 ชั่วโมงทำงาน/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ หรือ 630 ชั่วโมงทำงานใน 1 ภาคการศึกษา และ 1,260ชั่วโมงทำงานใน 1 ปีการศึกษา

การจัดสรรภาระงานจะพิจารณาจากความรู้ ความถนัด ประสบการณ์ และทักษะของแต่ละบุคคล โดยมีการประชุมสาขาในทุกภาคการศึกษา ซึ่งจะมีการปรับปรุงแนวทางการสอนทุกภาคการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากเทอมก่อนเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงในเทอมถัดไป การเปิดรายวิชา จำนวนผู้เรียน และความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานก็จะได้รับการพิจารณา

สำหรับบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานใหม่ จะได้รับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 2 ครั้ง (ครั้งละ 6 เดือน) ก่อนการบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานจะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงาน และผลการประเมินจะใช้สำหรับการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนประจำปี

ในด้านการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตจะใช้ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกรายวิชาในสมรรถนะด้านการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยยังมีนโยบายในการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองผ่านการออก "ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2567 เพื่อยกระดับให้เป็น “มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ”

นอกจากนี้ คณาจารย์ในสาขายังมีบทบาทและหน้าที่ที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร โดยมีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะที่รับผิดชอบในแต่ละงานของสาขา เช่น งานด้านกิจการนิสิต การบริการวิชาการ เป็นต้น และมีประธานหลักสูตรเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย

ทางสาขาวิชาได้จัดเก็บข้อมูลพันธกิจทั้ง 4 ด้านของอาจารย์ ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับภาระงานของ หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

การสื่อสารและการติดตามผล

- รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้สื่อสารนโยบาย เกณฑ์ และแนวทางการประเมิน ผ่านการประชุมคณะ, การประชุมภาควิชา, และหนังสือเวียน

- หัวหน้าภาควิชา เป็นผู้ถ่ายทอดรายละเอียดสมรรถนะที่คาดหวัง ติดตามผล และแจ้งผลการประเมินให้แก่บุคลากร เพื่อใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบถัดไป
- ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการปรับปรุงมาตรฐานภาระงาน ซึ่งมีการทบทวนทุก 3 ปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญ

ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2568

- อาจารย์ทุกคนได้จัดทำและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และข้อตกลงภาระงานของแต่ละสาขาวิชา โดยคำนึงถึงพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
- คณะได้ติดตามและวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ผ่านการคำนวณค่า FTE เพื่อให้การกระจายภาระงานมีความเหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสะท้อนลักษณะการปฏิบัติงานจริงของอาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วย
- ผลการวิเคราะห์ภาระงานพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานด้านการสอนและบริการวิชาการในสัดส่วนสูง ขณะที่ภาระงานด้านการวิจัยและการพัฒนาวิชาการยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย คณะจึงได้นำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดสรรภาระงานและกำหนดแนวทางสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ
- ข้อมูลจากการประเมินภาระงานและค่า FTE ถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) การวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude.

มีการกำหนดตำแหน่งหน้าที่และจัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ (คุณวุฒิ) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความถนัด

ผลการดำเนินงาน:

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายและกระบวนการจัดสรรภาระงานของบุคลากรสายวิชาการให้เหมาะสมกับ **คุณวุฒิทางวิชาการ ความรู้เฉพาะทาง ประสบการณ์การทำงานและความถนัดเฉพาะด้าน** เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจหลักของหลักสูตร ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อมาตรฐานวิชาชีพ

กระบวนการพิจารณาจัดสรรงาน

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
  การจัดสรรรายวิชาและบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก:
  - **คุณวุฒิการศึกษา** เช่น ปริญญาโท/เอกในสาขาการแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
  - **ประสบการณ์การทำงานและการสอน** เช่น ผู้ที่มีประสบการณ์ภาคสนาม EMS จะได้รับมอบหมายในรายวิชาปฏิบัติ

- **ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน** เช่น การฝึกจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน, การวิจัยหรือออกแบบนวัตกรรมสุขภาพตามความเชี่ยวชาญ
- **ความถนัดและความสนใจของอาจารย์** ซึ่งได้รับการสำรวจเป็นประจำทุกปี

รูปแบบการมอบหมายหน้าที่

- บุคลากรสายวิชาการแต่ละคนจะได้รับมอบหมายหน้าที่ทั้งด้านการสอน (Teaching), การวิจัย (Research), การบริการวิชาการ (Academic Service), และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Preservation) อย่างสมดุล
- มีการ**กำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (Course Coordinators)** โดยพิจารณาจาก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในเนื้อหารายนั้นโดยตรง
- อาจารย์ใหม่จะมีระบบการฝึกอบรบและการแนะนำจากอาจารย์ที่อยู่ก่อนหน้าหรือพี่เลี้ยง เพื่อช่วยเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและปรับตัวในบทบาทวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบและทบทวน

- หลักสูตรมีการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนการจัดสรรภาระงานของบุคลากรสายวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาศัยข้อมูลจากระบบ HR Smart ร่วมกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำรอบการประเมิน เพื่อประเมินความเหมาะสมของการมอบหมายหน้าที่ให้สอดคล้องกับคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความถนัดของอาจารย์แต่ละคน
- ในกรณีที่พบว่าภาระงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพหรือสมรรถนะของบุคลากร หลักสูตรจะดำเนินการปรับปรุงและจัดสรรภาระงานใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและจุดแข็งของแต่ละบุคคล
- การทบทวนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมดุลของภาระงาน ลดความเสี่ยงจากการมีภาระงานมากเกินไป และส่งเสริมให้อาจารย์สามารถพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของหลักสูตร

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which accounts for teaching, research, and service.
มีการวัดประเมินผล และการเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ ที่มีความเหมาะสมตามระบบคุณธรรม ที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ

ผลการดำเนินงาน:

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลัก คุณธรรม ความสามารถ และผลงานที่เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนโยบายของมหาวิทยาลัย

ระบบและกระบวนการที่ใช้

- การประเมินและเลื่อนตำแหน่งใช้ มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2559 เป็นมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งภาระงานที่กำหนดนี้ใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปริมาณภาระงานให้มีการกระจายความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นระบบ สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเป็นแนวทางในการกำหนดอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญกับผลงานของบุคลากรใน 5 ด้านหลัก ได้แก่:
    - ภาระงานสอน
    - ภาระงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
    - ภาระงานบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ
    - ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมหลักสูตร
    - ภาระงานบริหาร
- ผลการประเมินในแต่ละด้านถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลกระทบของผลงานเป็นสำคัญ
- บุคลากรสายวิชาการสามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบ HR Smart ของมหาวิทยาลัย โดยแนบผลงานและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองตามลำดับจากหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และคณบดี ก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
- การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินคุณภาพและมาตรฐานของผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด อันเป็นกลไกที่ช่วยให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

ด้วยระบบดังกล่าวคณะฯ สามารถส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความก้าวหน้าในวิชาชีพบนพื้นฐานของศักยภาพและผลงานที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับพันธกิจด้านการจัดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

การสนับสนุนจากหลักสูตรและคณะ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้าง ผลงานทางวิชาการและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยจัดให้มีโครงการและกิจกรรม พัฒนาบุคลากรในหลากหลายด้าน อาทิ
    - การอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
    - การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
    - การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

- มีการมอบหมายภาระงานที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากร เพื่อเอื้อต่อการสร้างผลงานตามเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ อาทิ การรับผิดชอบรายวิชา การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมโครงงานวิจัยของนิสิต การดำเนินงานวิจัย การเป็นวิทยากรหรือผู้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย

การสนับสนุนดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาผลงานด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตามระบบของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดและผลลัพธ์

- มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการเป็นประจำทุกปี ผ่านระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและฐานข้อมูล HR Smart โดยใช้ข้อมูลด้านภาระงาน ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินศักยภาพและความพร้อมสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- ผลการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2568 มีบุคลากรสายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2567 ที่ผ่านมา ระดับอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 รายซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของระบบส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ
- ผลการประเมินภาระงานและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การวางแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและการพิจารณาความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.
มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ และมีการสื่อสารให้ทราบ

ผลการดำเนินงาน:

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนด สิทธิ หน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และเสรีภาพทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics) และ เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อองค์กร ชุมชนและประเทศชาติ

แนวทางและกลไกการกำกับดูแล

- คณะกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการในแต่ละตำแหน่งตามข้อบังคับระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนโดยมีการระบุขอบเขตหน้าที่และอำนาจความรับผิดชอบในคำสั่งแต่งตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตร ฯลฯ
- บุคลากรสายวิชาการได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สิทธิประโยชน์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านการประชุมคณะ การประชุมสาขาวิชา การประชุมหลักสูตร ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตลอดจนคู่มือและประกาศต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสิทธิและสวัสดิการบุคลากรสายวิชาการได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อาทิ
    - สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการอย่างอิสระบนพื้นฐานของหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
    - สิทธิในการเข้าถึงโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น การอบรม การประชุมวิชาการ ทุนสนับสนุนการวิจัย และทุนพัฒนาศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    - สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความก้าวหน้าทางวิชาการและการประเมินผลตามระบบคุณธรรม
    - สิทธิในการได้รับสวัสดิการและการดูแลตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น สวัสดิการด้านสุขภาพ ประกันชีวิตเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย

การส่งเสริมจรรยาบรรณและเสรีภาพทางวิชาการ

- คณะจัดกิจกรรม อบรมและประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และการประชุมประจำปีของคณะ
- บุคลากรมี เสรีภาพในการออกแบบการเรียนการสอน การทำวิจัย และการแสดงความคิดเห็นในทางวิชาการ โดยอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย
- มีการ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพในความคิดเห็นต่าง และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของหลักสูตร เช่น การวางแผนปรับปรุงรายวิชา การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ความรับผิดชอบและความโปร่งใส
- บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องลงนามในเอกสารรับทราบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษา
- มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือเสนอแนะ หากมีการละเมิดจริยธรรม หรือใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสม โดยผ่านหน่วยทรัพยากรบุคคลของคณะ หรือระบบร้องเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นอกจากจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตรให้มีความชัดเจน โดยพิจารณาจากมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพพร้อมทั้งยึดมั่นในเสรีภาพทางวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่า ด้วยจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2567

การแบ่งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการออกเป็น 3 หมวด ได้แก่:

1. **หมวดที่ 1: มาตรฐานจรรยาบรรณและคุณธรรม**
    - ส่วนที่ 1: มาตรฐานจรรยาบรรณและคุณธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 8 ประการ
    - ส่วนที่ 2: มาตรฐานจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
    - ส่วนที่ 3: จรรยาบรรณพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา
2. **หมวดที่ 2: กลไกและระบบบังคับใช้จรรยาบรรณและคุณธรรม**
3. **หมวดที่ 3: ขั้นตอนการลงโทษ**

นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการสวัสดิการและสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม โดยได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยพะเยาและสภาพนักงาน ซึ่งช่วยเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ทุกฝ่าย

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs. มีการกำหนด และวางแผนความต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการดำเนินกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ได้กำหนดไว้

ผลการดำเนินงาน:

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการระบุความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ความพยายามในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการนี้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2569-2572) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน งานวิจัย การบริการและระบบบริหารจัดการเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นโรงเรียนแพทย์มาตรฐานสากลที่เชื่อมโยงกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

การระบุความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา

คณะได้ดำเนินการประเมินความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรสายวิชาการผ่านวิธีการหลายประการ เช่น การสำรวจความคิดเห็นจากคณาจารย์การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิตศิษย์เก่า และผู้ใช้งานบัณฑิต การประเมินตนเองของคณาจารย์และการประเมินผลการสอนเพื่อระบุความต้องการ ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการวิจัยใหม่ ๆ และการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์

กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนา

เมื่อได้ระบุความต้องการในการฝึกอบรมแล้ว คณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น โดยมีโครงการดังนี้

ตารางที่ 5.6-1 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2568

ลำดับ	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
1	โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	100%	100%	28 ส.ค. 2568
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI (Data Analytics and Data Visualization)	100%	100%	25-26 ก.พ. 2569
3	โครงการอบรม Performance Appraisal for Senior Leaders	100%	100%	20 มี.ค. 2569
4	โครงการอบรมหลักสูตร Manager Development Program (MDP)	100%	100%	23-25 มี.ค. 2569
5	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน HR Well-being และ HR Sustainability เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx	100%	100%	30 มี.ค. 2569
6	โครงการ IDP 100% เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้าน Core Competency และส่งเสริมค่านิยมองค์กร MEDUP	100%	100%	21-22 เม.ย. 2569

6	โครงการ IDP 100% เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้าน Core Competency และส่งเสริมค่านิยมองค์กร MEDUP	100%	100%	21-22 เม.ย. 2569

ตารางที่ 5.6-2 การฝึกอบรมด้านการวิจัย

ลำดับ	กิจกรรม	วันที่
1	Spinning Research Forward: Inspiring Innovation	12 มี.ค. 2568
2	Visiting Professor for Research (ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ)	2 ก.ย. 2568
3	อบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลองและมนุษย์	3 ก.ย. 2568
4	AI-Powered Medical Data Analytics	5 ก.ย. 2568
5	Visiting Professor for Research (Prof. Timothy O'Brien)	22 ธ.ค. 2568
6	กิจกรรมที่ปรึกษางานวิจัยด้านคลินิก	12 ม.ค. 2569
7	กิจกรรมที่ปรึกษางานวิจัยด้านคลินิก	16 ก.พ. 2569
8	กิจกรรมที่ปรึกษางานวิจัยด้านคลินิก	23 เม.ย. 2569
9	กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญสู่นักวิจัยรุ่นใหม่	7 พ.ค. 2569

การติดตามและประเมินผล

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมาย คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากอัตราการ เข้าร่วมกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของแต่ละโครงการและการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะในระยะยาว

สรุปผลการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2568 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กำหนดไว้ครบถ้วน ครอบคลุมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยผ่านกิจกรรมและการอบรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความสำเร็จในการดำเนินงานนี้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์

5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.
มีการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับ เพื่อประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ

ผลการดำเนินงาน:

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการดำเนินการด้าน การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างยั่งยืน โดยมี ระบบการให้รางวัลและการยอมรับ เป็นกลไกสำคัญในการจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

กลไกการประเมินและบริหารผลงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ผ่านระบบ HR Smart ของมหาวิทยาลัย โดยอิงตามตัวชี้วัดผลงานในแต่ละด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การผลิตงานวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาตนเอง

การประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานกับหัวหน้าสาขา หรือประธานหลักสูตร เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาอย่างตรงจุด

ระบบรางวัลและการยอมรับ

คณะและมหาวิทยาลัยมีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัลแก่บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยครอบคลุมการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อาทิ

- การมอบเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละปีการศึกษา

- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรผ่านเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารของคณะและมหาวิทยาลัย
    - การเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัลในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เช่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น อาจารย์แพทย์ดีเด่น โดยแพทยสภา อาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านให้บริการรับผู้ป่วยในสูงสุด, อาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกสูงสุด, อาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านหัตถการและการผ่าตัดสูงสุด, รางวัลหน่วยงานที่บุคคลสุขภาวะดี รางวัลประกาศนียบัตรบุคคลที่มีสุขภาพที่ดี
- การสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการยกย่องเชิดชูเกียรติช่วยกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความรับผิดชอบและความเป็นเลิศทางวิชาการส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

3 ผลการประเมินตนเอง

AUN-QA Criterion 5 – Checklist	ระดับ 2568
5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-deELOsyment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.	3
5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of education, research, and service.	3
5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, and communicated.	3
5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude.	4
5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which accounts for teaching, research, and service.	4
5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.	4

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs.	3
5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.	4
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)	**3**

รายการหลักฐาน AUN-QA 5

รหัสเอกสาร	รายละเอียดเอกสาร
AUN-QA 5.1-1	แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
AUN-QA 5.1-2	รายงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
AUN-QA 5.1-3	แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2569 - 2572
AUN-QA 5.1-4	รายงานบุคลากรได้รับรางวัลชมเชย ปี 69
AUN-QA 5.1-5	รายงานภาระงานและรายงานผลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ.2566-2568
AUN-QA 5.2-1	มาตรฐานภาระงานบุคคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559
AUN-QA 5.2-2	ตารางสรุปภาระงาน บุคลากรสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 2567
AUN-QA 5.3-1	ประกาศ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ พ.ศ.2567
AUN-QA 5.6-1	จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554 จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567
AUN-QA 5.6-2	ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนวิจัย 2568 (รอบที่1) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนวิจัย 2568 (รอบที่2)
AUN-QA 5.7-1	แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2569 - 2572
AUN-QA 5.8-1	รายงานบุคลากรได้รับรางวัลชมเชย ปี 69
AUN-QA 5.8-2	นักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยศาสตร์สุขภาพ

QR CODE เอกสารหลักฐาน

AUN - QA criterion 6 Student Support Services

AUN-QA 6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown to be clearly delined, communicated, published, and up-to-date.

นโยบายการรับเข้า เกณฑ์การรับเข้า และขั้นตอนการรับเข้าเรียนในหลักสูตรถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน มีการสื่อสารเผยแพร่ และข้อมูลดังกล่าวถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ผลการดำเนินงาน:

การดำเนินการในการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนไม่เกิน 40 คนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับอัตรากำลังของผู้สอนเพื่อผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ ทางสาขาวิชามีเกณฑ์การรับและขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสารเผยแพร่ตามช่องทางที่เหมาะสม โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการคณะและฝ่ายวิชาการประจำหลักสูตรร่วมกันกำหนดแผนการรับนิสิต (6.1.1) ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ รับทราบและพิจารณาถึงจำนวนการรับนิสิตแต่ละหลักสูตร

2. หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติ (6.1.2) และสัดส่วนการรับเข้าตามระบบ TCAS ในแต่ละรอบผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะ

3. ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 , 2 และ 3 (รายละเอียดการรับเข้าประกาศอัพเดทผ่านทาง website http://admission.up.ac.th/) (6.1.3) รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางเพจคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ภายใต้กิจกรรมเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ รู้จักคณะ รู้จักหลักสูตร รู้จักตนเอง (6.1.4) ซึ่งรายละเอียดการเปิดรับแต่ละรอบประกอบด้วย

3.1 TCAS รอบที่ 1 คือ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยพิจารณาจาก GPAX 5 ภาคเรียน = 20% และ TGAT = 80%

3.2 TCAS รอบที่ 2 คือ โครงการรับตรงในเขตพื้นที่บริการ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ โดยพิจารณาจาก GPAX 5 ภาคเรียน = 20% TGAT = 10% A-Level = 70% (ฟิสิกส์ 10%,เคมี 20%,ชีววิทยา 20%,ภาษาอังกฤษ 20%)

3.3 TCAS รอบที่ 3 (Admission) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยพิจารณาจาก GPAX 6 ภาคเรียน = 20% TGAT = 10% A-Level = 70% (ฟิสิกส์ 10%, เคมี 20%,ชีววิทยา 20%,ภาษาอังกฤษ 20%)

4. ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณสมบัติผู้สมัครว่ามีครบตามเกณฑ์ โดยการสอบสัมภาษณ์ มีการประกาศลำดับที่ วัน เวลา ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้รับทราบชัดเจน เมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครได้ทราบทุกคน

5. เมื่อนิสิตรายงานตัวเข้าศึกษาตามระบบ ทางคณะและทางหลักสูตรได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีการแนะนำการเตรียมตัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนรั้วมหาวิทยาลัยทั้งด้านความเป็นอยู่ การเรียน ขั้นตอนการเรียนสู่การสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตได้เตรียมตัว มีความรู้ความเข้าใจ และจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรแจ้งจำนวนรับนิสิต 40 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 113 คน และจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งในปีการศึกษาต่อไปทางหลักสูตรมีแผนที่จะสำรวจการรับรู้

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรจากนิสิตใหม่ เพื่อจะนำข้อมูลไปวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในปีการศึกษาต่อไปโดยฝ่ายบริการทางวิชาการได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครให้แก่นักเรียน ครูผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดการรับสมัครโดยเผยแพร่ผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์หลายช่องทาง

ตารางที่ 6.1-1 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัคร

กลุ่ม Stakeholder	ช่องทางการสื่อสาร	ข้อมูลที่สื่อสาร	Timeline	ผู้รับผิดชอบ
นักเรียนมัธยม	- Facebook - Tiktok - โทรศัพท์สอบถามมายังคณะฯ - เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ https://medicine.up.ac.th/th/ - เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครนิสิต http://admission.up.ac.th/	- ข้อมูลการรับสมัคร - หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเลือก - กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์	- ตลอดช่วงปีการศึกษา	- ฝ่ายบริการทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ - ส่วนงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยพะเยา - คณะแพทยศาสตร์ - สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ครูแนะแนว	- เปิดรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา	- ข้อมูลหลักสูตร - เกณฑ์การรับสมัคร - จำนวนโควต้าที่เปิดรับในแต่ละสิทธิ์สมัครของพื้นที่โรงเรียน	สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน	- มหาวิทยาลัยพะเยา -คณะแพทยศาสตร์ - สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ผู้ปกครอง	- Facebook - Tiktok - โทรศัพท์สอบถามมายังคณะฯ - เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ https://medicine.up.ac.th/th/ - เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครนิสิต http://admission.up.ac.th/	- ข้อมูลการรับสมัคร - หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเลือก - กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์	- ตลอดช่วงปีการศึกษา	- มหาวิทยาลัยพะเยา -คณะแพทยศาสตร์ - สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ผู้สนใจทั่วไป	- Facebook - Tiktok	- ข้อมูลการรับสมัคร	- ตลอดช่วงปีการศึกษา	- สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน

	- โทรศัพท์สอบถามมายังคณะฯ	- หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเลือก - กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์		

ผลการดำเนินการ พบว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัคร มีนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินมีจำนวนนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี ดังตารางที่ 6.1-2 และตารางที่ 6.1-3

ตารางที่ 6.1-2 ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา	จำนวนที่ประกาศรับ (No. Offered)	จำนวนผู้สมัคร (No. Applied)	จำนวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (No. Admitted) (จำนวนประกาศสัมภาษณ์)	จำนวนที่ลงทะเบียน (No. Enrolled)
1/2563	30	1,508	135	36
1/2564	30	2,598	120	39
1/2565	35	2,689	133	31
1/2566	40	2,268	118	28
1/2567	40	2,800	175	27
1/2568	40	4,801	113	31

ภาพที่ 6.1-3 ตารางข้อมูลจำนวนนิสิตในแต่ละชั้นปี

ปีการศึกษา	จำนวนนิสิต					รวม
	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	> ปี 4	
2564	37	28	18	24	-	107
2565	31	34	28	19	-	112
2566	26	29	34	28	-	117
2567	27	22	29	34	-	112
2568	32	26	23	28	-	109

AUN-QA 6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and community service.

มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของการบริการและสนับสนุนผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต และการดำเนินการตามแผนเพื่อให้มั่นใจว่าการบริการและสนับสนุนผู้เรียนด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการมีความเพียงพอและมีคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน:

ปีการศึกษา 2568 คณะแพทยศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 รายวิชามีการวางแผน ในการบริการและสนับสนุน ผู้เรียนที่ครอบคลุม ทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต นำผลการประเมินจากผู้เรียนจากปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกับส่วนงานสายสนับสนุน ดังนี้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้สำรวจความต้องการจำเป็นในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ ผู้ร่วมสอนในรายวิชานั้น ๆ เสนอหัวหน้าภาควิชาฯ แต่ละสาขา หัวหน้าภาควิชาฯ เสนอความต้องการ จำเป็นในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการ จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และมีความทันสมัย มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาตามหลักสูตร

นอกจากนี้คณะยังได้มีการวางแผนเพื่อสนับสนุนผู้เรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสนับสนนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพและมีความเพียงพอ หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการให้บริการร่วมกับทางคณะเพื่อสนับสนุนทั้งด้านการเรียนและด้านอื่นๆ โดยมีการดำเนินการดังนี้

ระยะสั้น (Short-term)

1. ทางหลักสูตรมีระบบการให้คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม โดยจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำแต่ละชั้นปีที่สามารถให้คำปรึกษาแก่นิสิตได้ตลอดเวลา และมีกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การลงทะเบียนวิชาเรียน รวมถึงช่วยเหลือนิสิตแก้ไขอุปสรรคปัญหาอื่นๆ

ระยะยาว (Long-term)

การดำเนินจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาทั้งทางวิชาการและทางสังคม ให้นิสิตมีความสามารถในการประกอบอาชีพได้

1. หลักสูตร มีกิจกรรมให้นิสิตมีบทบาทร่วมกับ คณาจารย์และบุคลากร ทั้งในและนอกสาขา เพื่อเสริมทักษะให้นิสิต สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การอยู่ร่วมกัน การมีน้ำใจช่วยเหลือพึ่งพา การกล้าแสดงออก การเป็นผู้นำ ผู้ตาม มีคุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครูและมอบเสื้อกาวน์ กิจกรรมออกหน่วยค่ายอาสา การเข้าร่วมสมาพันธ์นิสิตนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแข่งขันกีฬา การออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ร่วมกับสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้มาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ฝึกทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนในการนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตได้
2. ทางคณะและหลักสูตรได้จัดมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อได้พัฒนาทักษะสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ การฝึกอบรบฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โครงการจัดอบรมเสริมหลักสูตรโดยเชิญวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกการจัดการสาธารณภัย งานกีฬาสมาพันธ์ ห้องเรียน ห้องแลปปฏิบัติการ และฝึกงานในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงพยาบาลแหล่งฝึก อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการทำหัตถการและฝึกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินได้
3. สำหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ในกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่ง

ประกอบไปด้วย กองอาคารสถานที่ กองบริการการศึกษา ทำการจัดสรรห้องเรียนให้มีความเพียงพอต่อจำนวนนิสิต รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการของทุกหลักสูตรต้องมีเพียงพอต่อความต้องการ ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ ยังได้มีการเสนอครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยเพิ่มเติมต่อมหาวิทยาลัย โดยสำรวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตเพื่อตั้งงบประมาณจัดซื้อให้เพียงพออยู่เสมอ และในด้านอื่นๆ ดังตารางที่ 6.2-1

ตารางที่ 6.2-1 การวางแผนสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Academic	**การวางแผนระยะสั้น**	**วางแผนระยะยาว**
สถานที่เรียน	ใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์สุขภาพและบางส่วนของมหาวิทยาลัย	การก่อสร้างอาคารคณะแพทยศาสตร์ จะมีห้องเพิ่มสำหรับการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต
ห้องสมุด	จัดซื้อทรัพยากรห้องสมุดตามปีงบประมาณ	1. วางแผนจัดซื้อทรัพยากร ห้องสมุดให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่เปิดสอน 2. มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งภายในห้องสมุดและผ่านสื่อ Social Media
IT	เพิ่มจุดสัญญาณ WiFi เพื่อให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้สะดวกมากขึ้น	1.แผนพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนรวม วิทยาศาสตร์สุขภาพชั้น 5 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.เพิ่มจุดสัญญาณ WiFi ให้ครบทุกพื้นที่ 3.เพิ่มจำนวน ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย มากขึ้น
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	จัดซื้อครุภัณฑ์ตามปีงบประมาณ	วางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ในปีงบประมาณถัดไปเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และครุภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป

AUN-QA 6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workdoad monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary.

มีระบบที่เหมาะสมในการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ศักยภาพทางวิชาการของผู้เรียน และการกำกับติดตามภาระงานของผู้เรียน โดยมีการบันทึกและกำกับติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ และข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงทีหากจำเป็น

ผลการดำเนินงาน:

คณะฯ มีระบบในการควบคุมการดูแลในด้านการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระบบ โดยมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเรื่องการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนิสิตด้านวิชาการ ด้านการพัฒนานิสิต สุขภาพ การใช้ชีวิตและการเข้าสู่วิชาชีพ โดยมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดูแลนิสิตทุกคนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาและติดตามดูแลนิสิตจนสำเร็จการศึกษา โดยอาจารย์ 1 คน จะรับผิดชอบดูแลนิสิตไม่เกิน 6 คน และกำหนดให้ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตที่อยู่ในความดูแล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาค การศึกษา นอกจากนี้เมื่อนิสิตต้องการปรึกษาเพิ่มเติม นิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางโทรศัพท์ส่วนตัว หรือกลุ่ม Line หรือ Line ส่วนตัว และในปัจจุบัน ทางคณะฯ มีการดำเนินการให้การปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่นิสิตต้องการได้รับการช่วยเหลือ ได้ดำเนินการ ในรูปแบบออนไลน์ การให้คำปรึกษาแนะแนวด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต โดยใช้แบบบันทึก การให้คำปรึกษาแก่นิสิตเป็นรายบุคคลคณะฯ มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ศักยภาพทางวิชาการของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นพัฒนานิสิตให้มีสมรรถนะตาม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านการจัดการเรียนการสอน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีและ

ทั้งนี้นอกจากความก้าวหน้าในด้านผลงานวิชาการแล้วนั้น ผลการเรียนของผู้เรียน ภายหลัง การสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะแจ้งผลการเรียนให้นิสิตทราบ กรณีนิสิตมีแนวโน้ม จะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ต่ำกว่ามาตรฐาน จะทำการประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตาม และพัฒนา หาแนวทางช่วยเหลือนิสิต รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาให้รับทราบ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ติดตามดูแลผลการเรียนของนิสิตร่วมกัน โดยนิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายช่องทาง ในการติดตามผลการเรียนและสื่อสารระหว่างอาจารย์ ที่ปรึกษาและนิสิตโดย

1) ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

2) พบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง

3) ปรึกษาผ่าน Social network เช่น Line Application, Facebook, E-mail, Microsoft Teams

4) สื่อสารทางโทรศัพท์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดให้ทุกรายวิชารายงานผลการศึกษา หรือแจ้งคะแนนหลังการสอบกลางภาคให้นิสิตรับทราบ ภายใน 1 สัปดาห์เพื่อให้นิสิตสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองในการสอบปลายภาคในครั้งต่อไป

ในกรณีที่นิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนดตาม คณะฯ มีระบบการกำกับติดตาม Workload monitoring มีระบบในการติดตามและทราบว่า นิสิตมีรายวิชาและงาน/รายงาน/การบ้าน ที่ต้องส่งอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ทราบว่า นิสิตมีงาน การบ้าน ที่ต้องส่งทั้งหมดกี่ชิ้นงาน และสะดวกในการติดตามและประเมินผล เพื่อไม่ให้งานไปกระจุกรวมกันที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

หลักสูตรมีระบบติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบในรายวิชาฝึกปฏิบัติทุกชั้นปี โดยกำหนดให้ผู้เรียนบันทึกผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในการเก็บประสบการณ์ตามข้อกำหนด (Requirements) ของรายวิชาในแบบบันทึกที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้งที่เข้าฝึกปฏิบัติ ข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นระยะตลอดช่วงเวลาการฝึกดังเอกสารแนบ

ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ประสานงานรายวิชาดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบข้อมูลการฝึกและผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 2 สัปดาห์

ในรายวิชาที่มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติ 1 เดือน เพื่อประเมินว่าผู้เรียนสามารถบรรลุข้อกำหนดและผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาได้ตามแผนหรือไม่

เมื่อพบว่าผู้เรียนมีแนวโน้มไม่สามารถบรรลุข้อกำหนดของรายวิชา หรือมีข้อจำกัดจากบริบทของแหล่งฝึก เช่น จำนวนผู้ป่วยหรือกรณีศึกษาที่ไม่เพียงพอ หลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยอาจมีการปรับแผนการฝึกหรือปรับการหมุนเวียนแหล่งฝึก (Rotation) เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ เช่น การขยายพื้นที่ฝึกจากห้องฉุกเฉิน (ER) ไปยังหอผู้ป่วยใน (IPD) หรือแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเก็บประสบการณ์ทางคลินิกได้อย่างเพียงพอดังเอกสารแนบ

นอกจากนี้ หลักสูตรยังติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างการฝึกปฏิบัติ เช่น รายงานกรณีศึกษา (Case Report) และผลงานอื่น ๆ ตามที่รายวิชากำหนด หากพบว่าผู้เรียนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน จะมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้เรียนและปัจจัยแวดล้อมที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ก่อนกำหนดมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสม โดยยังคงรักษาคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาไว้

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลเป็นหลัก ขณะที่ผู้เรียนชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีการกำหนดจำนวนครั้งหรือระยะเวลาการฝึกที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ หลักสูตรใช้ข้อมูลจากแบบบันทึกการฝึก ตารางเวร และการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับ ติดตาม และปรับปรุงแผนการฝึก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้

AUN-QA 6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be available to improve learning experience and employablity.
มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการแข่งขันของผู้เรียน และการบริการสนับสนุนผู้เรียนด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน:

ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพและการเรียนรู้ความสามารถซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสการได้งานทำของนิสิต โดยมีกระบวนการดังนี้

1. ทางหลักสูตรจัดกิจกรรมที่นิสิตได้เข้าร่วมทุกปี เช่น การปฐมนิเทศน์นิสิต รับน้อง กิจกรรมไหว้ครู พิธีรับชุดปฏิบัติการ การฝึกอบรบฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การฝึกการจัดการสาธาณภัย และงานกีฬาสมาพันธ์นิสิตฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย

2. ทางหลักสูตรจัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ เตรียมพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ เช่น ออกหน่วยสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับอสม.เทศบาล ตำบลแม่กา การออกหน่วยค่ายสิงห์อาสา รวมถึงการออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ร่วมกับสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้มาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ฝึกทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนในการนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคต การฝึกงานของนิสิต เพื่อเรียนรู้เสริมทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพร่วมกับการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในหน่วยบริการ

3. ทางหลักสูตรส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายระหว่างสถาบัน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสมาพันธ์นิสิตฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 6.4.1 ตารางแสดงกิจกรรมโครงการวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2568

ลำดับ	โครงการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
1	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 (มิ.ย. 68)	พญ.มัลลิกา ขวัญเมือง
2	โครงการไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2568 (มิ.ย. 68)	อ.วรัทภพ แดนเขตต์
3	โครงการผูกข้อ ต่อขวัญ สานสัมพันธ์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2568 (มิ.ย. 68)	อ.ภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล
4	โครงการก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2568 ไพศาล (ก.ค. 68)	นพ.วรัญญู เหงี่ยมไพศาล
5	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตฉุกเฉินการแพทย์ (ก.ค. 68)	พญ.มัลลิกา ขวัญเมือง
6	โครงการนำเสนอวิจัยนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ก.พ. 69)	อ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์
7	โครงการพิธีรับเสื้อกาวน์ ชุดปฏิบัติการวิชาชีพและอุปกรณ์หูฟังทางการแพทย์ (มี.ค. 69)	แพทย์หญิงณัฐชยา กันทะเสนา
8	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตในการสอบ National license ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (มี.ค. 69)	อ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์
9	โครงการประมวลความรู้รวบยอด Comprehensive test หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ปีการศึกษา 2568 (มี.ค. 69)	อ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์
10	โครงการประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (พ.ค. 69)	อ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์

AUN-QA 6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to beevaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationshipsare shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.

ผลการดำเนินงาน:

ปีการศึกษา 2568 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานตำแหน่งของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อพันธกิจของหลักสูตร

คณะฯ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา

ดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ พร้อมได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความต้องการของหน่วยงาน

นอกจากนี้ คณะฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในรูปแบบฐานข้อมูลและ Excel Tracking Sheet เพื่อใช้ตรวจสอบความครบถ้วนของการพัฒนาตามแผน และเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี

ผลการติดตามดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการทบทวนการพัฒนาบุคลากรและการมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การให้บริการด้านการสนับสนุนนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการดำเนินงานของหลักสูตร

ตารางที่ 6.5-1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

ตำแหน่ง	จำนวน	ชื่อ - สกุล	ขอบเขตหน้าที่	ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน		
				คุณวุฒิ	กิจกรรมที่เข้าร่วม	หน่วยงานที่จัด
นักวิชาการศึกษา	**4**	1.นางสาวxxx xxx	1. วางแผนและประสานการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาและปฏิทินการศึกษา 2. จัดทำและตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ และการใช้ห้องเรียน 3. ประสานงานอาจารย์ผู้สอน นิสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการเรียนการสอน 4. ดำเนินงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น มคอ.3 มคอ.5 และเอกสารทางวิชาการอื่น 5. สนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 6.รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	xxx	1.การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 4 17 - 19 ก.พ. 69 2.โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI 25 - 26 ก.พ. 69	1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางที่ 6.5-2 ตัวอย่าง Excel รายงานการเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะรายบุคคล

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทการฝึกอบรม	หลักสูตร	สาระสำคัญ	สถานที่ฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	จำนวนชั่วโมง	งบประมาณ	วุฒิบัตร
คณะแพทยศาสตร์										
สำนักงานคณะแพทย์ศาสตร์										
1	นางสาวxxx xxx	นักวิทยาศาสตร์	สัมมนา	โครงการอบรมทักษะเชิงพื้นที่สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา	1. บรรยาย/กิจกรรม Workshop หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรเชิงพื้นที่บนฐาน SDGs และ Work From Area โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 2. บรรยายหัวข้อ SDGs: กับมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ แนวคิด การดำเนินการ ดัชนีชี้วัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) 3. แบบทดสอบหลังอบรม (Post–Test)	ห้อง UB001 มหาวิทยาลัยพะเยา และระบบออนไลน์ Microsoft Teams	21 พ.ค. 68	6.00	-	-

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทการฝึกอบรม	หลักสูตร	สาระสำคัญ	สถานที่ฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	จำนวนชั่วโมง	งบประมาณ	วุฒิบัตร
คณะแพทยศาสตร์										
สำนักงานคณะแพทย์ศาสตร์										
2	นางสาวxxx xxx	นักวิทยาศาสตร์	ฝึกอบรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกอบรมนักเทคนิค ด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์” (Simulation Technician)	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบจำลองทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ	ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	25-26 ก.ย. 68	15.30	-	-

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทการฝึกอบรม	หลักสูตร	สาระสำคัญ	สถานที่ฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	จำนวนชั่วโมง	งบประมาณ	วุฒิบัตร
คณะแพทยศาสตร์										
สำนักงานคณะแพทย์ศาสตร์										
3	นางสาวxxx xxx	นักวิชาการศึกษา	ฝึกอบรม	โครงการอบรมการจัดทำเล่มหลักสูตรสำหรับพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต ปีการศึกษา 2569	โครงการอบรมการจัดทำเล่มหลักสูตร สำหรับพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต ปีการศึกษา 2569 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยปฏิบัติตามนโยบายอัพเดทหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน สังคม และระบบบริการสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การทำงานเป็นทีมในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างศักยภาพผู้เรียนให้	ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี	5-6 ก.พ. 68	12.00	-	-

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทการฝึกอบรม	หลักสูตร	สาระสำคัญ	สถานที่ฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	จำนวนชั่วโมง	งบประมาณ	วุฒิบัตร
คณะแพทยศาสตร์										
สำนักงานคณะแพทย์ศาสตร์										
					พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์อย่างมืออาชีพ					

AUN-QA 6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement.
มีการประเมินผลการให้การบริการและสนับสนุนผู้เรียน มีการเทียบเคียงและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน:

ปีการศึกษา 2568 คณะฯ มีการจัดบริการและสนับสนุนผู้เรียนที่หลากหลาย ทางด้าน งานห้องสมุด ห้องเรียน เทคโนโลยี สารเทศ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ เป็นไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งมีการประเมินทรัพยากร การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ ผลการประเมินมาปรับปรุงให้การบริการและสนับสนุน ผู้เรียนให้ได้ดียิ่งขึ้น

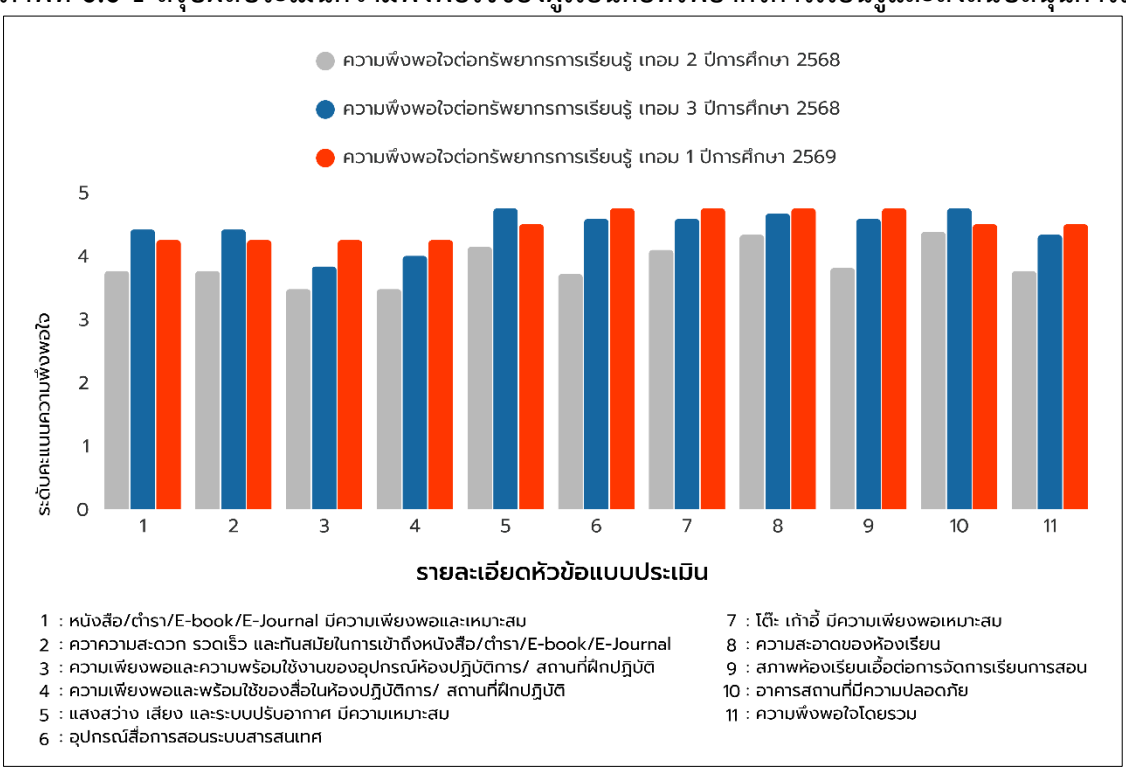
หลักสูตรดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา ผ่านระบบ Google Form เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียนสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินในปีการศึกษา 2568–2569 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากค่าเฉลี่ย 3.76 ในภาคการศึกษาที่ 2/2568 เป็น 4.33 ในภาคการศึกษาที่ 3/2568 และ 4.50 ในภาคการศึกษาที่ 1/2569 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ มีการพัฒนาสูงที่สุด โดยคะแนนความพึงพอใจต่ออุปกรณ์สื่อการสอนและระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นจาก 3.71 เป็น 4.75 (เพิ่มขึ้น 1.04 คะแนน) รองลงมา คือ สภาพห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจาก 3.81 เป็น 4.75 (เพิ่มขึ้น 0.94 คะแนน) ขณะที่ ด้านห้องปฏิบัติการและสถานที่ฝึกปฏิบัติ ทั้งความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 0.77 คะแนน ทั้งสองรายการ

นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อ ด้านห้องเรียนและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะความเหมาะสมของแสงสว่าง เสียง ระบบปรับอากาศ ความสะอาด และความเพียงพอของโต๊ะเก้าอี้ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.50–4.75 รวมถึง ด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง (4.38–4.75)

ภาพที่ 6.6-1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้



ผลการประเมินตนเอง

AUN-QA Criterion 6 – Student Support Services	ระดับ 2568
6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.	4
6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and community service.	4
6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary.	4
6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be available to improve learning experience and employability.	4
6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their continued	4

relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.	
6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement.	4
Overall opinion	4

รายการหลักฐาน AUN-QA 6

รหัสเอกสาร	**รายละเอียดเอกสาร**
6.1-1	รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 1
6.1-2	รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 2
6.1-3	รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 3
6.3-1	แบบบันทึกการเก็บหัตถการนิสิตฝึกงาน
6.3-2	ตารางเวรนิสิตก่อนและหลังปรับ Rotation
6.4-1	รวมภาพกิจกรรม โครงการประจำปีการศึกษา 2568
6.5-1	Job Description ของบุคลากรสายสนับสนุน
6.5-2	ข้อมูลบุคลากรสายสนัยสนุน
6.5-3	คำสั่งการจัดทำ IDP และตัวอย่างแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บุคลากรสายสนับสนุน
6.5-4	รายงานการเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะรายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน
6.6-1	รวมภาพอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
6.6-2	รายงานความพึงพอใจของผู้เรียนต่อทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

QR CODE เอกสารหลักฐาน

AUN - QA criterion 7 Facilities and Infrastructure

Sub Criterion 7

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient.
2. The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available,and effectively deployed.
3. A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.
4. The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.
5. The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, service, and administration.
6. The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be defined and implemented.
7. The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive for education, research, and personal well - being.
8. The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.
9. The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement.

AUN-QA 7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient.
มีทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการดำเนินการหลักสูตรรวมถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพียงพอ

ผลการดำเนินงาน:

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดเตรียมทรัพยากรทางกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยห้องเรียนทุกห้องได้รับการติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน การสอนที่พร้อมใช้งาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ จอรับภาพ ระบบเครื่องเสียง ไมโครโฟน และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องฟอกอากาศ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

คณะฯ มีระบบบริหารจัดการห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งอาจารย์บุคลากรและนิสิต สามารถจองใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการได้ทั้งในและนอกตารางเรียนพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านโสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อให้ทรัพยากรต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หลักสูตรยังสามารถใช้ทรัพยากรด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทำให้มีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา

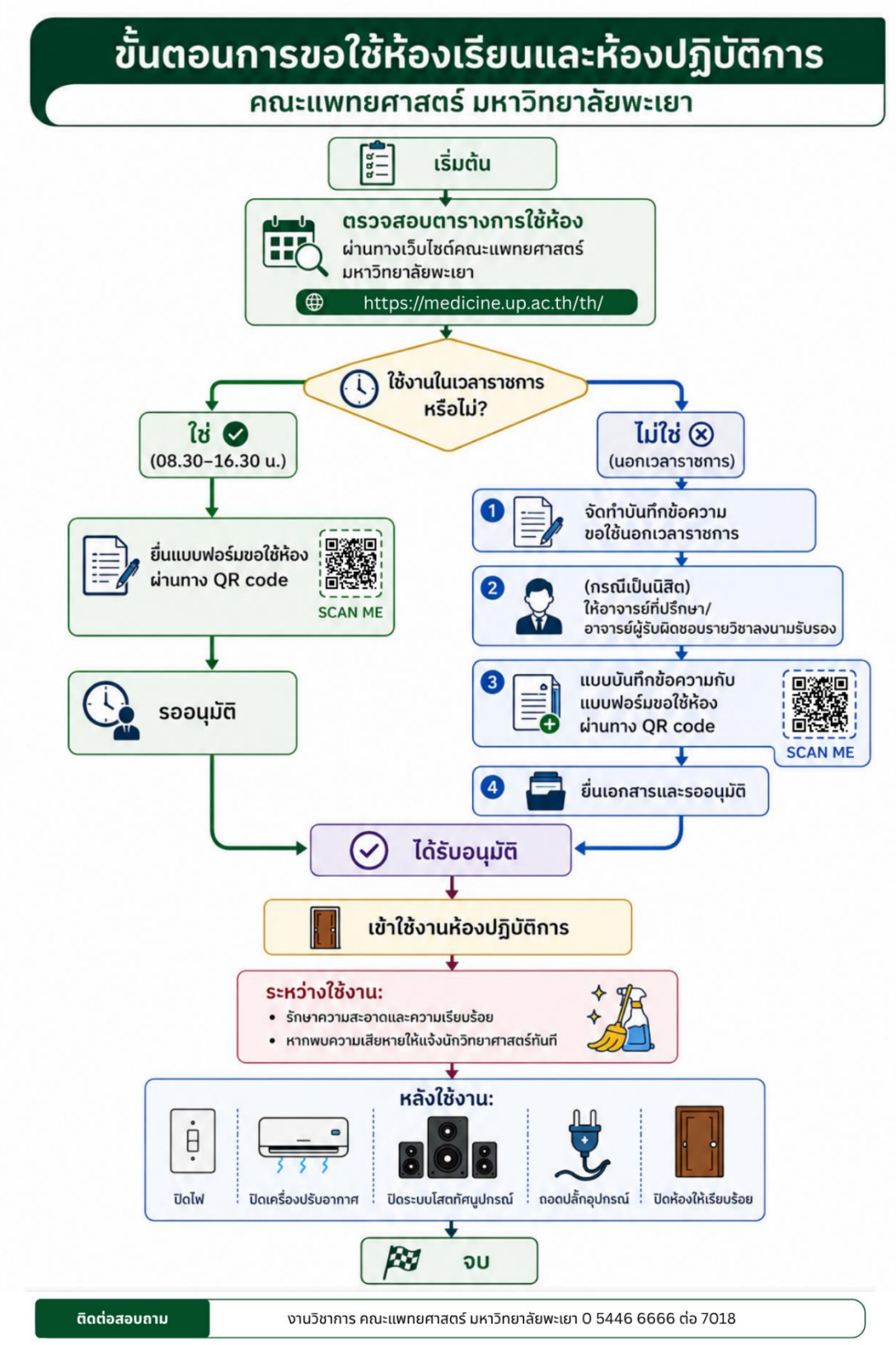
มหาวิทยาลัยพะเยาสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม ทั้งในอาคารเรียนและพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีระบบ Microsoft Teams, Zoom และ Google Meet สำหรับการจัดการเรียนการสอน การประชุม และการให้คำปรึกษา รวมถึงระบบ UP e-Learning, UP Academy และ MEDUP MOOC ซึ่งใช้เป็นแพลตฟอร์มในการเผยแพร่เอกสารประกอบการเรียน วิดีโอการสอน แบบทดสอบ และกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ นอกจากนี้ คณะฯ ยังสนับสนุนการใช้โปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการเรียนการสอน เช่น Complete Anatomy และสื่อดิจิทัลด้านกายวิภาคศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเองของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยและคณะฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้งานแก่ผู้สอนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรมีการสำรวจความต้องการด้านทรัพยากรการเรียนรู้ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนจัดหา พัฒนา และปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้ในทุกปีงบประมาณ โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

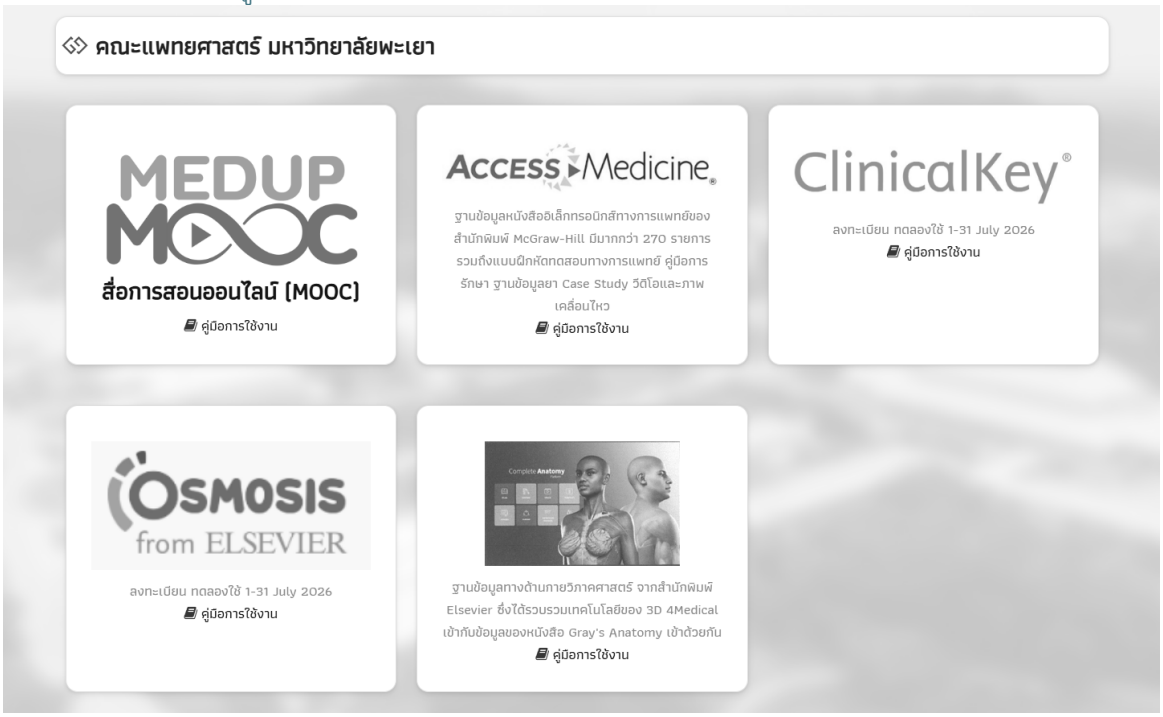
นอกจากนี้ หลักสูตรยังติดตามความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดหา พัฒนา และปรับปรุงอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

ภาพที่ 7.1-1 ขั้นตอนการขอใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

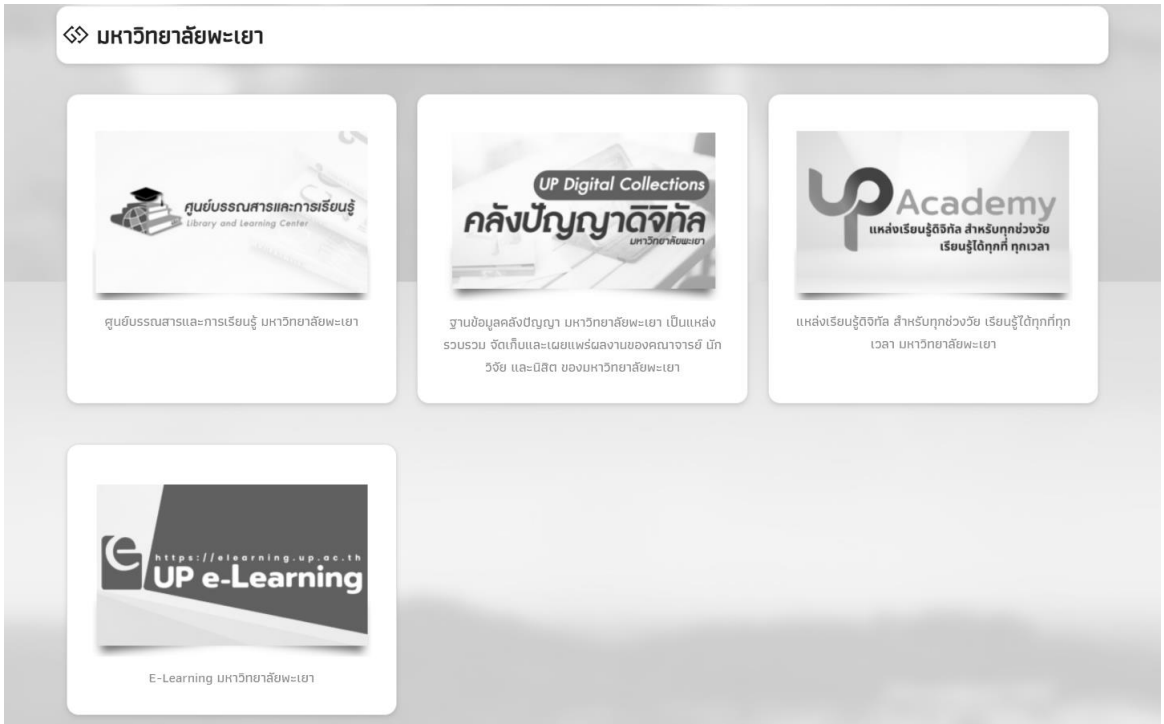
แบบฟอร์มจองห้องเรียน :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch7fAgoNEn5vtqNszvCfWtQqW989lQ4O5tWSCSQV1k_2F5cw/viewform



ภาพที่ 7.1-2 ทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลวิชาการด้านการแพทย์
เว็บไซต์ : คลังความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



ภาพที่ 7.1-3 ทรัพยากรของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์ : คลังความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



AUN-QA 7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively deployed.
มีห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สำหรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน และสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ โดยมีศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation Laboratory) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับฝึกทักษะทางคลินิก การฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินเสมือนจริงก่อนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และหุ่นฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เช่น หุ่นจำลองผู้ป่วยเสมือนจริง (SimMan) หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced CPR) หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่และทารกแรกเกิด หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG/EKG) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน บำรุงรักษา และทดแทนเมื่อชำรุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา

นอกจากนี้ หลักสูตรยังใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการของคณะร่วมผลิตและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น รายวิชาด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอยดูแลและสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

หลักสูตรมีระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการใช้งานห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการรับผิดชอบด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์ การดูแลรักษา การซ่อมบำรุง และการให้บริการยืมอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตรวมถึงมีการสำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์และจัดทำแผนจัดซื้อทดแทนหรือเพิ่มเติมในทุกปีงบประมาณเพื่อให้ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้

จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อทรัพยากรการเรียนรู้ของผู้เรียนในปีการศึกษา 2568–2569 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับสูงและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเพิ่มขึ้นจาก 3.76 ในภาคการศึกษาที่ 2/2568 เป็น 4.33 ในภาคการศึกษาที่ 3/2568 และ 4.50 ในภาคการศึกษาที่ 1/2569 นอกจากนี้ ความพึงพอใจด้านอุปกรณ์สื่อการสอนและระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นจาก 3.71 เป็น 4.75 ขณะที่ความเพียงพอและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นจาก 3.48 เป็น 4.25 เช่นเดียวกับความพร้อมของสื่อในห้องปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นจาก 3.48 เป็น 4.25 สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรมีการพัฒนาและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมและสามารถนำไปใช้สนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AUN-QA 7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.
มีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

ผลการดำเนินงาน:

คณะฯ จัดให้มีระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้นิสิต อาจารย์ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดโดยมี ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้พัฒนาและดูแลอำนวยความสะดวก โดยการ สืบค้นผ่านเว็บไซต์ https://lib.up.ac.th/ และมีระบบสืบค้น Online Public Access Catalog (OPAC) เป็นเครื่องมือในการช่วยสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด สำหรับการใช้งาน การสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดได้ตลอดเวลา นอกจากนี้มีฐานข้อมูล สำหรับการสืบค้น จากภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาได้อีกจำนวนมาก ทำให้ไม่มีข้อจำกัด ในเรื่องของเวลาและสถานที่ ในการค้นคว้า โดยผ่านระบบสืบค้นข้อมูล Online Databases ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศสหสาขาวิชา ระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ Academic Search Ultimate, Access Medicine, American Chemical Society Journal (ACS), ScienceDirect, Springer Link – Journal, Scopus, UpToDate เป็นต้น มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้นิสิตสามารถเข้าถึง E-journal ในรูปแบบฉบับเต็ม (Fulltext) นอกจากนี้มีฐานข้อมูล E-book ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่หลากหลาย ได้แก่ Cambridge Core, CU-eLibrary, 2ebook Digital Library, eBook Collection (EBSCOhost), SE-ED E-Library, UP Digital Library, e-Books Collection เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ E-Journals ที่หลากหลาย ได้แก่ Health Sciences, Science and Technology, Thai Journal Online (ThaiJO) เป็นต้น มีระบบ การยืมหนังสือต่อผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ account ของห้องสมุด เพื่อช่วยลดการเดินทางมาห้องสมุด มีการจัดทำคลิปวิดีโอสอนการใช้งานการสืบค้นข้อมูลต่างๆ มีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดคอยให้บริการ มีบริการสอบถามการใช้งานหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ตลอดปีการศึกษา ผ่านทางรายงานการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ บรรณสารและการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2568 แบบสอบถามมีความพึงพอใจการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมากมีช่องทางการติดต่อห้องสมุดผ่านสื่อออนไลน์ และเป็นช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ Instagram, Facebook, Line เป็นต้น นอกจากนี้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ในการแลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน (Resources sharing) เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสืบค้นและให้บริการระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ PILINET (ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค), ThaiLIS Service Working Group (คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา), Library of Congress, OCLC และ International Federation of Library Association and Institutions (IFLA) ทำให้นิสิตมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศมากขึ้นและสอดคล้องกับผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อทรัพยากร การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2568 ในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ ที่ให้บริการมีความหลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 4.39) ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว (คะแนนเฉลี่ย 4.49)

AUN-QA 7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.
มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน

ผลการดำเนินงาน:

คณะฯ ดำเนินการภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในระบบ REG, MIS ให้บริการนิสิตและบุคคลากร เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต ได้แก่ ระบบการลงทะเบียน ระบบการประเมินผู้สอน ระบบการประเมินรายวิชา ในส่วนของคณะฯ มีการติดตั้งระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน โดยมีการสำรวจ ความต้องการจำเป็น การจัดทำแผนกำหนดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอ เป็นประจำปีทุกปีงบประมาณ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริการวิชาการ การพัฒนาคุณภาพและการทำงานของบุคคลากร คือระบบ The Dashboard เช่น ระบบการกรอกข้อมูลบุคคล การบันทึกภาระงาน การลา การรายงานการเรียนการสอน มคอ.3, 4 ในปี 2568 คณะดำเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติงานย่อยภายใต้ระบบ The Dasgboard เพิ่มขึ้นอีก 3 ระบบ เพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการใช้งาน เช่น ระบบการจองรถ ระบบการจองห้องเรียน ระบบการส่งซ่อมบำรุง และมีเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้งานของแต่ละระบบ เป็นผู้กำกับติดตามการใช้งาน เมื่อเกิดปัญหาจะประสานผู้ดูแลระบบของคณะฯ เพื่อแก้ไขปัญหา ในเบื้องต้น และประสานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบซึ่งเป็นทีมงานภายนอกคณะฯ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

ภาพที่ 7.4-1 ระบบบริการการศึกษา
เว็บไซต์ : https://reg.up.ac.th/

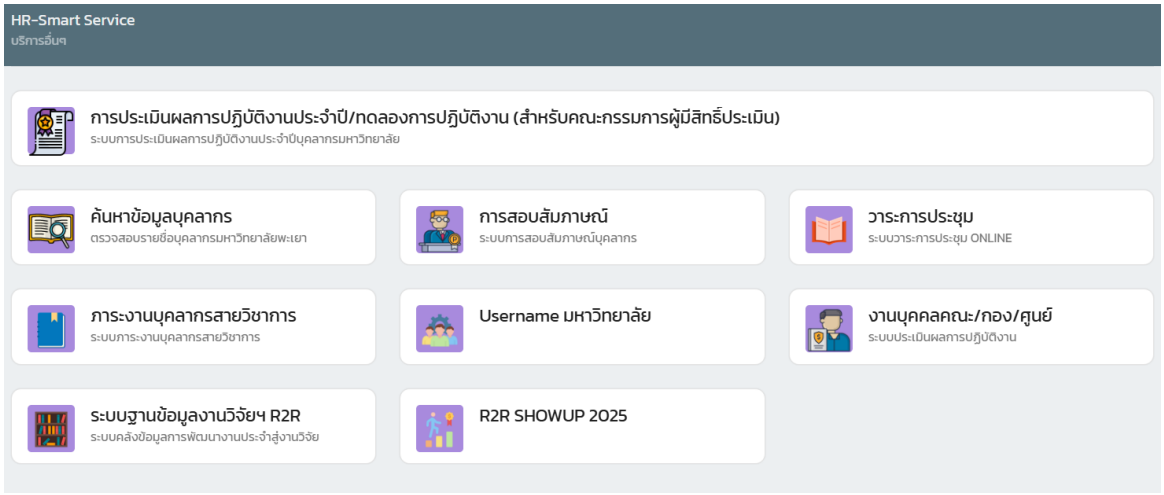


ภาพที่ 7.4-2 ระบบบริการให้คำปรึกษานิสิต



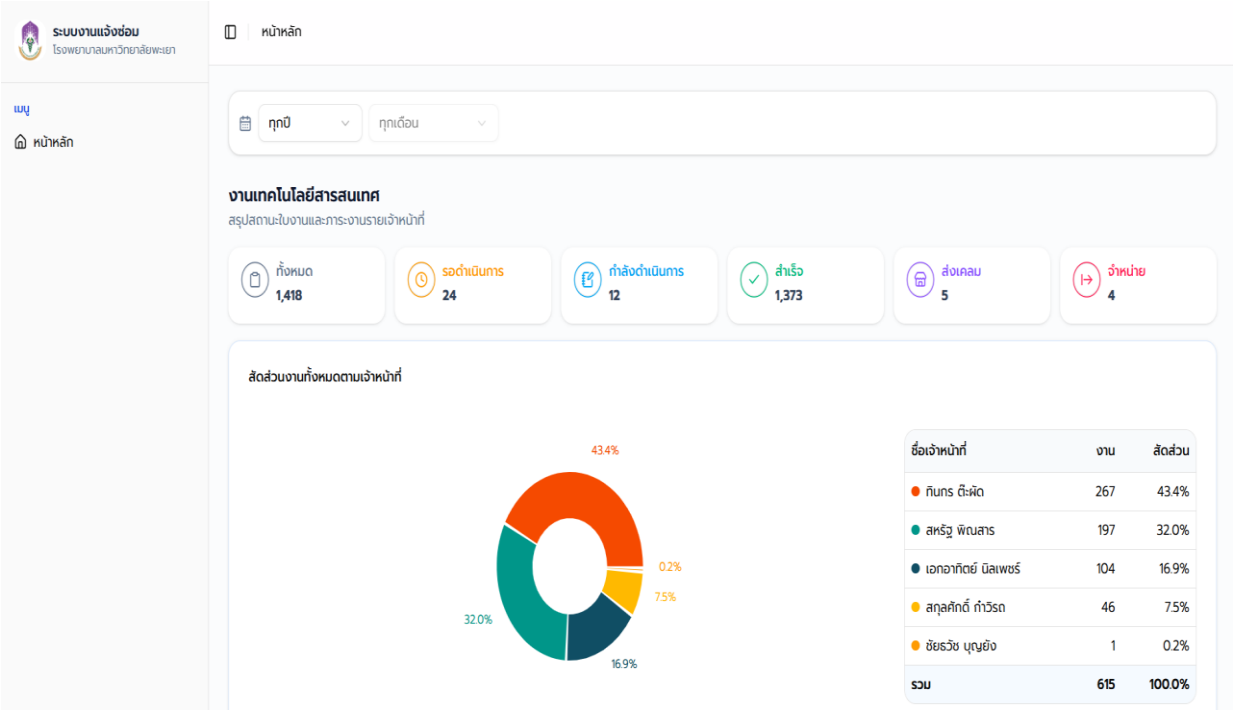
ภาพที่ 7.4-3 ระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

เว็บไซต์ : https://smarthr.up.ac.th/SMART/main/DefaultPage/default.aspx



ภาพที่ 7.4-4 ระบบงานแจ้งซ่อม

เว็บไซต์ : https://uphb.uph.up.ac.th/itservice



AUN-QA 7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, service, and administration.

มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการบริหารจัดการ

ผลการดำเนินงาน:

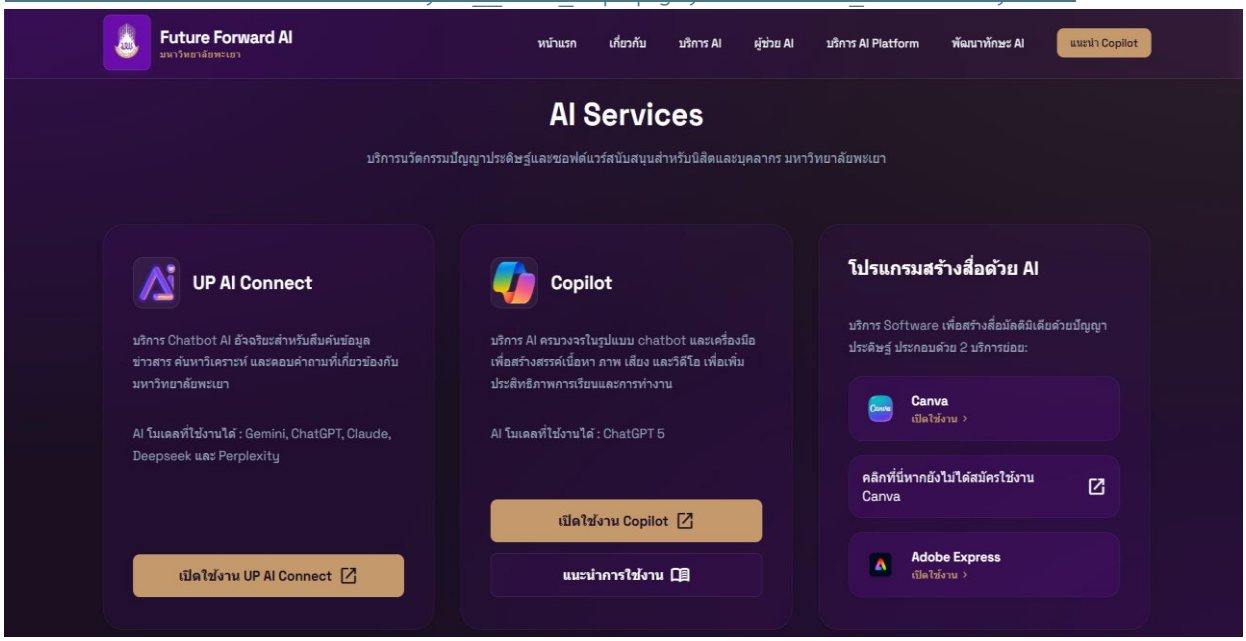
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และ WiFi Server สำหรับนิสิตและบุคลากรที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อลงและอัพเดทให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ ได้แก่ Windows, Microsoft Office, Endnote มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุด และมีบริการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบอัตโนมัติ โดยผ่านแอพลิเคชั้น ALIST ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนของคณะฯ จัดให้อาจารย์และบุคคลากร ทุกคนมีคอมพิวเตอร์ PC ใช้ทำงาน มีเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารทุกหน่วยงานอย่างเพียงพอ และมีห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลาสำหรับการใช้งานของนิสิตอย่างเพียงพอ ในการค้นคว้าอิสระ นิสิตสามารถใช้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เพื่อสืบค้นข้อมูล ทำรายงาน และมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน ทำหน้าที่ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และให้คำปรึกษา อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ส่วนการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ คณะฯ ดำเนินการดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมถึงตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย (IDS/IPS policy) เพื่อป้องกันทรัพยากรระบบสารสนเทศและข้อมูลบนเครือข่าย ภายในคณะฯ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพบปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้นเพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุด ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และตรวจสอบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เพื่อการสำรองข้อมูลสำคัญ กำหนดสิทธิผู้ใช้งานตามลำดับชั้น ความลับของข้อมูล และระดับของผู้ปฏิบัติการ และมีการสำรองข้อมูลเป็นประจำเพื่อการกู้คืน ในกรณีที่เกิดการเสียหาย มีบุคคลากรรับผิดชอบดูแล ใช้อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (firewall) และมีโปรแกรม antivirus ที่ได้รับการ update ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง จากผู้ผลิต มีระบบการตรวจสอบและแจ้งเตือนในกรณีอุปกรณ์ขัดข้องโดยการเตือนผ่าน E-mail ของผู้ดูแลระบบ

7.5-1 การเข้าใช้ระบบ IT

เว็บไซต์ :

https://ai.in.up.ac.th/?fbclid=IwY2xjawS9j2NleHRuA2FlbQIxMABicmlkETIxUm1MSXQ0cUdVQVRFMXNvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrMV0iz2eVVnrXRnKBecNgIXGBw3L9i4sVVUxAA-0aVtxVDhz4D89tO0y4n__aem_uqTqbgGyHIf0RBoCaa_QHA#ecosystem



AUN-QA 7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be defined and implemented.
มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงในการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

ผลการดำเนินงาน:

ด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ 8 ของไทย จาก 61 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 109 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 1,745 แห่ง ทั่วโลก โดยได้คะแนน 8,575 คะแนน การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Ranking เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจาก 6 ด้านสำคัญ ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2025 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคะแนนแบ่งตามเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้าน ได้ดังนี้

1. Setting and Infrastructure ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนน 1,225 คะแนน
2. Energy and Climate Change พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้คะแนน 1,725 คะแนน
3. Waste Management การจัดการขยะ ได้คะแนน 1,425 คะแนน
4. Water Management การจัดการน้ำ ได้คะแนน 887.5 คะแนน
5. Transportation การขนส่ง ได้คะแนน 1,650 คะแนน
6. Education and Research การศึกษาและวิจัย ได้คะแนน 1,662.5 คะแนน

เกณฑ์ตัวชี้วัดนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ สถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green) โดยผลการจัดอันดับดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยพะเยาในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน การบริหารจัดการขยะ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว และการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อความยั่งยืนในระดับชุมชนและสากล

มหาวิทยาลัยพะเยา แสดงศักยภาพและความก้าวหน้าในทุกเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยเฉพาะในด้านการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง ผลการจัดอันดับครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ตอกย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัย พะเยาในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยจะเดินหน้าส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทาง Green University ต่อไป

ในส่วนของคณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้กำหนดให้มีการดำเนินการพัฒนาระบบ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินงาน 8 กิจกรรม ภายใต้บริบทของความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยจัดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดแผนการ วิธีการ ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน ได้แก่ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5 ส) การจัดการขยะ การประหยัดน้ำไฟ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การนำน้ำผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ การสร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมคณะฯ สีเขียว การรณรงค์ขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์

ด้านความปลอดภัย คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินการจัดทำแผน และคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงในคณะฯ ซึ่งในปัจจุบันภายในคณะฯ มีมาตรการ

ควบคุมบุคลากรของคณะฯ และนิสิตในการเข้าใช้อาคาร เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอน หรือการค้นคว้าอิสระนอกเวลา ได้แก่กำหนดให้เข้ามาใช้ ห้องเรียนและอาคารเรียนได้ในเวลา วันจันทร์-ศุกร์ นอกจากนั้นได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีภัยให้กับนิสิตและบุคลากรของคณะปีละ 1 ครั้ง ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงในทุกอาคาร มีการตรวจสอบอาคารตามมาตรฐาน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและรอบอาคาร และมีแม่บ้านประจำอาคารดูแลรักษาความสะอาด ของพื้นที่เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ คณะฯ ได้ติดตั้งระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า (Face Recognition System) สำหรับการเข้า–ออกห้องสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ภายในคณะฯ อย่างเป็นระบบ

ด้านสุขภาพ คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดี มีมาตรการในการดูแลนิสิต ซึ่งได้จัดให้มีห้องพักสำหรับนิสิตป่วย มีอาจารย์และผู้ช่วยพยาบาลดูแลสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง มีการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนให้นิสิต บุคลากรตามนโยบายมหาวิทยาลัยและตามข้อกำหนด ของแหล่งฝึกปฏิบัติงานครบทุกคน มีการจัดสรรงบประมาณให้บุคคลากรทุกคนตรวจสุขภาพ เป็นประจำทุกปี และมีประกันภัยหมู่สำหรับนิสิต ในรายที่นิสิตมีอุบัติเหตุในการฝึกปฏิบัติงาน เช่น ได้รับของมีคมทิ่มตำ คณะฯ มีแนวปฏิบัติการดูแลนิสิต มีการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาการและเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีห้องออกกำลังกายของคณะฯ ให้บริการทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร และภายในมหาวิทยาลัยมีสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง (สนามบอล สระว่ายน้ำ สวนสุขภาพสำหรับวิ่งและทำกิจกรรมสันทนาการ) และสถานที่ออกกำลังกายในร่ม (สนามแบดมินตัน สนามวอลเล่ย์บอล สนามบาตเกตบอล) รวมทั้งฟิตเนตให้บริการทุกวัน

การเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ คณะฯ ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ทางลาดสำหรับผู้ใช้รถเข็นและผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า–ออกอาคาร รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการในบริเวณอาคาร เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการและการใช้งานอาคารของนิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อได้อย่างเหมาะสม

ภาพที่ 7.6-1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Ranking



ภาพที่ 7.6-2 โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2569



ภาพที่ 7.6-3 ระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า (Face Recognition System) สำหรับการเข้า–ออกห้องสำนักงาน





ภาพที่ 7.6-4 ห้องออกกำลังกายของคณะแพทยศาสตร์



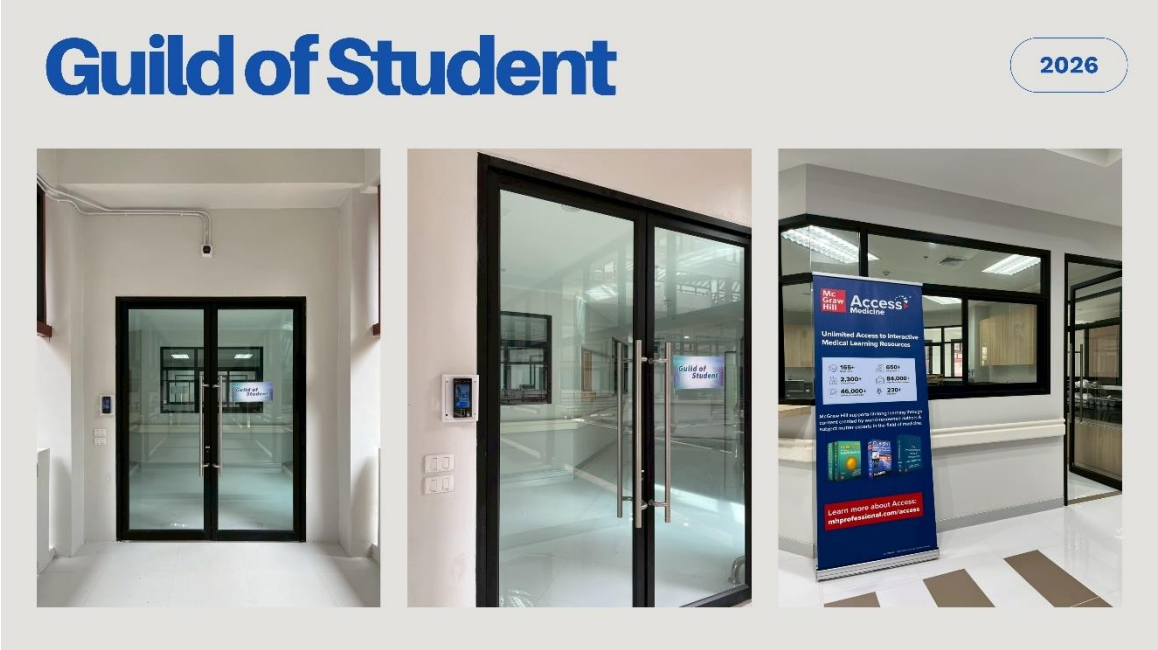
AUN-QA 7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive for education, research, and personal well – being
มหาวิทยาลัยมีการสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคมและจิตใจ ที่เอื้อต่อ การเรียนการสอน การวิจัย และสุขภาวะที่ดีของบุคคล

ผลการดำเนินงาน:

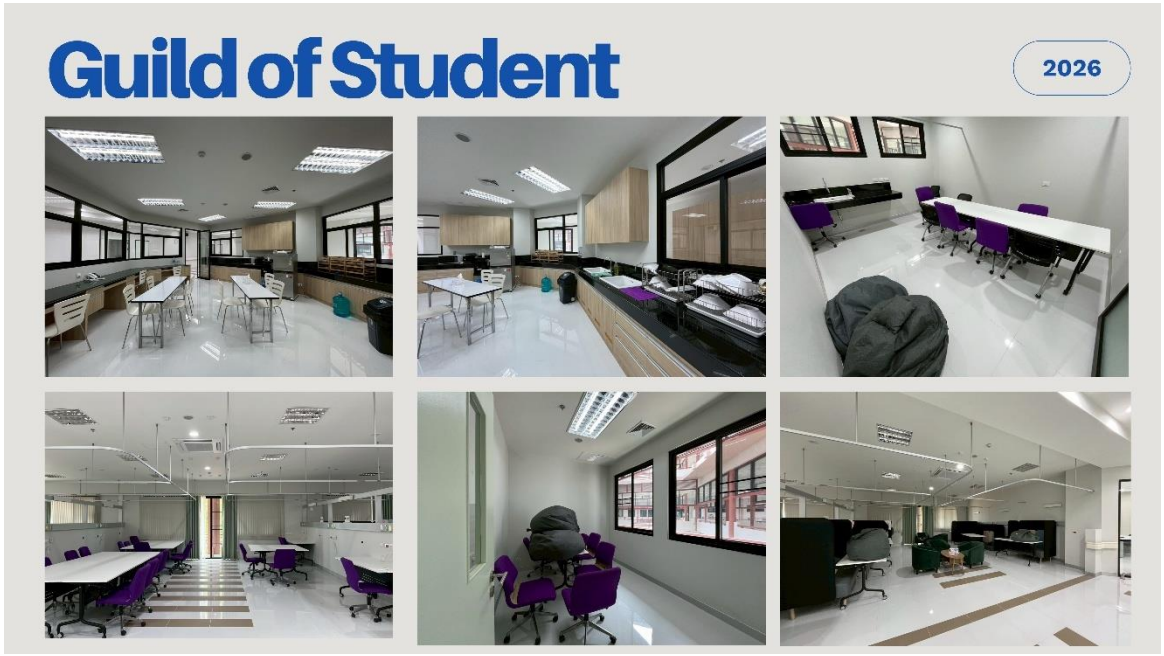
คณะฯ โดยสำนักงานคณบดีได้ดำเนินการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่อาศัย ได้แก่ สวนหย่อมรอบคณะฯ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีพนักงานรับผิดชอบทำความสะอาดทุกวัน และนิสิตมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดห้องพัก อาคารเรียน และดูแลสิ่งแวดล้อมทุกวัน ซึ่งช่วยให้นิสิตไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไปกลับบ้าน มีเวลาในการพักผ่อน เอื้อต่อการเรียนและสุขภาพที่ดีของนิสิต ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีพื้นที่ให้บริการเป็นสัดส่วน มีห้องประชุมย่อย

TV 50 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ มีคอมพิวเตอร์ ให้บริการสืบค้น 5 เครื่อง พร้อม WIFI ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ห้องสมุด เพื่ออำนวย ความสะดวก ให้นิสิตได้ใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานกลุ่ม หรือใช้เป็นห้องค้นคว้ากลุ่ม ห้องทำกิจกรรม เสริมหลักสูตรของนิสิต จำนวน 1 ห้อง ที่เปิดให้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ และนอกเวลาราชการ พร้อมโต๊ะเก้าอี้พร้อมใช้ และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้คณะฯ อำนวยความสะดวกให้มีการปรับเปลี่ยน ห้องเรียนเป็นห้องอ่านหนังสือ/ห้องกิจกรรม ห้องคาราโอเกะ ห้องดูหนัง (Guild of Student) ที่ศูนย์บรรณาสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดทำสวนหย่อม ให้ร่มรื่นบริเวณรอบอาคาร นิสิตสามารถใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการพักผ่อนได้ นอกจากนี้ คณะฯ ดำเนินการส่งเสริมและติดตามสุขภาวะทางจิตของนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลัยในการประเมินสุขภาพจิตนิสิตด้วยแบบประเมิน DASS-21 เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการเฝ้าระวัง ให้คำปรึกษา และวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตที่เหมาะสมกับนิสิตกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 7.7-1 ห้อง Guild of Student สำหรับการเรียนรู้และกิจกรรมของนิสิต







AUN-QA 7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.

มีการกำหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินงาน:

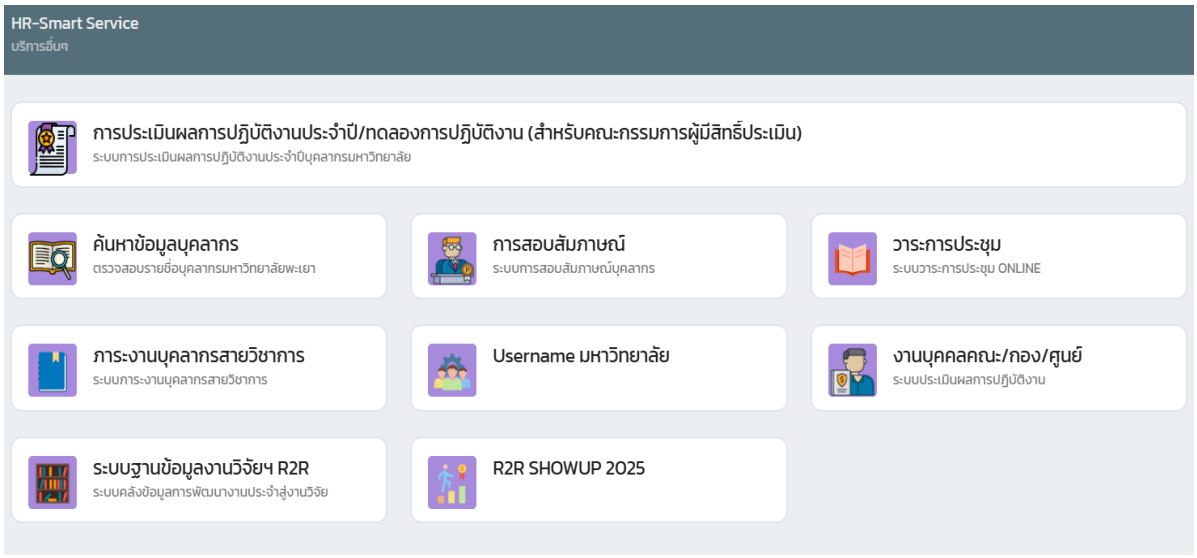
คณะฯ มีโครงสร้างการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายวิจัย โดยทุกตำแหน่งมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Description: JD) ที่ระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะฯ ได้กำหนดสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง (Functional Competency) ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบุคลากรทุกคนจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพของตนเอง พร้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ จำนวน 20,000 บาทต่อคนต่อปี

คณะฯ มีระบบกำหนดภาระงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งภาระงานประจำและภาระงานเชิงพัฒนา รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำผลการประเมินมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงสมรรถนะ และการวางแผนพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บุคลากรยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 7.8-1 ระบบกำหนดภาระงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
เว็บไซต์ : https://smarthr.up.ac.th/SMART/main/DefaultPage/default.aspx



AUN-QA 7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement.
มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการไอที และบริการนิสิต)

ผลการดำเนินงาน:

คณะฯ เปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินความต้องการและการใช้ ทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ จะนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากร ทางการศึกษาจากอาจารย์ ทั้งจำนวนและคุณสมบัติที่ต้องการสำหรับทรัพยากรเดิม ที่ต้องการเพิ่มและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นๆ ที่ต้องการ รวมทั้งพิจารณาจากผลการประเมิน การบริหารรายวิชาของปีการศึกษาก่อนหน้าเพื่อสนองต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะตามลำดับ เพื่อตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัย

2) ระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์และนิสิตสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อให้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาเพิ่มเติมได้โดยกรอกแบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ ซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับข้อ 1

3) สิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบวิชาจัดให้มีการประเมินผลรายวิชา คือ 1)ระหว่างอาจารย์ผู้สอน 2)นิสิต 3)ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียนในหลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิตในแหล่งฝึกที่ร่วมสอน อาจารย์พี่เลี้ยงและนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยประเมินความพึงพอใจและแสดงควาามคิดเห็นต่อทรัพยากรการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ในประเด็นจำนวน ความเพียงพอ ความพร้อมใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาและสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ซึ่งผู้รับผิดชอบวิชาจะนำผลการประเมินจากทั้ง 2 ส่วนมาบันทึกใน มคอ.5 หัวข้อทรัพยากรการเรียนรู้ หลังจากนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวบรวม ผลการประเมินทรัพยากรการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผลการประเมินตนเอง

AUN-QA Criterion 7– Checklist	**ระดับ 2568**
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient.	4
7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively deployed	4
7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.	4
7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.	4
7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, service, and administration.	4
7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be defined and implemented.	4
7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive for education, research, and personal well - being.	4

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.	4
7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement.	4
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)	**4**

รายการหลักฐาน AUN-QA 7

รหัสเอกสาร	**รายละเอียดเอกสาร**
7.1-1	ภาพทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการดำเนินการหลักสูตร
7.1-2	คู่มือการใช้งาน MEDUP COOC
7.1-3	คู่มือการใช้งาน Access Medicine
7.1-4	คู่มือการใช้งาน ClinicalKey และ Osmosis
7.1-5	คู่มือการใช้งาน Complete Anatomy
7.1-6	รายงานความพึงพอใจของผู้เรียนต่อทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7.2-1	ภาพสถานที่และวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกทักษะทางคลินิก
7.2-2	แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ
7.2-3	แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
7.3-1	รายงานการศึกษา ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ บรรณสารและการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2568
7.7-1	สิ่งอำนวยความสะดวกของนิสิตคณะแพทยศาสตร์
7.7-2	รายงานการประเมินสุขภาพจิตนิสิต ประจำปีการศึกษา 2568 เทอม 1
7.7-3	รายงานการประเมินสุขภาพจิตนิสิต ประจำปีการศึกษา 2568 เทอม 2
7.8-1	Job Description ของบุคลากรสายสนับสนุน
7.8-2	คำสั่งการจัดทำ IDP และตัวอย่างแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บุคลากรสายสนับสนุน

QR CODE เอกสารหลักฐาน

AUN - QA criterion 8 Output and Outcomes

Sub Criterion 8

1. The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
2. EmELOsyability as well as self-emELOsyment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
3. Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
4. Data are provided to show directly the achievement of the Programme outcomes, which are established and monitored.
5. Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

ผลการดำเนินงาน

AUN-QA 8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
จำนวนอัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการออกกลางคัน และเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษา ของผู้เรียนในหลักสูตร ถูกจัดเก็บ กำกับติดตาม และเทียบเคียงกับคู่เทียบเพื่อการพัฒนา มีข้อมูลผลผลิตและผลลัพธ์ในการดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินงาน:

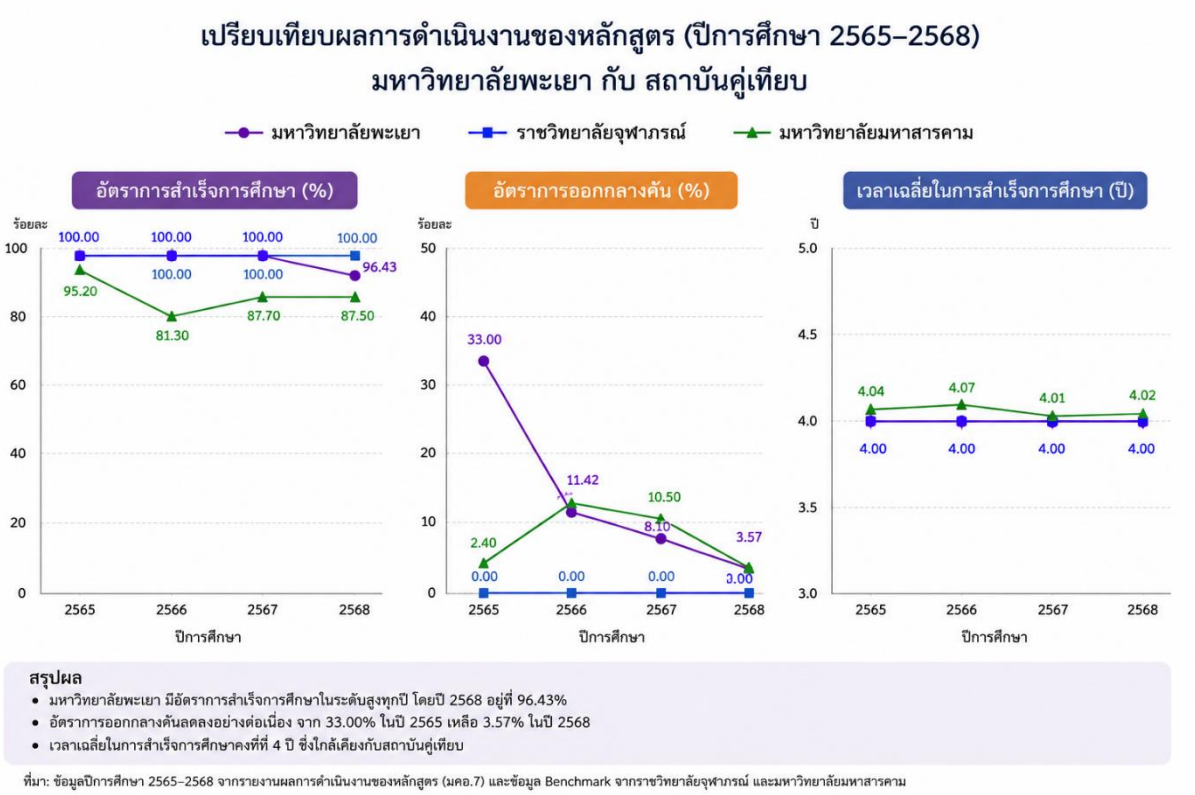
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีกระบวนการกำกับติดตามอัตราการสำเร็จการศึกษา (Pass Rate) อัตราการออกกลางคัน (Dropout Rate) และเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษา (Average Time to Graduate) อย่างเป็นระบบ โดยงานทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละปีการศึกษา และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มผลการดำเนินงาน ติดตามประสิทธิผลของการจัดการศึกษา และกำหนดแนวทางพัฒนาหลักสูตรตามวงจรการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: CQI)

หลักสูตรดำเนินการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน (Benchmarking) กับสถาบันที่มีบริบทใกล้เคียง ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และกำหนดมาตรการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 8.1-1

ตารางที่ 8.1-1 การเปรียบเทียบอัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการออกกลางคัน และเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษากับสถาบันคู่เทียบ

ตัวชี้วัด	ปี	มหาวิทยาลัยพะเยา	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อัตราการสำเร็จการศึกษา (%)	2565	100.00	100.00	95.20
	2566	100.00	100.00	81.30
	2567	100.00	100.00	87.70
	2568	96.43	100.00	87.50
อัตราการออกกลางคัน (%)	2565	33.00	0.00	2.40
	2566	11.42	0.00	12.50
	2567	8.10	0.00	10.50
	2568	3.57	0.00	2.10
เวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษา (ปี)	2565	4.00	4.00	4.04
	2566	4.00	4.00	4.07
	2567	4.00	4.00	4.01
	2568	4.00	4.00	4.02

ที่มา: ข้อมูลมหาวิทยาลัยพะเยาจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2568 และข้อมูล Benchmark จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

จากการติดตามผลย้อนหลัง 4 ปีการศึกษา (2565–2568) พบว่า หลักสูตรมีอัตราการสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2565–2567 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาร้อยละ 100 และในปีการศึกษา 2568 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาร้อยละ 96.43 เนื่องจากมีนักศึกษา 1 รายไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา อย่างไรก็ตาม อัตราการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรยังคงสูงกว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามในทุกปี และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อพิจารณาอัตราการออกกลางคัน พบว่าหลักสูตรสามารถลดอัตราการออกกลางคันได้อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 33.00 ในปีการศึกษา 2565 ลดลงเป็นร้อยละ 11.42 ในปีการศึกษา 2566 ร้อยละ 8.10 ในปีการศึกษา 2567 และลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.57 ในปีการศึกษา 2568 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของมาตรการติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง การดำเนินงานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การติดตามผลการเรียนรายภาคการศึกษา และการให้คำปรึกษาเชิงรุกด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ส่งผลให้สามารถลดการสูญเสียนักศึกษาระหว่างการศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาของหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาตามโครงสร้างหลักสูตร คือ 4 ปี อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหลักสูตร การวางแผนการเรียน การจัดการรายวิชา และการกำกับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับสถาบันคู่เทียบ

ผลการเปรียบเทียบกับสถาบันคู่เทียบแสดงให้เห็นว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีอัตราการสำเร็จการศึกษาร้อยละ 100 และไม่มีนักศึกษาลาออกกลางคันตลอดช่วงเวลาที่เปรียบเทียบ ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีแนวโน้มการสำเร็จการศึกษาและเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษาใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยพะเยา แต่มีความแตกต่างของอัตราการออกกลางคันในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้นำข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การนำผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนา (Continuous Quality Improvement: CQI)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่า ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรมีอัตราการออกกลางคันค่อนข้างสูง (ร้อยละ 33.00) จึงได้วิเคราะห์สาเหตุร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง พบว่านักศึกษาบางส่วนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิชาชีพ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรไม่เพียงพอก่อนเข้าศึกษา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาและการลาออกในช่วงปีแรกของการเรียน

หลักสูตรจึงกำหนดมาตรการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ได้แก่

1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรก่อนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้สมัครได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงสร้างหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Programme Learning Outcomes: PLOs) ลักษณะการจัดการเรียนการสอน และเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ ก่อนตัดสินใจเข้าศึกษา
2. ดำเนินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
3. พัฒนาระบบติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง (Early Warning System) จากผลการเรียน การเข้าเรียน และพฤติกรรมการเรียนรู้
4. จัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ การปรับตัว และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล
5. ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร

ผลจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวส่งผลให้อัตราการออกกลางคันของหลักสูตรลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก ร้อยละ 33.00 ในปีการศึกษา 2565 เหลือ ร้อยละ 11.42 ในปีการศึกษา 2566 ลดลงเป็น ร้อยละ 8.10 ในปีการศึกษา 2567 และลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 3.57 ในปีการศึกษา 2568 ขณะที่เวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษายังคงอยู่ที่ 4 ปี และอัตราการสำเร็จการศึกษายังคงอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 96.43–100.00)

ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า มาตรการที่หลักสูตรดำเนินการสามารถลดการลาออกกลางคันได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจต่อหลักสูตรและวิชาชีพมากขึ้นก่อนเข้าศึกษา สามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ดีขึ้น และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: CQI)

AUN-QA 8 . 2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

อัตราการได้งานทำ การประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ และการศึกษาต่อของผู้เรียนในหลักสูตรถูกจัดเก็บ กำกับติดตาม และเทียบเคียงกับเทียบเพื่อการพัฒนา

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีกระบวนการกำกับติดตามภาวะการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ และการศึกษาต่อของบัณฑิตอย่างเป็นระบบ โดยงานทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยดำเนินการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็น

ประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ติดตามแนวโน้ม และใช้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: CQI)

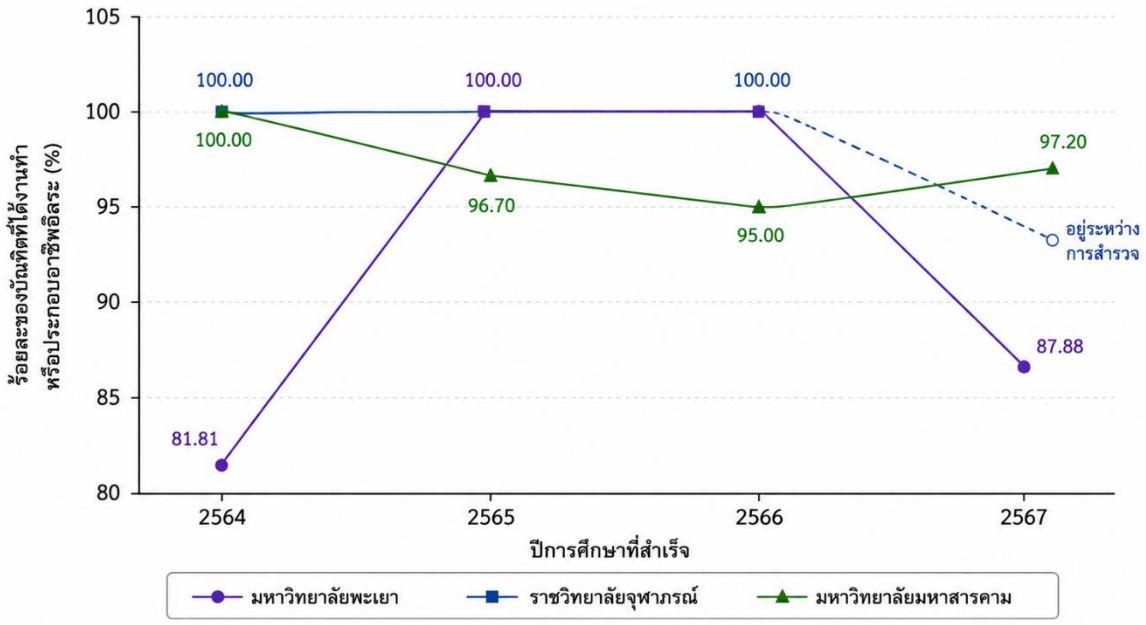
เพื่อประเมินประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต หลักสูตรได้ดำเนินการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน (Benchmarking) กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถาบันที่มีบริบทการจัดการศึกษาใกล้เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 8.2-1

ตารางที่ 8.2-1 การเปรียบเทียบร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่สำเร็จ	มหาวิทยาลัยพะเยา (%)	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (%)	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (%)
2564	81.81	100.00	100.00
2565	100.00	100.00	96.70
2566	100.00	100.00	95.00
2567	87.88	อยู่ระหว่างการสำรวจ	97.20

หมายเหตุ: ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา **2568** ของมหาวิทยาลัยพะเยา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ระหว่างการสำรวจภายหลังสำเร็จการศึกษา 1 ปี จึงยังไม่นำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบในรอบการประเมินนี้

กราฟที่ 8.2-1 การเปรียบเทียบร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา



หมายเหตุ: ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2568 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ระหว่างการสำรวจภายหลังสำเร็จการศึกษา 1 ปี จึงยังไม่นำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบในรอบการประเมินนี้

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

จากการติดตามข้อมูลย้อนหลัง 4 ปีการศึกษา (2564–2567) พบว่า หลักสูตรมีอัตราการได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตอยู่ในระดับสูง โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.81 ในปีการศึกษา 2564 เป็นร้อยละ 100.00 ในปีการศึกษา 2565 และ 2566 สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน

ในปีการศึกษา 2567 มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 33 คน พบว่ามีบัณฑิต 29 คน (ร้อยละ **87.88**) ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา ขณะที่มีบัณฑิต 3 คน (ร้อยละ **9.09**) ยังไม่มีงานทำ และมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ 1 คน โดยบัณฑิตที่มีงานทำส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รองลงมา ได้แก่ บริษัทหรือองค์กรเอกชน และรัฐวิสาหกิจ และร้อยละ **96.55** ปฏิบัติงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและผู้ใช้บัณฑิต

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำ พบว่า ทั้ง 3 คน ไม่ได้อยู่ในภาวะว่างงานจากการขาดโอกาสในการทำงาน โดยมี 1 คนประสงค์ประกอบอาชีพอิสระ และ 2 คนอยู่ระหว่างรอผลการคัดเลือกหรือการตอบรับจากหน่วยงานที่สมัครงาน จึงยังไม่ถูกนับเป็นผู้มีงานทำตามเกณฑ์ของการสำรวจภาวะการมีงานทำในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล สะท้อนให้เห็นว่าบัณฑิตยังคงมีแนวโน้มเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพตามแผนที่วางไว้

เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันคู่เทียบ พบว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีอัตราการได้งานทำร้อยละ 100 ในทุกปีที่รายงาน ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีอัตราการได้งานทำอยู่ระหว่างร้อยละ 95.00–100.00 โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสถาบันคู่เทียบ และยังคงสามารถผลิตบัณฑิตที่มีอัตราการได้งานทำในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

การนำผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนา (Continuous Quality Improvement: CQI)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและข้อมูลจากสถาบันคู่เทียบมาพิจารณาในการประชุมทบทวนหลักสูตรประจำปี และกำหนดแนวทางพัฒนา ดังนี้

1. ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานต้องการ
2. เพิ่มกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา เช่น การแนะแนวเส้นทางอาชีพ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพอิสระและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรองรับบัณฑิตที่ต้องการสร้างธุรกิจหรือประกอบอาชีพด้วยตนเอง
4. ขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาล หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการรับบัณฑิตเข้าปฏิบัติงาน
5. ติดตามภาวะการมีงานทำ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรในรอบปีการศึกษาถัดไป

ผลการดำเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีระบบการจัดเก็บข้อมูล การกำกับติดตาม การเปรียบเทียบกับสถาบันคู่เทียบ และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บัณฑิตมีอัตราการได้งานทำในระดับสูง มีโอกาสประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และมีความพร้อมทั้งในการประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาต่อ สอดคล้องกับข้อกำหนดของ AUN-QA Criterion 8.2 ที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลผลลัพธ์ของบัณฑิตเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบส่งเสริม กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิตอย่างเป็นระบบ โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การนำเสนอผลงานวิชาการ การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน และการได้รับทุนวิจัย พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการวิจัยของคณะ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ติดตามตัวชี้วัด และกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพงานวิจัยตามกระบวนการ **Continuous Quality Improvement (CQI)**

หลักสูตรดำเนินการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน (Benchmarking) กับสถาบันที่มีบริบทใกล้เคียง ได้แก่

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มและยกระดับคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียน

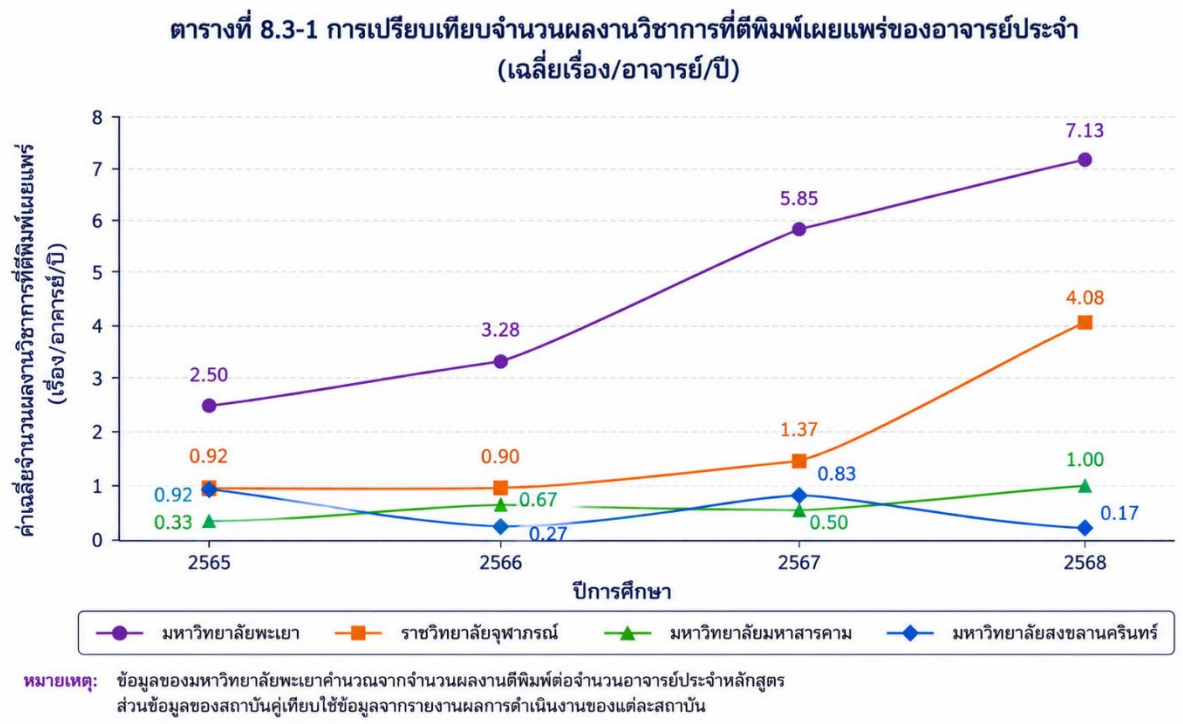
นอกจากนี้ หลักสูตรได้บูรณาการการวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดให้นิสิตทุกคนเรียนรายวิชาวิจัยในชั้นปีที่ 3 และดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การกำหนดปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การจัดทำโครงร่างวิจัย การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำรายงานวิจัย ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์จากแหล่งฝึก ก่อนนำเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 4

ครูพี่เลี้ยงและแหล่งฝึกสะท้อนว่าการดำเนินงานดังกล่าวช่วยให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางานประจำ อีกทั้งแหล่งฝึกยังสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้

ตารางที่ 8.3-1 การเปรียบเทียบจำนวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจำ (เฉลี่ยเรื่อง/อาจารย์/ปี)

ปีการศึกษา	มหาวิทยาลัยพะเยา	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2565	2.50	0.92	0.33	0.92
2566	3.28	0.90	0.67	0.27
2567	5.85	1.37	0.50	0.83
2568	7.13	4.08	1.00	0.17

หมายเหตุ: ข้อมูลของมหาวิทยาลัยพะเยาคำนวณจากจำนวนผลงานตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ส่วนข้อมูลของสถาบันคู่เทียบใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละสถาบัน



ตารางที่ 8.3-2 ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนิสิต

ปีการศึกษา	ผลงานวิจัยและการเผยแพร่
2566	นิสิตหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 24–26 มกราคม 2567 เรื่อง การศึกษาผลของ PM2.5 ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็ง
2568	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และนางสาวกัญญ์ภา รอดเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 84th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association (JCA) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25–27 กันยายน 2568 ภายใต้หัวข้อ *Believe in the Power of Cancer Research* โดยนำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ Dinactin exerts anti-cancer activity and its cellular mechanism of action และ Efficacy of Caffeic acid in Coffee on Colon and Liver cancer cells
2568	อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และ นางสาวอาภัสรา สารการ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม National EMS Forum 2026 การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 4–6 มีนาคม 2569 ณ จังหวัดนนทบุรี



การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัยย้อนหลัง พบว่าจำนวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 2.50 เรื่อง/อาจารย์/ปี ในปีการศึกษา 2565 เพิ่มเป็น 3.28 เรื่อง/อาจารย์/ปี ในปีการศึกษา 2566 และ 5.85 เรื่อง/อาจารย์/ปี ในปีการศึกษา 2567 ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 7.13

เรื่อง/อาจารย์/ปี ในปีการศึกษา 2568 สะท้อนถึงศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนงานวิจัยของหลักสูตร

เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันคู่เทียบ พบว่ามหาวิทยาลัยพะเยามีจำนวนผลงานวิชาการเฉลี่ยต่ออาจารย์สูงกว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทุกปี และสูงกว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในช่วงปีการศึกษา 2565–2567 แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยภายในหลักสูตร

ในด้านผู้เรียน หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตทุกคนดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลให้นิสิตมีทักษะด้านการวิจัย การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งได้รับโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13, การประชุมวิชาการระดับชาติ National EMS Forum 2026 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 84th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association (JCA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของอาจารย์และนิสิตในการสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การนำผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนา (Continuous Quality Improvement: CQI)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการติดตามตัวชี้วัดด้านการวิจัยและผลการเปรียบเทียบกับสถาบันคู่เทียบมาวิเคราะห์ในการประชุมทบทวนหลักสูตร และกำหนดแนวทางพัฒนา ดังนี้

1. สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนิสิตผ่านการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในเวทีวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับโรงพยาบาล หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมและการตีพิมพ์เผยแพร่
4. สนับสนุนการขอทุนวิจัย การพัฒนาบทความวิชาการ และการตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
5. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิตทุกปี พร้อมเปรียบเทียบกับสถาบันคู่เทียบ เพื่อนำผลเข้าสู่กระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร

ผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีระบบการส่งเสริม การกำกับติดตาม และการประเมินผลด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิตอย่างเป็นระบบ มีการใช้ข้อมูลจากสถาบันคู่เทียบเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนผลงานวิชาการของอาจารย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนิสิตสามารถสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ อันสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง Continuous Quality Improvement (CQI) และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ AUN-QA Criterion 8.3 อย่างเป็นรูปธรรม

AUN-QA 8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.
มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ถูกจัดเก็บ และกำกับติดตาม

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบกำกับติดตามผลการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) ตามแนวคิด Outcome-Based Education (OBE) โดยกำหนดให้มีการประเมินผลทั้ง Direct Assessment และ Indirect Assessment ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้สามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงก่อนสำเร็จการศึกษา

ข้อมูลผลการประเมินถูกจัดเก็บโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา งานวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผ่านรายงาน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 รวมถึงระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Course Assessment Verification) และรายงานผลการประเมินหลักสูตรประจำปี ก่อนนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ผลการบรรลุ PLOs และกำหนดแนวทางพัฒนาหลักสูตรตามวงจร Plan–Do–Check–Act (PDCA)

หลักสูตรใช้เครื่องมือประเมินผลโดยตรง (Direct Assessment) ที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ได้แก่

- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา (CLO Achievement)
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Course Assessment Verification)
- การสอบ Comprehensive Examination
- การสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
- การประเมินสมรรถนะระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน (Clinical Competency Assessment)
- การประเมินจากอาจารย์พี่เลี้ยงและแหล่งฝึก (Preceptor Evaluation)
- การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ผลงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต
- Portfolio และ Reflection Report

ขณะเดียวกัน หลักสูตรใช้การประเมินผลโดยอ้อม (Indirect Assessment) ผ่านแบบประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO Attainment Survey) ซึ่งให้นิสิตชั้นปีที่ 1–4 ประเมินตนเองตาม Sub-PLO จำนวน 26 ตัว ที่พัฒนาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อสะท้อนระดับการรับรู้ของผู้เรียนต่อการบรรลุสมรรถนะในแต่ละช่วงชั้นปี ดังแสดงใน ตารางที่ 8.4-1

ตารางที่ 8.4-1 ผลการประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLO Attainment) ของนิสิตชั้นปีที่ 1–4 ปีการศึกษา 2568

Sub PLOs	รายละเอียด	การบรรลุของ PLOs							
		นิสิตชั้นปีที่1 รหัส 68		นิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 67		นิสิตชั้นปีที่ 3 รหัส 66		นิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 65	
		$\bar{x}$	S.D.	$\bar{x}$	S.D.	$\bar{x}$	S.D.	$\bar{x}$	S.D.
PLO1	แสดงออกซึ่งจิตสำนึกและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	4.25	0.46	4.28	0.57	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO2	แสดงออกซึ่งจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม	4.38	0.52	4.28	0.67	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO3	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งในการดำรงตนและการปฏิบัติงานได้	4.25	0.46	4.33	0.59	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO4	เคารพกฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	4.25	0.46	4.56	0.62	5.0	0.0	4.71	0.49
PLO5	อธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง	4.25	0.46	4.06	0.54	4.8	0.45	4.43	0.53
PLO6	อธิบายความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านฉุกเฉินการแพทย์ สามารถบูรณาการและประยุกต์กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ	4.12	0.64	4.33	0.49	4.6	0.55	4.43	0.79
PLO7	อธิบายความรู้ความเข้าใจในคำสั่ง กฎ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์	4.12	0.64	4.0	0.69	4.8	0.45	4.29	0.76
PLO8	ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความรู้งานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ที่	4.12	0.83	3.94	0.54	4.8	0.45	4.43	0.98

	ค้นคว้า กับศาสตร์ด้านฉุกเฉินการแพทย์								
PLO9	แสดงความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ รวมทั้งประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้	4.12	0.64	4.22	0.55	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO10	แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติการด้านฉุกเฉินการแพทย์	4.25	0.46	4.22	0.65	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO11	ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในการวิเคราะห์และหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย	4.25	0.71	4.28	0.46	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO12	แสดงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม	4.38	0.52	4.33	0.69	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO13	แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน วางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	4.12	0.64	4.06	0.64	4.6	0.55	4.71	0.49
PLO14	แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.38	0.52	4.28	0.67	4.8	0.45	4.71	0.49

PLO15	แสดงความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	4.25	0.46	4.22	0.55	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO16	ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน	4.5	0.53	4.0	0.69	4.8	0.45	4.14	0.9
PLO17	ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	4.12	0.64	4.06	0.73	4.8	0.45	4.14	0.9
PLO18	แสดงทักษะการเลือกใช้ภาษาและรูปแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้	4.25	0.46	4.06	0.73	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO19	ประยุกต์ความรู้และคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม กับศาสตร์ที่ศึกษาได้	4.38	0.52	4.17	0.71	4.8	0.45	4.43	0.79
PLO20	ประยุกต์ความรู้และสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม	4.38	0.52	4.39	0.61	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO21	แสดงบุคลิกภาพตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม	4.25	0.46	4.39	0.7	4.8	0.45	4.71	0.49
PLO22	แสดงทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์	4.0	0.76	4.33	0.49	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO23	เลือกใช้มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินได้ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน	4.25	0.46	4.39	0.5	4.8	0.45	4.57	0.53
PLO24	ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	4.25	0.46	4.39	0.61	4.8	0.45	4.71	0.49

PLO25	บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้	3.88	0.83	4.11	0.83	4.8	0.45	4.43	0.79
PLO26	เลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	4.12	0.64	4.06	0.73	4.8	0.45	4.57	0.53

นอกจากการประเมินตนเองของผู้เรียนแล้ว หลักสูตรยังใช้ข้อมูลการประเมินผลโดยตรงเพื่อยืนยันการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 8.4-2

ตารางที่ 8.4-2 สรุปผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรจากการประเมินผลโดยตรง (Direct Assessment) ปีการศึกษา 2568

เครื่องมือประเมิน	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน	ผลการดำเนินงาน
Comprehensive Examination	ความรู้และการบูรณาการองค์ความรู้	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96.43
Objective Structured Clinical Examination (OSCE)	ทักษะวิชาชีพและการตัดสินใจทางคลินิก	ผ่านตามเกณฑ์หลักสูตร
Clinical Competency Assessment	สมรรถนะการปฏิบัติงานจริง	ผ่านเกณฑ์
Practicum Assessment	สมรรถนะระหว่างการฝึกปฏิบัติ	ผ่านเกณฑ์
Research Project และการนำเสนอผลงานวิจัย	การคิดวิเคราะห์ การวิจัย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	ผ่านเกณฑ์

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรของนิสิตชั้นปีที่ 1–4 พบว่า นิสิตมีระดับการบรรลุ Sub-PLO ทั้ง 26 ตัว อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดทุกตัวชี้วัด สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะตามลำดับขั้นของหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างชั้นปี พบว่านิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 มีระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้สูงกว่าชั้นปีต้นในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านจริยธรรมวิชาชีพ การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนตามแนวคิด Progressive Learning และ Outcome-Based Education

ผลการประเมินโดยตรงมีความสอดคล้องกับผลการประเมินโดยอ้อม กล่าวคือ ผลการสอบ Comprehensive Examination มีอัตราการผ่าน ร้อยละ 96.43 และผลการสอบ OSCE แสดงให้เห็นว่านิสิตมีสมรรถนะด้านการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพ การดูแลผู้บาดเจ็บ และการปฏิบัติหัตถการอยู่ใน

ระดับที่หลักสูตรกำหนด อย่างไรก็ตาม หลักสูตรพบว่าผลสัมฤทธิ์ในหัวข้อ Electrocardiogram Interpretation และ Unstable Bradycardia ต่ำกว่าหัวข้ออื่น จึงกำหนดเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

นอกจากนี้ ผลการประเมินจากอาจารย์พี่เลี้ยงและแหล่งฝึก รวมทั้งผลการประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และการตัดสินใจทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ขณะที่การดำเนินโครงการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านการวิจัย การคิดเชิงวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การนำผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนา (Continuous Quality Improvement: CQI)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการประเมินทั้งจาก Direct Assessment และ Indirect Assessment มาวิเคราะห์ร่วมกันในการประชุมทบทวนหลักสูตรประจำปี เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 8.4-3

ตารางที่ 8.4-3 การนำผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนา (CQI)

ผลการประเมิน	แนวทางปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ด้าน ECG Interpretation และ Unstable Bradycardia ต่ำกว่าหัวข้ออื่น	เพิ่ม Workshop ECG Interpretation และ Advanced Cardiac Life Support (ACLS)
ทักษะการตัดสินใจทางคลินิกในสถานการณ์วิกฤต	เพิ่ม Simulation-based Learning และ High Fidelity Simulation
การคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้	เพิ่ม Case-based Learning (CBL) และ Problem-based Learning (PBL)
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	ส่งเสริม Journal Club และ Research-based Learning
การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ	จัด Mock Comprehensive Examination และ Mock OSCE พร้อมระบบ Feedback รายบุคคล

หลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานของมาตรการดังกล่าวผ่านรายงาน มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และผลการประเมินการบรรลุ PLOs ในปีการศึกษาถัดไป เพื่อประเมินประสิทธิผลของการปรับปรุงและนำข้อมูลเข้าสู่การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

จากผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรมีระบบการจัดเก็บข้อมูล การประเมินผล การกำกับติดตาม และการวิเคราะห์การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลจาก Direct Assessment และ Indirect Assessment ร่วมกัน พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ Continuous Quality Improvement (CQI) ส่งผลให้สามารถแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการบรรลุ Programme Learning Outcomes ได้อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ AUN-QA Criterion 8.4

AUN-QA 8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established,monitored, and benchmarked for improvement.
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ถูกจัดเก็บ กำกับติดตาม และเทียบเคียงกับคู่เทียบเพื่อการพัฒนา

ผลการดำเนินงาน:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างเป็นระบบครอบคลุมผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พี่เลี้ยง แหล่งฝึก และหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต โดยข้อมูลถูกรวบรวมจากแบบประเมินของมหาวิทยาลัย การประเมินรายวิชา การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา การนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และข้อเสนอแนะจากการประชุมร่วมกับแหล่งฝึก ก่อนนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ผลและกำหนดแนวทางพัฒนาหลักสูตรตามวงจร Plan–Do–Check–Act (PDCA)

มหาวิทยาลัยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลังจากบัณฑิตสำเร็จการศึกษาและเข้าปฏิบัติงาน โดยส่งแบบประเมินไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของบัณฑิตเพื่อประเมินสมรรถนะของบัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Programme Learning Outcomes: PLOs) ครอบคลุม 8 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียศิลป์ การส่งเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพ และทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ ดังแสดงใน ตารางที่ 8.5-1

ตารางที่ 8.5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2565–2568

ผลลัพธ์การเรียนรู้	2565	2566	2567	2568
คุณธรรมและจริยธรรม	4.63	4.80	4.76	4.75
ความรู้	4.66	4.72	4.56	4.75
ทักษะทางปัญญา	4.63	4.67	4.70	4.75
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	4.70	4.60	4.73	4.75
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ	4.47	4.40	4.63	4.50

ผลลัพธ์การเรียนรู้	2565	2566	2567	2568
สุนทรียศิลป์	4.40	4.40	4.50	4.50
การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ	4.60	4.50	4.65	4.50
ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ	4.62	4.56	4.78	4.50
เฉลี่ยรวม	**4.59**	**4.58**	**4.67**	**4.63**

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในช่วงปีการศึกษา 2565–2568 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ระหว่าง 4.58–4.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกปีการศึกษา และสูงกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด สะท้อนให้เห็นว่าบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะที่หลักสูตรกำหนดและตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์พี่เลี้ยงที่สะท้อนว่า บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

ด้าน ทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.78 คะแนน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของบัณฑิตในการปฏิบัติงานจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บัณฑิตและแหล่งฝึกให้ข้อเสนอแนะว่าบัณฑิตบางส่วนยังควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมด้านความมั่นใจในการตัดสินใจทางคลินิก การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

นอกจากนี้ คณาจารย์ยังได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากการนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงและแหล่งฝึกเสนอให้เพิ่มโอกาสในการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และเพิ่มการใช้สถานการณ์จำลองที่มีความซับซ้อน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรดำเนินการเปรียบเทียบผลการประเมินกับข้อมูลของสถาบันคู่เทียบ ได้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละสถาบัน และนำแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงาน

ตารางที่ 8.5-2 การนำผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้เพื่อการพัฒนา (CQI)

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การดำเนินการปรับปรุง
เพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจทางคลินิก	เพิ่มการจัดการเรียนรู้แบบ Simulation-based Learning
เพิ่มประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต	เพิ่มชั่วโมงฝึกปฏิบัติในห้องฉุกเฉินและหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา	เพิ่มกิจกรรม Case-based Learning (CBL) และ Problem-based Learning (PBL)

การนำผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนา (Continuous Quality Improvement: CQI)

หลักสูตรนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มผลการประเมิน เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลจากสถาบันคู่เทียบ รวมทั้งกำหนดมาตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2568 นำไปสู่การเพิ่มกิจกรรม Simulation-based Learning, การพัฒนา High Fidelity Simulation, การขยายเครือข่ายแหล่งฝึก เพื่อยกระดับสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการของวิชาชีพ

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีระบบการจัดเก็บข้อมูล การกำกับติดตาม การเปรียบเทียบกับสถาบันคู่เทียบ และการนำข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้คุณภาพบัณฑิตและการจัดการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ Continuous Quality Improvement (CQI)

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา Criterion 8 (AUN-QA 8.1–8.5)

จุดเด่น (Strengths)

1. หลักสูตรมีระบบติดตามผลลัพธ์ของหลักสูตร (Programme Outcomes Monitoring) ที่ครอบคลุมและเป็นระบบ หลักสูตรมีการจัดเก็บ กำกับติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งอัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการออกกลางคัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทำ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO Attainment) และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลจากทั้ง Direct Assessment และ Indirect Assessment เพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)

2. หลักสูตรใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และ Benchmarking เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ดำเนินการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับสถาบันคู่เทียบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านอัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการมีงานทำ และผลงานวิจัย

ของอาจารย์ ทำให้สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และนำแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพของหลักสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. หลักสูตรนำผลการประเมินเข้าสู่กระบวนการ Continuous Quality Improvement (CQI) อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินจากผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์พี่เลี้ยง และแหล่งฝึก ถูกนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกปี เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การพัฒนารายวิชา การเพิ่มกิจกรรม Simulation-based Learning, Case-based Learning (CBL), Problem-based Learning (PBL) การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ Comprehensive Examination และ OSCE รวมทั้งการพัฒนาระบบดูแลนักศึกษา ส่งผลให้อัตราการออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 33.00 เหลือ 3.57 และยังคงรักษาอัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับสูง

4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิตอย่างโดดเด่น หลักสูตรบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นิสิตดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก และนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ขณะที่อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีค่าเฉลี่ยผลงานวิชาการต่ออาจารย์สูงกว่าสถาบันคู่เทียบหลายแห่ง สะท้อนถึงวัฒนธรรมการวิจัยที่เข้มแข็งของหลักสูตร

โอกาสในการพัฒนา (Areas for Improvement)

1. พัฒนาระบบติดตามผลลัพธ์ของบัณฑิตในระยะยาว (Graduate Tracking System) ควรพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เช่น ตำแหน่งงาน ความก้าวหน้าในการทำงาน การศึกษาต่อ การได้รับใบประกอบวิชาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลผลลัพธ์ระยะยาวในการพัฒนาหลักสูตรได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

2. ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับสมรรถนะวิชาชีพในอนาคต แม้ผู้ใช้บัณฑิตจะมีความพึงพอใจในระดับสูง แต่ยังมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจทางคลินิก การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่ซับซ้อน และการสื่อสารในภาวะวิกฤต ดังนั้นหลักสูตรควรเพิ่มการจัดการเรียนรู้ด้วย High-Fidelity Simulation, Interprofessional Education (IPE), Case-based Learning (CBL) และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้มากขึ้น

3. เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ แม้หลักสูตรมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ควรส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพสูง การสร้างเครือข่ายวิจัยกับสถาบันต่างประเทศ การขอทุนวิจัยภายนอก และการผลักดันให้นิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลกระทบทางวิชาการ (Research Impact) และความเป็นนานาชาติของหลักสูตร

4. ขยายระบบ Benchmarking ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ของหลักสูตรมากขึ้น ปัจจุบันหลักสูตรมีการเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญกับสถาบันคู่เทียบหลายแห่งแล้ว ในระยะต่อไปควรขยายการ Benchmark ไปยังตัวชี้วัดด้านผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ ระดับการบรรลุ PLO ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความก้าวหน้าในวิชาชีพของบัณฑิต เพื่อให้การเปรียบเทียบมีความครอบคลุมและสามารถใช้เป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้น

ผลการประเมินตนเอง

AUN-QA Criterion 8 – Checklist	ระดับ 2568
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	4
8.2 EmELOsyability as well as self-emELOsyment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3
8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3
8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.	3
8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)	**3**

ตารางสรุปเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน AUN-QA Criterion 8.1–8.5

Criterion	รหัสหลักฐาน	เอกสารหลักฐาน
AUN-QA 8.1	AUN8.1-1	รายงานอัตราการสำเร็จการศึกษา (Graduation Rate)
	AUN8.1-2	รายงานอัตราการออกกลางคัน (Dropout Rate)
	AUN8.1-3	รายงานระยะเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษา (Average Time to Graduate)
	AUN8.1-4	ข้อมูลนิสิตจากระบบทะเบียน REG
	AUN8.1-5	รายงานการติดตามความก้าวหน้าของนิสิต
	AUN8.1-6	รายงานวิเคราะห์สาเหตุการออกกลางคัน
	AUN8.1-7	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่ของนิสิต
	AUN8.1-8	Benchmarking Report ด้าน Graduation Rate และ Dropout Rate
AUN-QA 8.2	AUN8.2-1	รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
	AUN8.2-2	แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
	AUN8.2-3	รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำ
	AUN8.2-4	รายงานการศึกษาต่อของบัณฑิต

	AUN8.2-5	รายงานการประกอบอาชีพอิสระ/ผู้ประกอบการ
	AUN8.2-6	ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
	AUN8.2-7	แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต
	AUN8.2-8	รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
	AUN8.2-9	Benchmarking Report ด้าน Employability
AUN-QA 8.3	AUN8.3-1	รายชื่อผลงานวิจัยของนิสิต
	AUN8.3-2	รายงานโครงงานวิจัยนิสิต
	AUN8.3-3	Poster Presentation
	AUN8.3-4	Proceedings การประชุมวิชาการ
	AUN8.3-5	หนังสือรับรองการนำเสนอผลงานวิชาการ
	AUN8.3-6	รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์
	AUN8.3-7	รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
	AUN8.3-8	รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
	AUN8.3-9	Benchmarking Report ด้าน Research Output
AUN-QA 8.4	AUN8.4-1	รายงานผลการบรรลุ PLOs (PLO Attainment Report)
	AUN8.4-2	Curriculum Mapping
	AUN8.4-3	CLO–PLO Mapping
	AUN8.4-4	รายงานผลการสอบ Comprehensive Examination
	AUN8.4-5	Blueprint การสอบ Comprehensive Examination
	AUN8.4-6	รายงานผลการสอบ OSCE
	AUN8.4-7	แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน (Practicum Assessment)
	AUN8.4-8	รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
	AUN8.4-9	รายงานผลการสอบใบประกอบวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
	AUN8.4-10	มคอ.5
	AUN8.4-11	มคอ.6
	AUN8.4-12	มคอ.7
	AUN8.4-13	รายงานผลการสอบรับรองปริญญาจาก สพฉ.
	AUN8.4-14	รายงานผลการสอบ National License Examination
AUN-QA 8.5	AUN8.5-1	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
	AUN8.5-2	รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
	AUN8.5-3	แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบัน
	AUN8.5-4	รายงานผลความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบัน
	AUN8.5-5	แบบประเมินความพึงพอใจของศิษย์เก่า

AUN8.5-6	รายงานผลความพึงพอใจของศิษย์เก่า
AUN8.5-7	แบบประเมินความพึงพอใจของแหล่งฝึก
AUN8.5-8	รายงานการนิเทศฝึกปฏิบัติงาน
AUN8.5-9	Stakeholder Satisfaction Report
AUN8.5-10	รายงานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
AUN8.5-11	CQI Report
AUN8.5-12	Benchmarking Report ด้าน Stakeholder Satisfaction
AUN8.5-13	รายงานความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก (Preceptor Satisfaction Report)

QR CODE เอกสารหลักฐาน

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA

ตัวบ่งชี้ (Indicators)	**ระดับ**
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน	เป็นไปตามเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร	
AUN. 1 Expected Learning Outcomes	
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.	4
1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.	4
1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline).	4
1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes.	4
1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate.	4
AUN. 2 Programme Structure and Content	
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.	3
2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes.	4
2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders.	4
2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear.	3
2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.	4
2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations.	3

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.	4
AUN. 3 Teaching and Learning Approach	
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.	4
3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process.	4
3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students.	4
3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices).	4
3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.	4
3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.	4
AUN. 4 Student Assessment	
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives.	4
4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.	4
4.3 The assessment standards and procedures for student rogression and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.	4
4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.	4
4.5 The assessment methods are shown to measure the chievement of the expected learning outcomes of the programme and its courses.	4
4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.	4

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes.	4
AUN. 5 Academic Staff	
5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-deELOsyment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.	3
5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of education, research, and service.	3
5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, and communicated.	3
5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude.	4
5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which accounts for teaching, research, and service.	4
5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.	4
5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs.	3
5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.	4
AUN. 6 Student Support Services	
6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.	4
6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and community service.	4
6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload monitoring. Student progress, academic	4

performance, and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary.	
6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be available to improve learning experience and emELOsyability.	4
6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deELOsyment. These competences are shown to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.	4
6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement.	4
AUN. 7 Facilities and Infrastructure	
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient.	4
7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively deELOsyed.	4
7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.	4
7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.	4
7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exELOsit information technology for teaching, research, service, and administration.	4
7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be defined and implemented.	4
7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive for education, research, and personal well - being.	4
7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.	4
7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement.	4

AUN. 8 Output and Outcomes	
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	4
8.2 EmELOsyability as well as self-emELOsyment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3
8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3
8.4 Data are provided to show directly the achievement of the Programme outcomes, which are established and monitored.	3
8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3
ระดับในภาพรวม (Overall opinion)	**4**

รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา CAR-AUN- QA 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพ ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) และจุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้

ตัวบ่งชี้ (Indicators)	**จุดแข็ง**	**เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้**
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน	1. หลักสูตรมีการกำกับดูแลคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่ อว. กำหนด 2. อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ) เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. อาจารย์ผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการพัมนาและดำเนินกิจกรรมของหลักสูตร	1. การพิจารณาเพิ่มจำนวนหรือเพิ่มขีดความ สามารถของผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อให้หลักดำเนินกิจกรรมผ่านความเชี่ยวชาญที่มีความจำเพาะกับหลักสูตรและวิชาชีพได้ดี มากขึ้น 2. การผลักดันให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการ ผลิตผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางด้านฉุกเฉินการแพทย์หรือที่เกี่ยวข้อง
AUN. 1 Expected Learning Outcomes	1.1.1 จาก มคอ.2 หน้า 7-9 และ SAR หน้าที่ 6-8 และ 21-22 มีการกำหนด Program Learning Outcomes (PLOs) จำนวน 8 ด้าน (รวม sub-PLOs เป็น 26 ข้อ) และมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs และพบความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 1.1.2 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร พบว่ามีการนำพันธกิจ วิยัทัศน์ของ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (สพฉ.) รวมทั้งข้อมูลจากการสอบถามศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต มารวบรวมเป็น PLOs ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต ตามระบบ TQF	1.1.1 จาก มคอ.2 หน้า 7-9 และ SAR หน้าที่ 6-8 การเขียน PLOs ยังไม่เป็นไปตามหลัก SMART (เฉพาะเจาะจง, สามารถวัดผลได้, ผู้เรียนบรรลุได้, ความสอดคล้อง และมีกำหนด ระยะเวลาชัดเจน) ยังมีคำที่ไม่เป็นรูปธรรม เช่น อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ อย่างเหมาะสม และการเขียน PLOs ยังไม่เป็นไปตามหลัก SMART 1.1.2 SAR หน้าที่ 23 แสดงกลุ่ม Stakeholder (SHs) ที่ต้องการเผยแพร่ Program Learning Outcomes (PLOs) ได้แก่ผู้สอน และผู้เรียน

	1.2.1 จากตัวอย่าง มคอ.3 พบว่า หลักสูตร มี มคอ.3 ของบางรายวิชา และแสดงความสอดคล้อง ระหว่าง Course learning outcomes (CLOs) และ PLOs 1.2.2 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน พบว่า การจัดทำ CLOs ดำเนินการตามเล่ม มคอ. 2 และมาตรฐาน ตามเกณฑ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1.3.1 จาก SAR หน้าที่ 6-8 และ 21-22 พบว่า PLOs ประกอบด้วย generic outcomes และ subject specific outcomes 1.4.1 จาก SAR หน้าที่ 32-34 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรมีการกำหนด SHs ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม มคอ.1 อัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย และสอบถามความเห็นจาก นิสิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต โดยแบ่งเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ภายนอก และในอนาคต ผ่านแบบสอบถามและแบบประเมินออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมปรับปรุงแบบประเมินให้ตรงประเด็น และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเชิงลึก ด้วยคำถามปลายเปิด 1.5.1 จาก SAR หน้าที่ 35-36 มีการแสดง วิธีการ เกณฑ์ หรือเครื่องมือในการวัดการบรรลุ PLOs ในแต่ละข้อ 1.5.2 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร พบว่าหลักสูตรมีการ จัดสอบ Comprehensive (มีเกณฑ์ 60%) รวบยอดเนื้อหาชั้นปีที่ 1-4 และมีการสอบ OSCE (มีเกณฑ์ 80%) มีการแยกหมวดหมู่การสอบของ ข้อสอบ และให้สอบซ่อมจนกว่าจะผ่าน	แต่กระบวนการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจ PLOs ยังไม่ชัดเจน หลักสูตรพึงควรเพิ่มการสื่อสาร PLOs ไปยัง SHs ที่กำหนด 1.1.3 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่ามีใช้ Bloom Taxonomy 3 โดเมน ได้แก่ Cognitive, Psychomotor, Attitude ประกอบในการสร้าง PLOs แต่ยังไม่พบระดับการเรียนรู้ที่จำเพาะเจาะจง ในแต่ละโดเมน 1.2.1 จาก มคอ. 3 บางรายวิชา ยังไม่มีการแสดง CLOs จึงยังไม่พบการแสดงความสอดคล้อง ระหว่าง CLOs และ PLOs และ CLO ที่เป็นรูปธรรม (SMART) 1.2.2 CLOs บางรายวิชายังไม่เป็น action verb ที่สามารถวัดประเมินได้ และเนื่องจากยังไม่พบการใช้ learning taxonomy ในการจัดทำ PLOs จึงยังไม่พบระดับ learning taxonomy ใน CLOs เช่นกัน 1.3.1 จาก SAR หน้าที่ 30-31 หลักสูตรพึงควรทบทวน การจำแนก PLOs generic outcomes และ subject specific outcomes เช่น PLO3 อาจจัดเป็น specific outcomes 1.4.1 จาก SAR หน้าที่ 34 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แสดงตาราง รวบรวม ข้อมูลความเห็น SHs แต่ยังไม่พบขั้นตอนการวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลความต้องการของ SHs

		โดยเฉพาะ External SHs ที่รวบรวมมา เพื่อนำไปสร้าง PLOs 1.5.1 จาก SAR หน้าที่ 35-36 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระบุว่า มีการกระจายผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) อย่างเป็นระบบ แต่พบว่าหลายรายวิชายังไม่มี CLOs 1.5.2 จาก SAR หน้าที่ 38 หลักสูตรแสดงข้อมูลการประเมิน PLOs 8 ด้าน จากผู้ใช้บัณฑิต แต่ไม่มีการประเมิน sub-PLOs 26 ข้อย่อย 1.5.3 จาก SAR หน้าที่ 39 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่ามีการวัดการบรรลุ PLOs ในแต่ละชั้นปี ด้วย PLOs เดียวกัน โดยให้นิสิตประเมินตนเอง (self-evaluation) ซึ่งอาจไม่สามารถวัดการบรรลุทุก PLOs ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งการกำหนดช่วงเวลา ในการบรรลุ PLOs ได้ในช่วงเวลาที่ผู้เรียนอยู่ในหลักสูตร ยังไม่ชัดเจน
AUN. 2 Programme Structure and Content	2.1.1 มีการแสดงข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร ใน มคอ. 2 ในเว็บไซต์คณะ และ ม.พะเยา เป็นปัจจุบัน 2.1.2 จาก SAR หน้าที่ 43 มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร ที่หลากหลายผ่าน website, Facebook ของคณะฯ และกิจกรรมแนะนำสัญจร ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย 2.1.3 จาก SAR หน้าที่ 45-46 และการสัมภาษณ์นิสิตปัจจุบัน พบว่า นิสิตได้รับทราบ CLOs จากเอกสาร มคอ. 3 จากแต่ละรายวิชา	2.1.1 จาก SAR หน้าที่ 45-46 หลักสูตรยังไม่ได้ดำเนินการประเมินการเข้าถึง จากกลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ได้จากการ ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ 2.1.2 จากตัวอย่าง มคอ. 3 ของบางรายวิชายังขาดการ updated ให้เป็นปัจจุบัน และ CLOs ยังไม่ครบถ้วน เช่น

	และนิสิตรับทราบเกี่ยวกับ มคอ. 2 2.2.1 SAR หน้าที่ 47-48 หลักสูตร มีการจัดเวทีวิพากษ์ร่างหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิ สาขา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาปรับปรุงร่างหลักสูตร 2.3.1 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร มีการนำ feedback จากผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต เรื่องการจัดลำดับรายวิชา เช่น การเรียนว่ายน้ำ และรายวิชาวิจัย มาปรับใช้ใน การเรียนการสอน 2.4.1 จากเอกสาร SAR หน้าที่ 50-51 และมคอ 2 หน้าที่ 68-72 พบว่า มีการกระจายผลลัพธ์ การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ไปยังรายวิชาต่าง ๆ และรายวิชาต่าง ๆ ช่วยผลักดันการบรรลุทุก PLOs 2.5.1 จาก SAR หน้าที่ 52-54 หลักสูตรมีการจัดลำดับและความสัมพันธ์ของ รายวิชา ในชั้นปีที่ 1-4 โดยจัดเรียงตามลำดับ องค์ความรู้และเนื้อหาที่สำคัญ ในการปูพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานและศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วค่อยเป็นการเรียน การสอนในเนื้อหาและฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพ ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และจากการสัมภาษณ์ ถามนิสิต พบว่าการจัดเรียงรายวิชามีความเหมาะสม ลำดับรายวิชาจากง่ายไปยาก 2.6.1 จาก มคอ 2 หน้า 22 ระบุว่า นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2.7.1 หลักสูตรมีการปรับปรุงตามวงรอบทุก 5 ปี	วิธีการประเมินในรายวิชายังไม่เป็นปัจจุบัน 2.2.1 จาก SAR หน้าที่ 47-48 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า กระบวนการ Backward Curriculum Design (BCD) ยังไม่ชัดเจน และที่มาของ PLOs ยังไม่ชัดเจน ทำให้ความสอดคล้อง (alignment) ไม่สอดคล้อง 2.2.2 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร พบว่า การออกแบบรายวิชา ยังเป็น subject based design ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับ outcome based education 2.3.1 SAR หน้าที่ 49 และจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สอนยังไม่พบระบบการนำ Feedback ของ SHs ภายนอก มาใช้ในการออกแบบ หลักสูตร และทำส่วนอื่น ของ มคอ.2 พึงควรจัดเก็บข้อมูลและแสดง การปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 2.4.1 มีการเชื่อมโยง เกณฑ์ TQF และ sub-PLOs หลักสูตรพึงควรพิจารณาปรับ ความรับผิดชอบ ในบางรายวิชาให้เหมาะสม ตารางจากหน้า 50-51 พบว่า มีการแสดง รายวิชาที่รับผิดชอบ PLO8 หลักสูตรพึงควรพิจารณารายวิชา ที่รับผิดชอบ และผลักดัน PLOs ทุกข้อ 2.5.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หลักสูตรอาจพิจารณาจัดทำระบบการ

		เก็บ feedback จากผู้เรียนที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากบางวิชามีความคาบเกี่ยว ระหว่าง ปี 2-3 มีเนื้อหาซ้อนทับกัน เล็กน้อย 2.6.1 จากการสัมภาษณ์นิสิต พบว่า รายวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต เป็นรายวิชา บังคับเลือกของคณะ และสามารถเลือก ได้ตามอิสระ 3 หน่วยกิตในชั้นปีที่ 3 ซึ่งนิสิตสะท้อนว่าต้องการมีรายวิชา ที่ให้เลือก มากขึ้น ตามความสนใจ ของนิสิต ทั้งวิชาของคณะและนอกคณะ หรือมีรายวิชา elective หรือกิจกรรมเพื่อเสริมประสบการณ์ 2.7.1 ข้อแนะนำเพิ่มเติม ยังไม่พบกระบวนการปรับปรุงรายวิชา ให้ทันสมัย ตามคำแนะนำจาก ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก (External SHs)
AUN. 3 Teaching and Learning Approach	3.1.1 จาก SAR หน้าที่ 1 และ 59 แสดงปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา “ประสบการณ์สร้างปัญญา” ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะจาก ประสบการณ์จริง ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณ์จริง 3.1.2 จาก SAR หน้าที่ 59-60 มีการกำหนด SHs ที่ต้องทราบปรัชญาการศึกษา และวิธีการสื่อสารปรัชญาการศึกษา ไปยัง SHs คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สื่อสารปรัชญา การศึกษาและแนวทางปฏิบัติไปยัง • ผู้เรียน ผ่านการปฐมนิเทศ เว็บไซต์คณะ และกิจกรรมพัฒนานิสิต • อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ผ่านการประชุมคณะ, การประชุมวิชาการ, และการสื่อสารทาง Group Line และระบบ E-Document • ผู้ใช้บัณฑิตและแหล่งฝึก	3.1.1 จากการสัมภาษณ์นิสิตและผู้สอน นิสิตและอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน ยังไม่ทราบ ปรัชญาการศึกษาของ มหาวิทยาลัยพะเยา และยังไม่ได้นำ ปรัชญาไปบูรณาการในรายวิชา 3.2.1 การติดตามการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการออกแบบหรือแสดง ความคิดเห็นต่อกิจกรรม การเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ จะเป็นการช่วยให้ผู้สอนและหลักสูตร จะได้มี ข้อมูลในการวางแผน เพื่อให้ผู้เรียน ได้มี ส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของ รายวิชาทั้งนี้ต้องระวังไม่ให้

	ผ่านการสัมมนาและการประชุมพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 3.2.1 จาก SAR หน้าที่ 60-62 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนิสิต พบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมกำหนดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การกำหนดประเด็นวิจัย/อภิปราย การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา กิจกรรมการเรียนรู้ 3.3.1 จาก SAR หน้าที่ 62-64 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอนพบว่ามีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในทุกรายวิชา และมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น community-based learning, problem-based learning, case study, simulation-based learning ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา 3.4.1 จาก SAR หน้าที่ 64-65 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนิสิตพบว่าหลักสูตร มีรายวิชาที่รับผิดชอบการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ชัดเจน เช่น การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน (323334) และภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (323337) กำหนดให้นิสิตค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนิสิตทุกคนต้องจัดทำโครงงานวิจัยหรือ นวัตกรรม EMS อย่างน้อย 1 ชิ้นงานในรายวิชา การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน (323334) และ ภาคนิพนธ์ (323337) โดนอาจเลือกหัวข้อที่ตอบสนองปัญหาของระบบ EMS หรือชุมชน และจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน พบว่านิสิตความกระตือรือร้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการหาข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง	กระทบต่อผล การเรียนรู้ที่หัวข้อหรือรายวิชา กำหนด 3.3.1 จาก มคอ.3 บางรายวิชา CLOs ยังไม่ชัดเจน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน active learning ในรายวิชาจึงยังไม่แสดงความสอดคล้องกับ CLOs ที่ต้องการ 3.3.2 หลักสูตรพึงควรพบทวนรูปแบบกิจกรรม การเรียนการสอนในทุกรายวิชา ในทุกหัวข้อให้สอดคล้องกับ CLOs อย่างครบถ้วน 3.4.1 หลักสูตร ยังไม่ได้กำหนดนิยาม “ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่ชัดเจน รวมทั้งวิธีการประเมินการบรรลุทักษะดังกล่าว อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 3.5.1 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวข้อความก้าวหน้าในวิชาชีพ paramedic แทรกแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ สอนในรายวิชากฎหมาย และจริยธรรม เน้นความก้าวหน้า ทางวิชาชีพและการบริหารจัดการ ในหน่วยงานการอำนวยการการแพทย์ ฉุกเฉิน แต่หลักสูตรยังไม่ได้กำหนดนิยาม “แนวคิดผู้ประกอบการ” ที่ชัดเจน หลักสูตรพึงกำหนด ทักษะที่จำเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และแนวคิดผู้ประกอบการ ผ่านรายวิชาที่รับผิดชอบ และมีการประเมินผลที่ชัดเจน สอดคล้องกับทักษะที่ตั้งไว้ 3.6.1 จากสัมภาษณ์กรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรยังไม่ได้แสดงให้เห็นความสอด

	3.5.1 จาก SAR หน้าที่ 66 หลักสูตรได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวคิด ผู้ประกอบการ ไว้ผ่าน PLO7 (สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน) และ PLO8 (แสดงภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีม และการร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพ) นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนการบูรณาการทักษะเหล่านี้ในรายวิชาหลัก เช่น การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน (323334) และ ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (323337) 3.6.1 จาก SAR หน้าที่ 67-68 หลักสูตรมีการทวนสอบรวมถึงนำผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรฯ ทุกปีการศึกษา มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน อจ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการทวนสอบ การบรรลุ CLOs, PLOs กระบวนการจัดการเรียนการสอน และนำผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า มีการอัพเดททัศถการ มีการปรับเนื้อหาการเรียนการสอนให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม ทุก 1 เดือน และกรรมการพัฒนาหลักสุตรทุก 6 เดือน และมีการนิเทศน์งาน ทุกภาคการศึกษาเพื่อรับฟังความต้องการจากแหล่งฝึกงาน	คล้องกับความต้องการของภาคการทำงาน ดังนั้นหลักสูตรพึงควรมีกระบวนการให้เก็บข้อมูลความต้องการของภาคการทำงาน และนำมาพัฒนากระบวนการเรียนการ สอนในทุกรายวิชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ CLOs และความต้องการของภาคการทำงานอย่างชัดเจน
AUN. 4 Student Assessment	4.1.1 จาก SAR หน้าที่ 71 และตัวอย่าง มคอ.3 พบว่าหลักสูตรมีการประเมินนิสิตตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลาย วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เช่น แบบประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมิน OSCE 4.2.1 จาก SAR หน้าที่ 72-73 พบว่าหลักสูตรมีระบบการวัดและประเมินผลชัดเจน และจากการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนพบว่าคณะและหลักสูตร มีระบบกลไกการอุทธรณ์ โดยหลักสูตรได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกระบวนการอุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาได้ โดยนิสิตสามารถขอดูข้อสอบหรือผลสอบโดยตรง จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา	4.1.1 จาก SAR หน้าที่ 71 และตัวอย่าง มคอ.3 พบว่าบางรายวิชายังไม่กำหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) หลักสูตรพึงพิจารณา กำหนด CLOs เพื่อนามากำหนดวิธีการวัดและประเมินผล ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับ CLOs ทุกรายวิชา 4.2.1 หลักสูตรพึงทบทวนระบบการอุทธรณ์ ให้มีการเก็บข้อมูล เช่น นิสิตสอบถามคะแนนไปที่อาจารย์ผู้สอนโดยตรง เป็นส่วนหนึ่งของระบบอุทธรณ์ และนำข้อมูลขับเคลื่อนระบบการอุทธรณ์ เพื่อให้ใช้ได้จริง

	และมีระบบอุทธรณ์คะแนนแสดงอยู่หน้าเว็บของคณะ โดยให้นิสิตกรอกแบบฟอร์ม ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากคะแนนกรอก ผ่านฝ่ายวิชาการดำเนินการ และจากการสัมภาษณ์นิสิต นิสิตรับทราบเกี่ยวกับระบบอุทธรณ์ดังกล่าว 4.3.1 จาก SAR หน้า 73-75 พบว่า มีการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียนของหลักสูตร ในแต่ละชั้นปี และเงื่อนไขการจบการศึกษาของหลักสูตร ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไว้ในมคอ. 2 และคู่มือนิสิตในแต่ละปีการศึกษา ได้แจ้งให้นิสิตทราบในวันปฐมนิเทศ และจากสัมภาษณ์นิสิต นิสิตรับทราบเกณฑ์ดังกล่าว และจากสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่ามีการจัดสอบ OSCE ทุกชั้นปี และการสอบรวบยอด (comprehensive examination) เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนิสิต 4.4.1 จาก SAR หน้าที่ 75-76 จากสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนิสิต พบว่า ทุกรายวิชาเป็นรายวิชาตัดเกรดอิงเกณฑ์ทุก รายวิชา และพบหลักฐานตัวอย่างแบบประเมิน คะแนนแบบ Rubric scoring 4.5.1 จาก SAR หน้าที่ 76-77 และจากสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่ามีการประเมินตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 1–4 ตาม Sub-PLOs (26 ด้าน) 4.6.1 จาก SAR หน้าที่ 77-78 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนให้ ประเมินผลกิจกรรมในชั้นเรียน บางรายวิชามีการใช้ Kahoot ระหว่างเรียน และให้ feedback แก่นิสิต หรือการให้ feedback หลังการสอบ OSCE และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแจ้งผลการประเมิน จุดเด่นและข้อควรปรับปรุง	4.3.1 หลักสูตร พึงทบทวนรูปการประเมิน แบบ self-assessment ในการประเมิน PLOs เพื่อกำหนดมาตรการประเมินผลที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังไม่พบการนำผลจาก การจัดสอบ OSCE ทุกชั้นปี และการสอบรวบยอด (comprehensive examination) มาเป็นเกณฑ์ในการในการสำเร็จการศึกษา 4.4.1 จาก SAR หน้าที่ 75-76 และตัวอย่าง มคอ. 3 มีการกำหนดการส่ง มคอ.3 และส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาและตรวจสอบ แต่กำหนดระยะเวลาการประเมินที่สอดคล้องกับ CLOs ยังไม่ชัดเจน ขาดการวิเคราะห์ข้อสอบหลักสูตรพึงพัฒนา แบบประเมินต่าง ๆ เพื่อการวัดผลที่ถูกต้อง (validity) ความคงเส้นคงวา (reliability) และความยุติธรรม (fairness) ในการวัดผล 4.5.1 จาก SAR หน้าที่ 76-77 ไม่พบว่ามีวิธีการอย่างไรในการประเมินการบรรลุทั้ง PLOs และ CLOs ของทุกรายวิชา และยังขาดกระบวนการ ติดตาม (เนื่องจากสอดคล้องกับ เกณฑ์ 1.5) 4.6.1 หลักสุตรพึงควรพัฒนาระบบการให้ feedback ที่เหมาะสม เช่น formative evaluation ในทุกรายวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาตนเองได้ทันเวลาก่อนสอบ (summative

	4.6.2 จากการสัมภาษณ์นิสิตปัจจุบัน พบว่านิสิตได้รับ feedback ในบางรายวิชา เช่นกายวิภาคศาสตร์ เพื่อช่วยให้นิสิตปรับปรุงการเรียนรู้ในรายวิชา และได้รับ feedback จากแหล่งฝึกเพื่อให้นิสิตปรับปรุงการทำงาน ผ่านการนิเทศน์งาน 4.7.1 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า หลักสูตรได้มีระบบการทวนสอบ และนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตเพื่อที่จะ นำมาปรับปรุงการเรียนการสอน	evaluation) ในทุกรายวิชา 4.7.1 จาก SAR หน้า 79 ไม่พบว่าหลักสูตรมีการทบทวน (Check) และปรับปรุง (Act) กระบวนการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง กับ CLOs ของทุกรายวิชา หลักสูตรพึงทบทวน (Check) และปรับปรุง (Act) กระบวนการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง กับ CLOs ของทุกรายวิชา และปรับปรุงให้ทันสมัยกับความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรม (ตลาดแรงงาน)
AUN. 5 Academic Staff	5.1.1 จาก SAR หน้า 83-86 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร พบว่าหลักสูตรมีการวางแผน บุคลากรสายวิชาการให้เพียงพอทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ และมีแผนารเปิดรับอาจารย์ วุฒิปริญญาโท 5 ตำแหน่ง และผู้ช่วยสอน 1 ตำแหน่งรองรับความต้องการของหลักสูตร และมีกระบวนการให้ทุนแก่นิสิต เพื่อเรียนต่อและกลับมาเป็นอาจารย์ 5.2.1 จาก SAR หน้า 86-89 พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 7 คน และอาจารย์ในหลักสูตร มีภาระการสอนไม่เกินเกณฑ์ 5.3.1 จาก SAR หน้า 89-90 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร พบว่า หลักสูตร และคณะ ได้กำหนดสมรรถนะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีคุณภาพ และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของหลักสูตร โดยการประเมินจะดำเนินการทั้งในด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หลังการประเมิน	5.1.1 ควรมีการจำแนกบุคลากรระหว่างหลักสูตร ในคณะ เพื่อสะท้อนความต้องการด้านบุคลากรที่แท้จริงและควรมีแผนอัตรากำลังของหลักสูตรที่ชัดเจนของหลักสูตร 5.2.1 จาก SAR หน้า 86-89 มีการแสดงข้อมูลการแสดง FTE ซึ่งมาจากระบบของมหาวิทยาลัย แต่ FTE ยังรวมระหว่างการสอน และการบริการวิชาการ อีกทั้งจำนวนอาจารย์ผู้สอนร่วมกันกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอาจพิจารณาใช้ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานที่แท้จริงของหลักสูตร และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนพบว่า ผู้ช่วยสอน Paramedic 1 ตำแหน่งในปัจจุบัน ภาระงานค่อนข้างมาก ในรายวิชาปีที่ 1-2 และอาจารย์แพทย์ในสาขา Emergency medicine มีเพียงท่านเดียวซึ่งไม่เพียงพอ

	อาจารย์แต่ละท่านรับทราบคะแนนการประเมินของตนเอง 5.4.1 จาก SAR หน้า 90-91 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน พบว่า หลักสูตรมีการกำหนดภาระงานของอาจารย์ผ่านการพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 5.5.1 จาก SAR หน้า 92-94 หลักสูตร/คณะ และมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดระบบการประเมินความดีความชอบของบุคลากร และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยใช้ระบบของมหาวิทยาลัย 5.5.2 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนพบว่า ระบบการสนับสนุน และประเมินการทำงาน การขึ้นเงินเดือนของอาจารย์มีความเหมาะสม 5.6.1 จาก SAR หน้า 94 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน พบว่ามหาวิทยาลัยและคณะได้ กำหนดสิทธิ สิทธิพิเศษ ผลประโยชน์ ที่พึงมีต่ออาจารย์ โดยสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลหรือระบบการสื่อสารของคณะ เพื่อให้ข้อมูลกระจายไปยังอาจารย์ทุกท่านอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกัน 5.7.1 จาก SAR หน้า 95-97 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร มีการพัฒนาอาจารย์ตามแผนของคณะ ในส่วนของหลักสูตรกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่านต้องเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ และบรรลุเกณฑ์ KPI ปี 2567 ของสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน การแพทย์ และมีการสำรวจความต้องการของอาจารย์เป็นรายบุคคล (ในระดับคณะ) จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอบ พบว่าในปีงบประมาณ 2567 คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ อาจารย์จำนวน	5.3.1 จาก SAR หน้า 89-90 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยังไม่พบการกำหนด สมรรถนะเฉพาะงาน สำหรับอาจารย์แต่ละคน 5.5.1 หลักสูตรหรือคณะ สามารถพัฒนาระบบที่เน้นการประเมินและให้รางวัลตามความสามารถและผลงานที่แท้จริงของบุคลากร ทั้งด้านการสอน งานวิจัย และการให้บริการวิชาการ ที่เน้นระบบคุณธรรม (merit system) 5.7.1 จาก SAR หน้า 95-97 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ยังไม่พบการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์ รายบุคคลอย่างเป็นระบบ (IDP) รวมทั้งกระบวนการกำกับดูแลตามแผนที่จัด ทำไว้ 5.8.1 ถึงแม้จะมีการมอบรางวัลแก่บุคลากร แต่การมอบรางวัลนั้นยังไม่ได้แสดงให้เห็นกระบวนการส่งเสริมหรือกระตุ้นบุคลากร ในคณะให้มีการพัฒนามากขึ้น

	50,000 บาท/ปี/คน เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง และฝ่ายบริหารของคณะ มีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน การอบรมหลักสูตร แพทยศาสตรศึกษา 100% มีการส่งเสริมการ reskill upskill และด้านอื่นๆ ส่งเสริมตามที่อาจารย์แต่ละท่านได้รับมอบหมาย เช่น การสนับสนุน UP-PSF และการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา เช่น Toolbox assessment และ Rookie's teacher 5.8.1 จาก SAR หน้า 97-98 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร พบว่าคณะ และหลักสูตรฯ ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในด้านผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในแต่ละปีการศึกษา มีงานชื่นชมยินดี เช่น ในกิจกรรมวันไหว้ครู	
AUN. 6 Student Support Services	6.1.1 จาก SAR หน้า 100-102 ในปีการศึกษา 2567 หลักสูตรได้ดำเนินการตามนโยบายการรับนิสิต และกระบวนการรับเข้าโดยมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน หลักสูตรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ Facebook , Tiktok เว็บไซต์คณะ และและจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่าหลักสูตรมีการทบทวนรูปแบบการรับเข้า เช่น การลดจำนวนรับในรอบ TCAS1 6.2.1 จาก SAR หน้า 103-104 หลักสูตร มีทางหลักสูตรมีระบบการให้คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม หลักสูตร มีกิจกรรมให้นิสิตมีบทบาทร่วมกับ คณาจารย์และบุคลากร ทั้งในและนอกสาขา เพื่อเสริมทักษะให้นิสิต 6.3.1 จาก SAR หน้า 105 หลักสูตร ได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดูแลนิสิตทุกคน	6.2.1 จาก SAR หน้า 103-104 ยังไม่พบแผนบริการนิสิตทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนิสิต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังไม่พบการดำเนินการตามแผนอย่าง เป็นระบบ 6.3.1 จาก SAR หน้า 104 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่าหลักสูตรมีระบบการตรวจสอบภาระงาน มีการดูภาระงานในภาพรวม ทุกรายวิชาเพื่อไม่ให้ภาระงานของนิสิตมากเกินไป แต่ยังไม่พบระบบการบันทึกข้อมูลที่สะท้อน ภาระงานที่แท้จริงของนิสิตอย่าง เป็นระบบ 6.4.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กิจกรรม/โครงการมีการประเมินการบรรลุ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง กิจกรรมหรือไม่

	ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาและติดตามดูแลนิสิตจน สำเร็จการศึกษา โดยอาจารย์ 1 คน จะรับผิดชอบดูแลนิสิตไม่เกิน 6 คน และกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตที่อยู่ในความดูแล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 6.3.2 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร มีระบบการตรวจสอบภาระงาน มีการดูภาระงานในภาพรวม ทุกรายวิชา เพื่อไม่ให้งาน Overloaded แต่ยังไม่เห็น action ของระบบ 6.4.1 จาก SAR หน้า 106-107 หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะที่ จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต มีกิจกรรมการแข่งขันในสมาพันธ์นิสิตฯ 6.5.1 จาก SAR หน้า 109-110 แสดงการกำหนดภาระงานและหน้าที่ที่รับ ผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน และมีการประเมินการทำงาน 6.5.2 จากการสัมภาษณ์บุคลากร สายสนับสนุนทุกคนรับทราบเกณฑ์ภาระงาน และระบบการประเมินที่เกี่ยวข้อง และมีงบประมาณ 20,000 บาท ต่อปี แก่สายสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะตนเอง 6.6.1 จาก SAR หน้า 111 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน พบว่าว่า คณะมีการจัดบริการและสนับสนุน ผู้เรียนที่หลากหลายทางด้าน งานห้องสมุด ห้องเรียน เทคโนโลยี สารเทศ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ เป็นไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งมีการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ REG ของมหาวิทยาลัย	6.5.1 ยังไม่พบข้อมูลหรือหลักฐานการประเมินการ ตอบสนองความต้องการของ SHs เพื่อพัฒนาสมรรถนะของสายสนับสนุน มีการกำหนดให้ทำ IDP 6.6.1 จาก SAR หน้า 111 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน พบว่าว่าหลักสูตรฯ ยังไม่มีการเก็บข้อมูลการประเมินผลการให้บริการและช่วยเหลือผู้เรียน และยังไม่พบคู่เทียบเคียงเพื่อพัฒนาการบริการ
AUN. 7 Facilities and	7.1.1 จาก SAR หน้า 114-115 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนิสิต และการเยี่ยมชมสถานที่ พบว่ามีทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอำนวย ความ	7.6.1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ขาดมาตรฐานสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น การออกแบบพื้นที่ที่สะดวก

Infrastructure	สะดวก ที่ใช้ในการดำเนินการหลักสูตร รวมถึงเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย 7.2.1 จาก SAR หน้า 115-116 พบว่าห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความ ทันสมัย พร้อมใช้งาน และจากการสัมภาษณ์นิสิต สะท้อนว่าเครื่องมือ และอุปกรณ์เพียงพอ พร้อมใช้ในการเรียนการสอน 7.3.1 จาก SAR หน้า 116-117 และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนิสิต พบว่าสำนักวิทยบริการของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดตั้งระบบ ห้องสมุด ดิจิทัลที่ให้บริการมีฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหนังสือจำนวนมาก และ electronic databases เช่น Up-to-date และ Access medicineและโปรแกรมต่าง ๆ เพียงพอต่อการใช้งาน 7.4.1 จาก SAR หน้า 118 และการเยี่ยมชมสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของ บุคลากร และนิสิต เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน, การบริหารจัดการ, และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมและระบบต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและ การเรียนรู้ และมหาวิทยาลัยมีระบบ UP smart บริการนิสิต 7.5.1 จาก SAR หน้า 118 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอด 24 ชั่วโมง 7.6.1 จาก SAR หน้า 119-121 และการเยี่ยมชมสถานที่พบว่า มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย	สาหรับการใช้วีลแชร์ และการออกแบบทางเดินที่เหมาะสมสำหรับผู้พิการทางสายตา 7.8.1 จากการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน ยังไม่พบการกำหนดสมรรถนะรายบุคคล (IDP) ที่ชัดเจน และยังการประเมินการตอบสนองความ ต้องการของ SHs และความต้องการของ หลักสูตร เพื่อกำหนดสมรรถนะของสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการ 7.9.1 จาก การสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน พบการประเมินความพึงพอใจ ของสิ่งสนับสนุน แต่ยังไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลการประเมิน ผลอย่างเป็นระบบ และยังไม่ ครบถ้วน ในทุกฝ่าย เช่น ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ จึงเห็นควรให้หลักสูตรออกแบบระบบการประเมินผลปรับปรุงสิ่งสนับสนุนให้เป็นระบบเพื่อสามารถนำมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนและการให้บริการได้

	มีการใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม Green University ที่ครอบคลุมการจัดการขยะ น้ำ และพลังงาน และทางคณะได้จัดให้มี ห้องออกกำลังกายสำหรับบุคลากร และมีสนามสำหรับออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 7.7.1 จาก SAR หน้า 121 มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งในด้านกายภาพ สังคม และจิตวิทยา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย และความเป็นอยู่ที่ดีของนิสิตและบุคลากร โดยมีพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต เช่น หอพัก รถขนส่งภายในมหาวิทยาลัย, ร้านค้า ร้านอาหาร สนามกีฬา ระบบการให้คำปรึกษาทางจิตใจ 7.8.1 จาก SAR หน้า 122 คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดภาระงานของ บุคลากรสายสนับสนุนไว้ และมีการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตาม ตามระบบของมหาวิทยาลัย 7.8.2 จากการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน ทุกคนทราบภาระงานและหน้าที่ความ รับผิดชอบของตนเองสมรรถนะของบุคลากร สายสนับสนุน 7.9.1 จาก SAR หน้า 122-123 คณะได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ นิสิตต่อการให้บริการของผ่านระบบ REG ของมหาวิทยาลัยหลังจากการเรียนการสอน เสร็จสิ้น	
AUN. 8 Output and Outcomes	8.1.1 จาก SAR หน้า 126-127 แสดงการข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา อัตราการลาออกกลางคัน และระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ย และมีการแสดงคู่เทียบ 8.1.2 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ พบว่า หลักสูตรมีการดำเนินการ ช่วยเหลือและกระตุ้นนิสิตให้จบตามระยะเวลา ของหลักสูตร	8.1.1 จาก SAR หน้า 126-127 มีการแสดงการข้อมูลร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา อัตราการลาออกกลางคัน และระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ย พร้อมคู่เทียบ แต่ยังขาดการวิเคราะห์เพื่อนำไปพัฒนาผลลัพธ์ ของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น และอาจพิจารณาเลือกคู่เทียบ

	8.2.1 จาก SAR หน้า 127 บัณฑิตมีอัตราการได้งานทำ 100% และมีคู่เทียบที่ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน 8.3.1 จาก SAR หน้า 128-129 มีการแสดงข้อมูลงานวิจัย/งานตีพิมพ์ของอาจารย์ในหลักสูตร พร้อมคู่เทียบ 8.4.1 จาก SAR หน้า 130-132 แสดงตารางประเมิน PLOs และ sub-PLOs ซึ่งนิสิตประเมินตนเอง 8.5.1 จาก SAR หน้า 132-133 หลักสูตรคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตาม PLOs ทั้ง 8 ข้อ นอกจากนี้ยังมีการสอบถามข้อมูลจากครู พี่เลี้ยง แหล่งฝึกงาน และมีระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของมหาวิทยาลัย	ที่มีผลลัพธ์ที่สูงกว่า เพื่อความท้าทายในการพัฒนา หลักสูตร 8.2.1 เนื่องจากอัตราการมีงานทำของบัณฑิต ในหลักสูตรค่อนข้างสูง หลักสูตรอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดอื่นที่สามารถสะท้อนศักยภาพในการทำงานจริง และอาจพิจารณาคู่เทียบที่มีผลลัพธ์สูงกว่าเพื่อโอกาสในการพัฒนา 8.3.1 จาก SAR หน้า 128-129 ยังไม่มีการนำข้อมูลวิเคราะห์เทียบเคียงกับคู่เทียบเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ส่งเสริมงาน วิจัย/ผลงานตีพิมพ์ รวมทั้งหลักสูตรอาจพิจารณานำข้อมูลงานวิจัย และนิสิตมาวิเคราะห์และอาจพิจารณาคู่เทียบที่มีผลลัพธ์สูงกว่าเพื่อ โอกาสในการพัฒนา 8.4.1 จาก SAR หน้า 130-132 ไม่พบว่าหลักสูตรมีการวัดการบรรลุ PLOs นอกเหนือจากนิสิตประเมินตนเอง หลักสูตรพึงพิจารณาทบทวนข้อมูล ที่แสดงถึงการบรรลุ PLOs ของหลักสูตร พิจารณาการกำหนดวิธีและเครื่องมือ ในการประเมินการบรรลุ PLOs (สอดคล้องกับเกณฑ์ 1.5 และ R4.1 ของทุกรายวิชา) และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา หลักสูตร 8.5.1 หลักสูตรพึงพิจารณาติดตามข้อมูล ความพึงพอใจ จากกลุ่ม SHs ที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง และควรพิจารณาการเลือกคู่เทียบเพื่อเรียนรู้การดำเนินงานและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของหลักสูตร

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

รายการหลักฐาน (QR CODE เอกสารหลักฐาน 1-8)



หลักฐาน AUN-QA 1



หลักฐาน AUN-QA 2



หลักฐาน AUN-QA 3



หลักฐาน AUN-QA 4



หลักฐาน AUN-QA 5



หลักฐาน AUN-QA 6



หลักฐาน AUN-QA 7



หลักฐาน AUN-QA 8